30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: MARCO AURELIO DE SOUZA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: LUIZ HENRIQUE PRESCENDO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADV.(A/S)	: JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

EMENTA: DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS.

1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem.

2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14486972.

instituiu.

3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina.

4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público.

5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária.

6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos, acordam em julgar improcedente a ação, vencidos parcialmente os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Rosa Weber. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski, e, neste julgamento, os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Falaram, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União, e, pelo *amicus curiae* Conselho Federal de Medicina, o Dr. José Alejandro Bullón.

Brasília, 30 de novembro de 2017.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14486972.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator para acórdão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14486972.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: MARCO AURELIO DE SOUZA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: LUIZ HENRIQUE PRESCENDO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADV.(A/S)	: JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O assessor Dr. Marcelo Novelino Camargo prestou as seguintes informações:

> A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU busca a declaração de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos artigos 3º a 14 da Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, que instituiu o denominado Programa Mais Médicos.
>
> Eis o teor dos dispositivos impugnados:
>
> [...]
>
> Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de medicina, ouvido o Ministério da Saúde;

II - procedimentos para celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliativos necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do *caput*, deverá ser considerada, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do *caput*, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer, para a instituição de educação superior vencedora do chamamento público, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

graduação em medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do *caput* observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos, exigirá garantia de proposta do participante, e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto respectivamente no art. 56 e no inciso II do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Medida Provisória.

Art. 4º Para os ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1º de janeiro de 2015, a formação do médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares entre si, correspondendo:

I - o primeiro ciclo, à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da carga horária não inferior a sete mil e duzentas horas; e

II - o segundo ciclo, a treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Educação - CNE, homologada pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 1º O segundo ciclo não dispensa o estudante de medicina do estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço supervisionado, em regime de internato, desenvolvido durante o primeiro ciclo do curso e disciplinado em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º Sem prejuízo da necessária supervisão acadêmica a cargo da instituição de educação superior à qual o estudante de medicina esteja vinculado, o segundo ciclo será realizado sob supervisão técnica de médicos, detentores de título de pós-graduação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

§ 3º Durante a realização do segundo ciclo, é assegurada aos estudantes de medicina a percepção de bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, em valor estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde.

Art. 5º Ao estudante de medicina aprovado no primeiro ciclo, conforme certificado expedido pela correspondente instituição de educação superior, será concedida permissão para o exercício profissional da medicina, válida exclusivamente para as atividades do segundo ciclo de formação.

§ 1º A inscrição no segundo ciclo de formação é condição necessária e suficiente para expedição da permissão de exercício profissional de que trata o *caput* pelos Conselhos Regionais de Medicina.

§ 2º O segundo ciclo de formação é considerado componente curricular obrigatório do curso de graduação em medicina e será inscrito no histórico escolar do estudante.

§ 3º O diploma de médico somente será conferido ao estudante de medicina aprovado no segundo ciclo de formação.

§ 4º O segundo ciclo de formação poderá ser aproveitado como uma etapa dos programas de residência médica ou de outro curso de pós-graduação, nos termos definidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde, ouvida a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.

Art. 6º As instituições de ensino superior promoverão a adequação da matriz curricular dos cursos de medicina para atendimento ao disposto nesta Medida Provisória, nos prazos e na forma definida pelo CNE, em parecer homologado pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória, para submeter o parecer referido no *caput* ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Ministro de Estado da Educação.

Art. 7º Fica instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observará a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante - médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista - médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamentos e os recessos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Art. 8º O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o *caput* terá prazo de até três anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à aprovação nas avaliações periódicas.

Art. 9º Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimentos de língua portuguesa.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 10. O médico intercambista exercerá a medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Fica vedado ao médico intercambista o exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

§ 2º Para exercício da medicina pelo médico intercambista no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil será expedido registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina.

§ 3º A declaração de participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, fornecida pela coordenação do programa, é condição necessária e suficiente para a expedição de registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina, não sendo aplicável o art. 99 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 4º O registro provisório será expedido pelo Conselho Regional de Medicina no prazo de quinze dias, contado da apresentação do requerimento pela coordenação do programa de aperfeiçoamento, e terá validade restrita à permanência do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do regulamento.

§ 5º O médico intercambista registrado provisoriamente estará sujeito à fiscalização e ao pagamento das anuidades estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito, conforme legislação aplicável aos médicos inscritos em definitivo.

§ 6º O médico intercambista não participará das eleições do Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Art. 11. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 12. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de três anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 8º, mediante declaração da coordenação do projeto.

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o *caput* aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei nº 6.815, de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 13. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no *caput*, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de três bolsas-formação.

§ 2º Fica a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

> Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.
>
> § 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.
>
> Art. 14. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na condição de contribuinte individual, na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
>
> Parágrafo único. Ficam ressalvados da obrigatoriedade de que trata o *caput* os médicos intercambistas:
>
> I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou
>
> II - filiados a regime de seguridade social no seu país de origem, que mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.
>
> [...]

A requerente assevera ter legitimidade para a propositura da ação por ser confederação sindical regularmente inscrita no Ministério do Trabalho. Sob a óptica da pertinência temática, aduz haver nexo entre as próprias finalidades institucionais e o conteúdo das normas impugnadas, as quais afetam diretamente o interesse da categoria de médicos.

No mérito, alega a impropriedade da veiculação da matéria por medida provisória, seja por inexistir urgência a justificar a edição, seja por tratar de cidadania, tema expressamente vedado pelo texto constitucional. Articula com a mitigação do princípio do concurso público, ante a ausência de processo seletivo para a admissão de profissionais no âmbito do programa. Aponta a precarização nas relações de trabalho pelo afastamento de vínculo empregatício de qualquer natureza, bem como pela forma de contratação e pagamento dos médicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

cubanos. Diz da violação aos valores sociais do trabalho em razão da imposição de segundo ciclo de treinamento em serviço, com duração mínima de dois anos, para a formação de médicos, por caracterizar espécie de "serviço civil obrigatório". Argui a incompatibilidade da autorização para o exercício da medicina antes do cumprimento dos dois ciclos de formação e da dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas com o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 208 da Constituição Federal. Alude à imprescindibilidade de proficiência na língua portuguesa para a adequada prestação de atendimento médico, sendo insuficiente a exigência de mero conhecimento do idioma. Assinala o desrespeito à regra da reciprocidade, considerada a diferença de tratamento conferido aos brasileiros residentes no exterior. Enfatiza a ausência de isonomia em decorrência de os pacientes serem atendidos, em determinadas regiões, por médicos devidamente capacitados e, em outras, por profissionais ainda em formação ou com diploma não revalidado. Frisa violar o princípio da autonomia universitária, porquanto afeta diretamente o funcionamento de tais instituições, a criação de regras modificativas do plano de formação a ser observado nos cursos de medicina.

Sob o ângulo do risco, menciona a possibilidade de exercício profissional por médicos estrangeiros inscritos como intercambistas sem a necessária revalidação do diploma. Buscara o deferimento de liminar para suspender os efeitos da medida provisória até a apreciação pelo Congresso Nacional. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Ante a parcial coincidência de objetos, Vossa Excelência determinou o apensamento a este processo, com impugnação mais ampla, do revelador da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, para julgamento conjunto.

Nesta última, as requerentes pedem a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, 7º, incisos I e II e parágrafos 1º e 2º, incisos I e II, 9º, incisos I e II e § 1º, 10, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e 11 da Medida Provisória nº 621/2013.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Em preliminar, a Associação Médica Brasileira – AMBR realça a própria legitimidade ativa, por ser entidade de classe de âmbito nacional voltada à defesa da dignidade profissional dos médicos e à assistência de qualidade à saúde da população. Daí a pertinência temática. O Conselho Federal de Medicina – CFM pleiteia ser admitido como parte legítima ou como terceiro interessado, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. No mérito, ambos alegam a impropriedade de veiculação do tema por medida provisória, seja por não ter sido verificada a urgência constitucionalmente exigida, seja pela impossibilidade de tal ato normativo regulamentar matérias atinentes a orçamento ou reservadas a lei complementar. Sob a óptica material, apontam contrariar os princípios da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade humana, da segurança e da proteção à saúde a autorização, para o exercício da medicina, a profissionais estrangeiros e brasileiros formados no exterior, sem a devida revalidação do diploma. Dizem transgredir o princípio da isonomia o tratamento diferenciado conferido a esses médicos, assim como aos pacientes por eles atendidos. Sustentam que o programa autoriza o exercício ilegal da medicina ao permitir a atuação de profissionais da área sem o prévio registro nos Conselhos Regionais. Argumentam, considerada a inobservância de normas protetivas das relações laborais, estar configurada "verdadeira escravidão disfarçada de intercâmbio", a violar tratados internacionais de direitos humanos e direitos sociais do trabalho. Sublinham o desrespeito ao princípio da autonomia universitária. Aduzem ser incompatível com o princípio da legalidade a inexistência de critérios objetivos para a análise do conhecimento da língua portuguesa, de modo a viabilizar a prática da medicina por estrangeiros sem a adequada proficiência. Ressaltam a ingerência estatal indevida na autonomia dos Conselhos de Medicina, compelidos a expedir registros provisórios aos profissionais participantes do programa. Arguem afronta às exigências de concurso público e de processo licitatório pelas normas autorizativas da contratação de médicos para o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

programa, ante a não imposição de realização de processo seletivo.

Sob o ângulo do risco, destacam os perigos à segurança e à saúde da população decorrentes do exercício da medicina por indivíduos sem as necessárias qualificações técnicas. Postularam o implemento de liminar para suspender as normas impugnadas. No mérito, pretendem a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos atacados.

Vossa Excelência, em 31 de agosto de 2013, nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou informações.

A Câmara dos Deputados limita-se a enfatizar a estrita observância, no âmbito do Congresso Nacional, dos preceitos constitucionais e regimentais relativos ao processo legislativo.

A Presidente da República, após breve descrição do Programa Mais Médicos, suscita, em preliminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF, a ilegitimidade ativa da requerente, uma vez não comprovada a pertinência temática. No mérito, em ambas as ações, afirma presentes a relevância e a urgência a justificarem ser a matéria versada em medida provisória, alegando não haver erro grosseiro ou atributo inadequado a configurar "evidente abuso de discricionariedade" sujeito ao controle judicial. Sob a óptica material, sustenta a impossibilidade de enquadrar-se a concessão de visto temporário aos médicos intercambistas estrangeiros como matéria referente à cidadania, conceito relacionado aos brasileiros natos e naturalizados. Esclarece tratar-se de programa de capacitação, inexistente relação de emprego a respaldar a incidência de normas trabalhistas. Diz da inadequação de interpretar-se o treinamento em serviço, mudança de paradigma pedagógico voltada a priorizar a atuação preventiva na atenção básica, como imposição de trabalho obrigatório aos estudantes de medicina. Defende ser descabido falar em exercício ilegal do ofício, considerada a dispensa de revalidação dos diplomas, por existirem mecanismos de avaliação utilizados para aferir a qualificação profissional e, inclusive, o conhecimento da língua portuguesa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Ressalta a ausência de obrigatoriedade de revalidação do diploma para todos que não se sujeitam a condições de reciprocidade. Argumenta não ter sido apontado qualquer dispositivo a criar diferenciação entre pacientes das distintas regiões do País, sendo as preferências por certos locais decorrentes de opção dos próprios médicos. No tocante à autonomia universitária, aduz a hierarquia legal dos preceitos supostamente violados, passíveis de revogação por medida provisória. Alfim, anexa pareceres das consultorias jurídicas junto aos Ministérios da Educação e da Saúde, nos quais analisada a constitucionalidade do Projeto Mais Médicos para o Brasil, bem como o relatório de estatísticas sanitárias mundiais, elaborado pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

O Senado Federal, em preliminar, sustenta a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, por falta de pertinência temática. No mérito, alega caber apenas aos Poderes Executivo e Legislativo a análise da presença dos pressupostos para edição de medidas provisórias, salvo em situação de abuso, não demonstrada no caso. Assinala a ausência dos requisitos autorizadores para o implemento da medida liminar.

O Advogado-Geral da União, após tecer considerações acerca do Programa Mais Médicos, destaca haver relevância e urgência para a edição da medida provisória, sublinhando ser a aferição de tais condições pelo Poder Judiciário providência de caráter excepcional. Menciona a imprescindibilidade de recrutamento de médicos estrangeiros devido à insuficiência de profissionais no mercado de trabalho brasileiro e à má distribuição territorial. Realça ser desnecessária a imposição de revalidação do diploma obtido no exterior, ante a exigência de conhecimento de língua portuguesa, a avaliação por instituições de ensino e a restrição do exercício das atividades ao âmbito do projeto, sob contínuo monitoramento de instituição acadêmica supervisora. Quanto à inclusão do segundo ciclo de formação profissional, elucida consistir em treinamento com enfoque na atenção básica à saúde, podendo ser aproveitado como etapa da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

residência ou pós-graduação. Frisa contribuir para o aprimoramento da formação médica no Brasil. Na manifestação formalizada na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, além dos citados argumentos, aponta irregularidade na representação da Associação Médica Brasileira, por não constar a especificação dos dispositivos impugnados, requisito indispensável para o reconhecimento da capacidade postulatória da requerente. Argui a ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina, em virtude de ser conselho corporativista não previsto no rol de legitimados do artigo 103 da Lei Maior.

Em 6 de novembro de 2013, Vossa Excelência acionou o § 1º do artigo 9º da Lei nº 9.868/1999, visando obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre a matéria, sobretudo por revelar processo objetivo, no qual ausentes interesses individualizados. Assegurou-se a participação de entidades, autoridades e profissionais, cujos pedidos foram recebidos por correio eletrônico. As sessões ocorreram em 25 e 26 de novembro de 2013.

Na abertura, o então advogado-geral da União, Luís Inácio Lucena Adams, discorreu sobre o Sistema Único de Saúde – SUS e o Programa Mais Médicos, reafirmando os termos anteriormente expostos.

Após, Roberto Luiz D`Ávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, manifestando-se de forma contrária ao programa, destacou a ofensa ao princípio da isonomia, em razão da dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas e da diferenciação quanto ao tratamento dado aos pacientes mais carentes, usuários do serviço de saúde pública, e daquele conferido aos dotados de recursos para arcar com despesas médico-hospitalares.

A seguir, Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde, ressaltou a importância do programa, voltado à atenção básica, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Elucidou o liame entre a reformulação dos cursos de medicina e a abertura à participação de médicos estrangeiros. Apontou, como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

justificativa para a dispensa de revalidação do diploma, a necessidade de restringir a atuação dos médicos intercambistas, impedindo-os de atuar em outras áreas.

Na sequência, Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente da Associação Médico-Oncologista, salientou os problemas resultantes da falta de investimento e de gestão qualificada na saúde. Questionou aspectos estruturais do Programa Mais Médicos, suscitando incoerências e contradições nas medidas implementadas.

Na continuação dos trabalhos, José Luiz Bonamigo Filho, diretor da Associação Médica Brasileira, realçou a importância da aplicação do Revalida, avaliação instituída pelo governo para validar diplomas obtidos no exterior. Disse do elevado índice de reprovação no exame e alertou para os riscos do desconhecimento do nível de qualificação dos profissionais estrangeiros.

Em seguida, Paulo Speller, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, frisou os objetivos do programa, sobretudo no tocante à integração ensino-serviço. Apontou a baixa média brasileira de médicos por habitantes e a desigualdade na distribuição desses profissionais nas regiões do País, acentuando a premência de expansão do número de vagas nos cursos de medicina. Reportou-se à instituição de medidas voltadas a reduzir, de forma gradativa, a necessidade de médicos intercambistas.

Dando continuidade à audiência, Sebastião Vieira Caixeta, procurador do Ministério Público do Trabalho, informou a instauração de inquérito civil para apurar denúncia acerca de problemas e irregularidades envolvendo o programa. Discorreu sobre o possível desvirtuamento da relação de trabalho travestida de curso de especialização; a contratação de médicos sem qualquer tipo de procedimento seletivo; a dispensa da revalidação do diploma para participantes do programa; e, em especial, o tratamento diferenciado conferido aos médicos cubanos.

Reiniciando-se os trabalhos na parte da tarde, Vagner

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Freitas de Moraes, presidente da Central Única dos Trabalhadores, destacou o apoio da direção executiva da entidade ao programa. Embora tenha reconhecido a necessidade de aprimoramento das condições de trabalho para o adequado exercício da profissão, apontou a falta de médicos para o atendimento da população menos abastada como um dos principais problemas na área da saúde.

Foi ouvido, a seguir, Ruy Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho. Referiu-se ao acordo judicial firmado em ação civil pública no qual a União se obriga a não mais terceirizar atividades-fim. Disse da inobservância do dever de tratamento isonômico entre trabalhadores vinculados direta ou indiretamente à Administração Pública.

Na sequência, José Alberto Reus Fortunati, prefeito de Porto Alegre/RS e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, relatou a dificuldade na contratação de recursos humanos pelos Municípios, em especial de médicos. Salientou a importância do Sistema Único de Saúde e do Programa Mais Médicos para o atendimento à população carente, ressaltando a primordialidade de aperfeiçoamento do atual sistema.

Na continuação dos trabalhos, Fernando Casquel Monti, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realçou o problema da falta de médicos no âmbito municipal. Enfatizou a dificuldade no preenchimento das vagas por concurso público. Reiterou os pontos positivos do programa.

A promotora de justiça do Ministério Público do Tocantins e primeira vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde – AMPASA, Maria Rosely de Almeida Pery, após reconhecer que deveria haver melhorias estruturais das carreiras na área da saúde, apontou a indispensabilidade de resposta urgente, como a efetivada pelo programa, para o atendimento das necessidades básicas da população menos favorecida.

Após breve intervalo, ouviu-se o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Mozart Túlio Tabosa Sales frisou a diferença entre o amplo exercício da profissão, garantido pela revalidação dos diplomas, e o programa destinado à atenção básica, em que os médicos são constantemente avaliados pelas universidades públicas federais. Destacou ser necessário restringir a atuação dos profissionais intercambistas.

Na sequência, Marcelo André Barboza da Rocha Chaves, titular da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, abordou os objetivos do programa, assim como o objeto de análise e a atuação do Órgão de contas federal em relação ao tema. Em especial, realçou os problemas envolvendo o pagamento dos médicos cubanos.

O deputado federal Henrique Mandetta assinalou a impossibilidade de acesso ao conteúdo do convênio celebrado pelo governo brasileiro com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS e com Cuba, cujos termos não foram objeto de análise pelo Congresso Nacional, por terem sido divulgados apenas após o período de deliberação das emendas parlamentares.

Na continuação dos trabalhos, o também deputado federal Ronaldo Caiado ressaltou as obscuridades e a falta de debates parlamentares acerca do teor do referido convênio, a despeito dos requerimentos feitos ao Ministério das Relações Exteriores. Asseverou a falta de equidade no tratamento conferido aos médicos intercambistas cubanos e aos europeus.

Por último, o médico William José Bicalho Hastenreiter Paulo, participante do Programa Mais Médicos, relatou que, embora tratado como estudante bolsista, nunca recebeu o devido acompanhamento de tutor. Afirma submeter-se a rotina normal de trabalho, mas sem a garantia de direitos trabalhistas.

O segundo dia de audiências públicas foi aberto por Geraldo Ferreira Filho. O presidente da Federação Nacional dos Médicos e dos Sindicatos dos Médicos do Rio Grande do Norte sublinhou a precarização das relações trabalhistas no âmbito do programa, em desarmonia com a Constituição, a Consolidação das Leis do Trabalho e os tratados internacionais sobre o tema.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Disse ter natureza trabalhista o vínculo entre os médicos participantes do programa e o Estado brasileiro, embora disfarçado de ensino.

Em seguida, a presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, Jadete Barbosa Lampert, fez ponderação entre os avanços quantitativos e os riscos qualitativos da assistência médica ofertada pelo programa. Salientou a relevância do estímulo à capacitação profissional para o fomento da qualidade dos serviços assistenciais e de saúde.

No final da manhã, Lúcia Nader, diretora da Conectas Direitos Humanos, após breve análise do contexto global envolvendo os direitos humanos, referiu-se ao direito à saúde, à migração e aos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Articulou com a impossibilidade de questões burocráticas, como o acesso a cargos públicos e a exigência de revalidação de diplomas, servirem de óbice ao direito migratório. Alertou para a insuficiência do programa diante dos obstáculos existentes. Defendeu a necessidade de soluções estruturais e duradouras.

Na reabertura dos trabalhos, Vasco Vasconcelos, representante da Associação Ordem dos Bacharéis do Brasil, arguiu a imprescindibilidade da contratação de médicos brasileiros e estrangeiros, devido à falta de profissionais nas regiões mais carentes do País. Alegou inexistir violação a normas constitucionais, morais ou éticas pela legislação instituidora do programa.

O ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Marcelo Côrtes Néri, apresentou pesquisas indicando a saúde como prioridade para a população brasileira e a carência de médicos como o principal problema, sobretudo nas localidades menos abastadas do Brasil. Discorreu sobre o baixo crescimento do número de vagas em medicina na comparação com outros cursos. Acentuou a importância da manutenção do programa para fomentar a acessibilidade da assistência à população menos favorecida. O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

coordenador da área de saúde do referido instituto, Matheus Stivali, abordou os impactos sistêmicos do programa e a estrutura da Federação brasileira, segundo a qual cabe aos Municípios a atenção básica à saúde. Destacou a heterogeneidade municipal entre as causas das destoantes realidades. Mencionou a competência atribuída à União no âmbito do Programa Mais Médicos. Expôs a urgência da atuação em frentes de curto e longo prazo, referentes, respectivamente, à recepção dos médicos intercambistas e à modificação do currículo dos cursos de medicina.

Finalizando a audiência pública, Juracy Barbosa Júnior, representante da Associação Nacional dos Médicos Residentes, reportou-se à necessidade de adequada avaliação dos profissionais estrangeiros. Apontou a qualidade dos serviços prestados, e não a quantidade de médicos, como o principal problema da saúde no Brasil.

O Procurador-Geral da República, em preliminar, suscita a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, por ausente a pertinência temática. Argumenta que o fato de congregar todos os profissionais liberais com nível superior reconhecido confere à requerente legitimidade ativa quase universal. Assinala a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, por falta de aditamento da inicial, considerada a conversão da medida provisória impugnada em lei. Alude à irregularidade na representação processual da Associação Médica Brasileira – AMBR, ante a ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação. Aponta a ilegitimidade do Conselho Federal de Medicina – CFM, por se tratar de autarquia corporativista. Em ambas as ações, após traçar breve histórico do Programa Mais Médicos, delimita o objeto da ação à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Medida Provisória nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013. Diz excluídas do âmbito do julgamento questões individuais e as atinentes à execução financeira do projeto, entre elas o convênio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

celebrado com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS. No mérito, articula com a impropriedade da alegação de falta de urgência para tratar de alteração curricular prevista no artigo 4º da Medida Provisória nº 621/2013, ante a mudança promovida pela lei de conversão. Sustenta incabível o exame judicial dos requisitos de relevância e urgência, uma vez não verificado manifesto abuso do Poder Executivo. Ressalta não ter o ato normativo impugnado tratado de cidadania nem de qualquer outra matéria vedada pelo § 1º do artigo 62 da Constituição da República. Pondera acerca da inviabilidade de reconhecimento de vínculo empregatício aos médicos intercambistas, considerada a proibição constitucional de contratação direta pelo regime celetista. Salienta tratar-se de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Carta Federal, regulamentado pela Lei nº 8.745/1993. Assevera a perda do objeto no tocante à instituição do segundo ciclo no curso de graduação em medicina e ao exercício da profissão por estudante nele matriculado, tendo em vista a retirada do preceito atacado da lei de conversão. Realça a possibilidade de a liberdade profissional ser condicionada às qualificações estabelecidas por lei. Quanto à revalidação do diploma, frisa tratar-se de matéria legal, passível de ser excepcionada por norma de mesma hierarquia. Aduz dispensável a revalidação para os médicos participantes do programa em virtude de estarem submetidos a regime jurídico específico, por prazo determinado e sob a fiscalização do respectivo Conselho Regional de Medicina. Observa inexistir ofensa ao artigo 13 do Diploma Maior, considerada a exigência de domínio da língua portuguesa pelos médicos participantes do programa, cujo primeiro módulo é voltado ao aperfeiçoamento do estudo do idioma. Esclarece que o artigo 112, inciso IV, do Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 6.815/1980 – em momento algum exige proficiência do naturalizado, mas apenas saber "ler e escrever a língua portuguesa". Sublinha ser a reciprocidade, prevista no artigo 12, § 1º, da Constituição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

Federal, aplicável apenas aos portugueses, inexigível em relação aos direitos assegurados no âmbito do programa no qual implementada política pública voltada ao atendimento das necessidades da população brasileira. Diz ser desprovido de fundamentação lógica o argumento de violação à isonomia entre os pacientes das diferentes regiões do País, considerado o reconhecimento constitucional da existência de desigualdades regionais, inclusive no âmbito da saúde, a justificar tratamentos diferenciados. Enfatiza que a autonomia universitária não impede a União de criar ato normativo instituindo diretrizes curriculares específicas para o curso de medicina, delegando competências gerenciais ao Ministro da Educação ou determinando a adequação das instituições de ensino superior. Na conclusão, opina pelo não conhecimento da ação ou, caso conhecida, pela total improcedência do pedido. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, manifesta-se pela intimação da Associação Médica Brasileira – AMB para regularizar a petição inicial e a respectiva documentação anexada e, no mérito, pela improcedência total do pleito.

Vossa Excelência deferiu a intervenção da Associação Médica Nacional Dra. Maíra Fachini – AMN-MF como terceira interessada. O mesmo ocorreu em relação ao Conselho Federal de Medicina – CFM, excluído do polo ativo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF, por ausência de legitimidade. Foram indeferidos os pedidos de ingresso da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social e da Federação Nacional dos Médicos.

Devido à conversão da medida provisória, houve aditamento para requerer-se o prosseguimento das ações no tocante à Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Os termos de ambas as iniciais foram integralmente ratificados, alegando-se a inexistência de alteração substancial das normas atacadas.

Os dispositivos correspondentes aos expressamente impugnados passaram a ter a seguinte redação:

Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de Medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

superior vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Lei.

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que:

I - possuam certificação como hospitais de ensino;

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus serviços.

§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde.

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I - os seguintes critérios de qualidade:

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas;

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:

a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na região;

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza.

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo constitui ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

[...]

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da matriz curricular para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao Ministro de Estado da Educação.

[...]

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

à sua aprovação nas avaliações periódicas.

§ 3º O primeiro módulo, designado acolhimento, terá duração de 4 (quatro) semanas, será executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da Atenção Básica em saúde, aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde, à língua portuguesa e ao código de ética médica.

§ 4º As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e compreenderão o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o médico participante está apto ou não a continuar no Projeto.

§ 5º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas avaliações de que tratam os §§ 1º a 4º, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a programação em módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 3º A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, para todos os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão médica e à tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Vide Decreto nº 8.126, de 2013)

§ 1º (VETADO).

§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.

§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de registro único.

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto.

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o *caput* aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os médicos intercambistas:

I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou

II - filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.

[...]

A Associação Médica Brasileira juntou, ainda, nova procuração com poderes específicos para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.035/DF.

O Conselho Federal de Medicina, a fim de comprovar as irregularidades suscitadas, promoveu a juntada de relatório do Tribunal de Contas da União referente ao Programa Mais Médicos e de Projeto de Decreto Legislativo voltado à sustação do "Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto 'ampliação do acesso da população brasileira à atenção básica em saúde', celebrado entre o Ministério da Saúde/Fundo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

> Nacional de Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde". Mencionou o endereço eletrônico para acesso a reportagens sobre o tema transmitidas pela Rede Bandeirantes de Televisão.
>
> Em 25 de fevereiro de 2016, Vossa Excelência indeferiu o pleito de extinção da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF formulado pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, ante a falta de admissibilidade do ingresso da postulante como terceira.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185531.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – As ações diretas versam sobre normas instituidoras do Programa Mais Médicos, criado com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde – SUS. Entre as medidas a serem adotadas para a consecução dos objetivos visados pelo programa estão a reordenação da oferta dos cursos de medicina e de vagas para a residência médica, o estabelecimento de novos parâmetros para a formação de médicos e o incentivo ao aperfeiçoamento desses profissionais na área de atenção básica em saúde – artigos 1º e 2º da Lei nº 12.871/2013.

Cumpre, inicialmente, delimitar o objeto desta análise, ante o pedido abrangente formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF, no sentido de ser "reconhecida a desconformidade dos comandos oriundos da Medida Provisória n° 621/2013, que trata de Programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, com a Ordem Constitucional vigente, em especial de seus artigos 3° a 8°, 9°, 10°, 11°, 13° e 14° [...]".

No controle concentrado, embora a causa de pedir seja aberta, a atuação do Tribunal deve ficar adstrita aos limites do pedido. Excetuadas as hipóteses de interdependência com os dispositivos atacados ou de inconstitucionalidade consequente, descabe proclamar, de ofício, a nulidade de normas não impugnadas de maneira específica pelo requerente. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.895/AL, relator ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno; e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.645/PR, relatora ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno.

No tocante à relação entre as ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.035 e nº 5.037, verifico a identidade quase total entre os pleitos veiculados nas respectivas petições iniciais. A distinção reside na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

amplitude do objeto dos processos. A autora da ação direta nº 5.037 busca a declaração de inconstitucionalidade de mais preceitos da norma atacada, em comparação ao postulado na ação direta nº 5.035. Sob esse ângulo, o exame do versado na ação nº 5.037 necessariamente resultará na apreciação dos requerimentos da de nº 5.035, razão pela qual procedo ao julgamento conjunto dos processos.

I) DAS PRELIMINARES

I.1) DA REGULARIDADE DO MANDATO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

Quanto ao argumento do Ministério Público de irregularidade da representação processual da Associação Médica Brasileira, observo que a autora juntou, após a formalização desta ação direta, procuração especificamente direcionada à atuação neste processo. Embora não explicitados, no instrumento, os dispositivos impugnados, a superveniente regularização da representação processual acaba por superar o vício. É que não não cabe exarcerbar a forma. Quando o legislador entendeu necessário o fez, como é exemplo a disciplina da matéria na queixa-crime ligada à honra. Afasto a preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República.

I.2) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

O Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República arguiram a ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina, considerada a natureza de conselho corporativista, não inserido no rol de legitimados a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Em 5 de abril de 2016, determinei a exclusão da autarquia do polo ativo da ação direta nº 5.037, por não se enquadrar nos requisitos do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal. Assentei adequada a admissão na condição de terceiro, no que ficou esvaziada a preliminar articulada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

I.3) DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS – CNTU

Alega-se ausente a pertinência temática, em razão de ser entidade composta por associados com interesses distintos.

O Supremo tem, historicamente, imposto limites subjetivos ao exercício da legitimidade prevista no inciso IX do artigo 103 da Carta de 1988. Desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 42/DF, relator ministro Paulo Brossard, em 24 de setembro de 1992, adota definição restritiva de entidades de classe: são aquelas a representarem grupo de pessoas que exercem as mesmas atividades profissionais ou econômicas. O traço distintivo seria, como destacou o ministro Sepúlveda Pertence em voto proferido no aludido processo, a identidade ou semelhança da atividade empresarial ou profissional ou do setor econômico. Assentou estar o sentido da expressão "classe" preso à ideia de profissão ou de segmento econômico, considerado interesse objetivo homogêneo entre os associados. O caráter econômico ou profissional das entidades e a homogeneidade de interesses dos associados seriam, em última análise, os requisitos imprescindíveis da legitimidade versada no inciso IX do artigo 103.

Com essas premissas, o Tribunal afastou a legitimidade da União Nacional dos Estudantes – UNE (ação direta de inconstitucionalidade nº 894/DF, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, apreciada em 18 de novembro de 1993), da Associação Brasileira de Defesa do Cidadão – ABRADEC, associação civil de finalidade altruísta (ação direta de inconstitucionalidade nº 61/ES, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgada em 29 de agosto de 1990), de associação de profissionais de categorias heterogêneas (ação direta de inconstitucionalidade nº 34/DF, relator ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, examinada em 5 de abril de 1989), de associação de associações (ação direta de inconstitucionalidade nº 1.037/SC, relator ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Moreira Alves, Tribunal Pleno, analisada em 3 de junho de 1998), de associação de órgãos públicos (ação direta de inconstitucionalidade nº 67/DF, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, apreciada em 18 de abril de 1990).

Também foi rígido na caracterização da qualificadora de âmbito nacional, exigindo das entidades de classe a existência de membros em pelo menos nove Estados da Federação – ação direta de inconstitucionalidade nº 386/DF, relator ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgada em 4 de abril de 1991, Diário da Justiça de 28 de junho seguinte.

Somada ao requisito da pertinência temática, a ser observado quando envolvidos os denominados legitimados especiais, a definição bastante estreita da categoria entidades de classe acabou revelando que estas apenas podem defender interesses exclusivos dos associados, profissionais e econômicos. Não lhes seria permitido, por falta de pertinência temática, buscar a garantia de direitos e interesses coletivos, direitos fundamentais e da cidadania que aproveitem a toda a sociedade ou a grupos particulares, salvo se como mero reflexo da promoção dos direitos corporativos dos associados.

Estou convencido, a mais não poder, de ser a hora de o Tribunal evoluir na interpretação do artigo 103, inciso IX, da Carta da República, de modo a ampliar a legitimação conferida às entidades de classe e confederações sindicais.

Não há qualquer razão legítima a justificar a visão restritiva do Supremo. Não é alcançada ante a interpretação literal, pois a palavra "classe" é vaga, comportando leituras muito mais generosas. A percepção não se concilia com a interpretação teleológica da Lei Básica da República, pois frustra o propósito do Texto Maior, que é democratizar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade. Pior, colide frontalmente com a interpretação sistemática da Carta, afrontando o postulado de unidade da Constituição Federal.

De muito, concordo com a óptica segundo a qual o constituinte originário visou a amplitude maior do rol de legitimados. Foi o que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

consignei, em voto vencido, no exame da mencionada ação direta de inconstitucionalidade nº 1.037/SC, ocasião em que defendi a legitimidade da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL:

> Senhor Presidente, sou daqueles que acreditam no rol do artigo 103 da Carta da República; que houve, quando dos trabalhos da Assembleia Constituinte, uma opção visando-se justamente a elastecer os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo foi abrir a possibilidade, abandonando-se o nefasto monopólio do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República, de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

No caso, encontra-se preenchido o requisito da pertinência temática, considerado o estreito vínculo entre os objetivos institucionais da entidade e a matéria analisada, a afetar diretamente interesses da classe médica, uma das categorias representadas pela requerente.

Entendo que restringir o conceito de entidade de classe e de confederação sindical implica, ao reduzir a potencialidade de interação entre o Supremo e a sociedade civil, amesquinhar o caráter democrático da jurisdição constitucional, em desfavor da própria Carta da República. Reconheço a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU.

I.4) DA INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA NOS CASOS DE VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de exigir-se, para o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, ofensa frontal ao texto da Lei Maior – ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.243, da minha relatoria, Tribunal Pleno; nº 2.714, relator ministro Maurício Corrêa; nº 2.628, redatora do acórdão ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno; nº 1.900, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno; nº 147, relator ministro Carlos Madeira, Tribunal Pleno.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

No tocante aos argumentos envolvendo a falta de domínio do idioma, a indevida interferência na autonomia dos conselhos regionais e a necessidade de tratamento recíproco para validação de diploma obtido no exterior – respectivamente, artigos 15, § 1º, III, e 16, cabeça e parágrafos 2º a 4º, da Lei nº 12.871/2013 –, embora mencionadas normas constitucionais supostamente infringidas, todo o raciocínio veiculado pelas requerentes é desenvolvido a partir do cotejo com dispositivos infraconstitucionais.

Na ação direta nº 5.035/DF, sustenta-se que a simples exigência de "possuir conhecimento em língua portuguesa" afronta o princípio da legalidade, consagrado nos artigos 5º, inciso II, e 37 da Lei Fundamental. Na ação direta nº 5.037/DF, aduz-se violação ao artigo 13 do Diploma Maior, segundo o qual a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, bem como a prescrição de proficiência contida no artigo 112 da Lei nº 6.815/1980 e na Portaria nº 1.350/2010.

Quanto à alegada ingerência estatal na autonomia dos Conselhos de Medicina, a Associação Médica Brasileira argui a impossibilidade de afastamento, por meio de medida provisória, do artigo 99 da Lei nº 6.815/1980, bem como do artigo 17 da Lei nº 3.268/1957, por serem "legislações específicas para a habilitação médica em complemento ao artigo 5°, XIII, da Constituição", no qual assegurada a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Relativamente à necessária reciprocidade no tratamento conferido aos brasileiros pelos demais países, formulada na ação direta nº 5.037, a autora alega desrespeito ao artigo 12 da Carta Federal. Consoante afirma, o ato atacado ignora o disposto no artigo 48 da Lei nº 9.394/1996, que condiciona a validação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras à existência de acordo internacional de reciprocidade.

Em todas essas situações, não há transgressão direta ao texto constitucional a ensejar a admissibilidade da ação no que concerne aos enunciados atacados. As supostas antinomias jurídicas, se existentes, devem ser resolvidas com base nos critérios hierárquico, cronológico ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

da especialidade, revelando-se inadequado, no caso, o controle normativo abstrato. Por ausente ofensa a dispositivo da Constituição Federal, as ações não devem ser admitidas no ponto.

II) DA PREJUDICIAL

II.1) DA PERDA PARCIAL DE OBJETO

Com a conversão da Medida Provisória nº 621/2013 em lei, foram alteradas as regras relativas ao funcionamento dos cursos de medicina, extinguindo-se a exigência de dois ciclos distintos e complementares entre si para a formação de médicos e, por conseguinte, a permissão para o exercício da profissão, exclusivamente observado o segundo ciclo de formação, após a aprovação no primeiro.

Consoante a jurisprudência do Supremo, fica prejudicada, em virtude da perda do objeto, a ação direta cujo ato normativo contestado sofre alteração substancial no conteúdo – ação direta de inconstitucionalidade nº 258/DF, relator ministro Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, e medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 991/DF, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno.

Verifico que as iniciais de ambas as ações foram aditadas pelas autoras, afastando o prejuízo arguido pelo Procurador-Geral da República em parecer juntado à ação direta nº 5.035. No tocante à de nº 5.037, não houve impugnação específica ao conteúdo do dispositivo na nova redação. Considerada a substancial mudança, assento o prejuízo do pedido no tocante à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 12.871/2013.

A análise das ações diretas deve ocorrer relativamente aos demais dispositivos da Lei nº 12.871/2013.

III) DO MÉRITO

III.1) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

As requerentes sustentam a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013, seja por ausente o pressuposto constitucional da urgência, seja por tratar de matérias expressamente vedadas pelo artigo 62, § 1º, inciso I, da Constituição da República.

A conversão em lei é incapaz de sanar eventuais nulidades inerentes à medida provisória, permanecendo hígida a possibilidade de controle.

Sob o ângulo formal, o Supremo admite caber ao Chefe do Executivo a avaliação de conveniência e oportunidade, ressalvados os casos de excesso de poder – ação direta de inconstitucionalidade nº 2.150-8/DF, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, publicada no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2002. O controle de constitucionalidade das medidas provisórias, quanto aos requisitos de relevância e urgência, ainda que excepcional, mostra-se viável quando manifesto o abuso.

Sempre consignei serem tais condições aferíveis por aquele que possui, no controle concentrado, a guarda da Constituição. Reconheço a existência de texto aberto no qual formuladas, a permitir múltiplas interpretações. Somente podem ser tidas como próprias ante a situação concreta. A indeterminação concernente aos conceitos versados na Constituição exige seja apreciada a opção do intérprete sob o ângulo conceitual, o que deve ser feito em observância ao princípio da separação de Poderes e à necessidade de reconhecer espaço legítimo de interpretação constitucional aos demais agentes políticos de cúpula do Estado. Em síntese, a inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 62 da Lei Maior deve resultar do contexto.

Em jogo faz-se a edição de medida provisória instituidora de políticas públicas na área da saúde voltadas, entre outras, à formação de profissionais, bem como ao fortalecimento da prestação de serviços essenciais. A relevância da matéria salta aos olhos, considerada a importância do tema, refletida nos graves problemas a afetar a atuação do Sistema Único de Saúde, sobretudo nas regiões mais carentes do País, sendo insuficiente, a mais não poder, a estrutura existente, notando-se falha no corpo funcional dedicado à saúde, conforme abordado a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Quanto à urgência para o implemento da medida, menciono a informação, veiculada na exposição de motivos da Medida Provisória nº 621/2013, de que o Brasil apresenta proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, média consideravelmente inferior à de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante e à de outros com sistemas universais de saúde. O mais grave: há grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões, verificando-se proporção inferior a 1 médico por 1.000 nos Estados do Acre (0,94), Amapá (0,76), Maranhão (0,58), Pará (0,77) e Piauí (0,92). Entre as explicações para o panorama, aponta-se o número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina, a refletir no número de médicos. Extraio desse quadro a justificativa de urgência no regramento.

Sob o ângulo material, descabe conferir aos conceitos de nacionalidade e cidadania sentido alargado, a abranger contratação e concessão de visto temporário para médicos intercambistas estrangeiros e dependentes legais. O texto impugnado não dispõe sobre o vínculo jurídico-político por meio do qual passam a conviver com os nacionais, nem versa acerca da participação nos negócios políticos do Estado ou em outras áreas de interesse público.

Também é impróprio agasalhar a tese de que a medida provisória disciplinou matéria orçamentária. O diploma normativo não trata de planejamento e execução de finanças públicas, tampouco contempla previsão de receitas e fixação de despesas. Veicula política pública referente à saúde, cumprindo ao Poder Executivo implementar, mediante instrumentos próprios, as providências necessárias ao custeio do programa.

Sob tais ângulos, não procedem as alegações de inconstitucionalidade formal e material suscitadas pelas requerentes, porquanto ausente tema constitucional vedado e configurada, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a situação de relevância e urgência a justificar a edição de normas provisórias pelo Presidente da República.

III.2) DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Faz-se em jogo analisar o regime jurídico aplicável aos médicos participantes do programa. As requerentes aduzem que os artigos 11, 13 e 14 da Medida Provisória nº 621/2013 – convertidos, respectivamente, nos artigos 17, 19 e 20 da Lei nº 12.871/2013 – padecem de inconstitucionalidade por mitigar o princípio do concurso público, afastar direitos sociais e tornar precárias as relações trabalhistas.

A Presidência da República afirma tratar-se de programa de capacitação executado na modalidade ensino-serviço, inexistente vínculo efetivo com os bolsistas e tampouco a criação de cargo, emprego ou função pública. A óptica não se coaduna com a realidade fática nem com os preceitos constitucionais atinentes à matéria.

As informações e esclarecimentos prestados durante a audiência pública revelam a inequívoca presença de relação de natureza trabalhista escamoteada de ensino-serviço[1]. Nas manifestações favoráveis ao programa, fica nítida a exclusiva finalidade de suprir a falta de médicos em determinadas regiões do País.

Não é razoável concluir pelo pagamento de bolsa para médicos estrangeiros se especializarem e, em seguida, sem qualquer indenização aos combalidos cofres públicos, retornarem aos países de origem.

No acórdão nº 1605-25/15-P, da relatoria do ministro Benjamin Zymler, o Tribunal de Contas da União chegou a recomendar ao Ministério da Saúde a reavaliação da necessidade e dos benefícios de oferecer cursos de especialização para médicos estrangeiros, considerado o seguinte cenário:

[…]

1 Segundo o procurador do trabalho Sebastião Vieira Caixeta, a análise das normas legais e documentos conjuntos assinados pelos gestores do programa, em inquérito civil promovido no âmbito do Ministério Público do Trabalho, revelou, "com muita clareza, que o que se tem, de fato, é uma relação de trabalho [...], embora mascarada por um programa de aperfeiçoamento que seria uma pós-graduação com foco no ensino, na pesquisa e na extensão[...]". O Doutor William José Bicalho Hastenreiter Paulo, médico participante do programa, disse trabalhar no atendimento à população como qualquer outro médico, sendo o único contato mantido com o tutor voltado apenas a informar quantos pacientes atende por dia.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> 25. Observou-se que, até 12/5/2014, 11.814 médicos intercambistas individuais estrangeiros ou cooperados (provenientes do acordo com a Opas) estavam em atividade. Considerando os gastos com tutores e supervisores e os custos do curso a distância ministrado para esses médicos, o dispêndio total da especialização somente para os médicos estrangeiros, nos três anos de projeto, ficará em R$ 242.782.748,72 (duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Isso quer dizer que o Governo Federal investirá cerca de R$ 240 milhões no prazo de três anos para especializar profissionais que, ao final do projeto, têm grandes chances de deixar o país e não aplicar aqui os conhecimentos adquiridos (TC nº 005.391/2014-8005.391/2014-8, peça 171, p. 40).

Quanto à ausência de certame para o ingresso de médicos no programa, de fato, no âmbito da administração pública, a regra é a admissão de pessoal mediante concurso. No caso, tem-se contratação por tempo determinado para satisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público, contemplada no artigo 39 inciso, IX, da Constituição. Trata-se de exceção à regra geral. A falta de concurso público justifica-se pelo número insuficiente de médicos para atender à demanda existente em certas regiões.

No julgamento do recurso extraordinário nº 658.026/MG, com repercussão geral reconhecida, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 31 de outubro de 2014, foram apontadas cinco condições para a validade de contratação temporária: a) previsão legal dos casos excepcionais; b) prazo de contratação pré-determinado; c) caráter temporário da necessidade; d) excepcionalidade do interesse público; e) indispensabilidade da contratação, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar abrangidos pelas contingências administrativas normais.

No caso do Programa Mais Médicos, os requisitos encontram-se preenchidos. A exigência formal de previsão legislativa foi satisfeita com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

a edição da Medida Provisória nº 621/2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.871/2013. O prazo para o aperfeiçoamento dos médicos participantes e para a concessão do visto temporário dos intercambistas foi pré-fixado em, no máximo, três anos, prorrogável por igual período. Embora sejam permanentes as necessidades envolvendo políticas públicas na área da saúde, a carência de profissionais da área médica em algumas regiões pode ser caracterizada, ao menos em tese, como de caráter temporário, ante as medidas adotadas com a finalidade de formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde – SUS. A excepcionalidade do interesse público está presente na relevância de tais políticas públicas para toda a coletividade. Por fim, a contratação temporária de médicos revela-se indispensável ao adequado atendimento nas regiões com reduzida proporção de médicos por habitantes.

Descabe considerar inconstitucional toda e qualquer contratação temporária voltada ao implemento de atividades essenciais e permanentes. Deve ficar sempre aberta a possibilidade de análise da transitoriedade da situação e da excepcionalidade do interesse público a justificá-la. Esse foi o entendimento do Tribunal, em acórdão assim ementado:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES "NECESSIDADE TEMPORÁRIA" E "EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO". POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição (Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.247/MA, relatora ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de agosto de 2014).
>
> O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. A alegada inércia da administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal" (Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.068, redator do acórdão ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, publicado no Diário da Justiça de 23 de setembro de 2005).

Devem ser observados os direitos dos servidores públicos civis da União assegurados pelo artigo 11 da Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado:

> Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Não procede o alegado desrespeito às exigências constitucionais de concurso público e de licitação, tampouco a direitos sociais dos trabalhadores.

III.3) DA ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

A constitucionalidade dos artigos 3º, 6º e 8º da Medida Provisória nº 621/2013 – correspondentes aos artigos 3º, 10 e 14 da Lei nº 12.871/2013 – é questionada sob o argumento de ofensa ao princípio da autonomia universitária, consagrado no artigo 207 da Lei Maior, o qual dispõe:

> As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A autonomia consiste no poder atribuído a determinadas instituições para elaborar regras próprias dentro de certos parâmetros delimitados por normas superiores. Nas palavras de José Afonso da Silva, trata-se de "conceito relacional, porque se prende ao confronto com outros órgãos de poder: autonomia é o poder de gerir os próprios assuntos dentro de um círculo prefixado."[2]

A autonomia universitária não é irrestrita: subordina-se aos preceitos constitucionais e legais. Não se pode confundi-la com soberania ou interpretá-la como independência.

A Constituição Federal, no artigo 22, inciso XXIV, confere à União competência para estabelecer normas gerais sobre a educação nacional, fixando as diretrizes e bases que devem informar o ensino ministrado no

2 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

País. Com alicerce nessa previsão, a Lei nº 9.394/1996, na qual estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, limita a autonomia atribuída às universidades:

> Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
>
> I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
>
> II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
>
> […].

Nos termos do artigo 9º, § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, cabe à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional da Educação "deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação."

O quadro revela a existência de limites legitimamente impostos à autonomia didático-científico, mesmo antes do advento dos dispositivos legais atacados.

No mais, as orientações veiculadas na Lei nº 12.871/2013 estão em harmonia com os parâmetros fixados pelo artigo 214 da Constituição Federal, segundo o qual um dos objetivos do plano nacional de educação consiste em definir diretrizes com o fim de assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino por meio de ações integradas dos poderes públicos voltadas à "formação para o trabalho" e à "promoção humanística".

Quanto a esse ponto, compartilho da visão adotada pelo Procurador-Geral da República, em parecer:

> A formação dos médicos no Brasil tem uma perspectiva humanística, ética e social, que envolve uma reflexão crítica e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

contextualizada, além dos conhecimentos técnico-científicos inerentes à profissão. Desse modo, constata-se que a autonomia universitária para a organização curricular e programática dos cursos de graduação em Medicina já se encontrava limitada pelas diretrizes gerais estabelecidas em 2001 pela Câmara de Educação Superior.

De qualquer forma, nada impede que a União, por meio de medida provisória e respectiva lei de conversão, institua diretrizes curriculares específicas para o curso de Medicina, delegue competências gerenciais ao Ministro da Educação – gestor executivo por excelência da Pasta – e determine a adequação das instituições de ensino superior às novas regras.

Tampouco há violação à gestão democrática do ensino público, prevista no art. 206, VI, da Constituição. A competência estatal para estabelecer diretrizes normativas relativas ao ensino superior decorre do dever do Estado de disciplinar a educação no país, associando-a à realidade social e às políticas públicas. Na hipótese em exame, verifica-se uma política de direcionamento do acesso à saúde para determinadas regiões e públicos-alvo que historicamente foram privados da plena realização desse direito fundamental.

Constatando-se que parte do problema do sistema brasileiro de saúde decorre de deficiências na formação e na distribuição dos médicos no país, é inevitável a integração dos requisitos da formação profissional ao conjunto de soluções desenhadas na política pública posta em ação.

Desse modo, a imposição pelo Estado de novos requisitos curriculares não viola o texto constitucional.

Surge impróprio considerar ofensivas à autonomia universitária as diretrizes fixadas quanto à autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina, à adequação da matriz curricular e ao aperfeiçoamento dos médicos participantes do programa.

III.4) DA DISPENSA DE REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Outro ponto a ser analisado é a dispensa de revalidação do diploma para os médicos intercambistas. Alega-se que os artigos 13 e 16 da Lei nº 12.871/2013 violam normas da Constituição da República, em especial o princípio da isonomia. Primeiro, por conferir tratamento diferenciado a integrantes de idêntica categoria essencial, qual seja, a dos médicos. Segundo, em razão do atendimento desigual oferecido aos cidadãos brasileiros, conforme a região e a classe econômica. Argumenta-se serem os pacientes de determinados centros urbanos atendidos por profissionais devidamente registrados nos conselhos regionais, ao passo que, nas regiões menos favorecidas, considerada a dispensa de validação dos diplomas, a assistência é realizada por estrangeiros sem a comprovação da capacidade técnica necessária para o adequado exercício da medicina. Daí o risco à vida e à saúde dos pacientes.

O reconhecimento da igualdade pelo direito vem trilhando caminho de constante evolução ao longo da história.

No estado liberal clássico, ocorre em termos meramente formais, no sentido de exigir-se idêntico tratamento a todos que se encontrem na mesma situação, concepção a veicular a ideia de serem todos os homens iguais, não importando o conteúdo do tratamento dispensado nem as condições ou circunstâncias de cada indivíduo. Reduzido ao aspecto formal, o princípio da igualdade converte-se em simples exigência de generalidade e de prevalência da lei em face da jurisdição e da administração. A visão mostrou-se insuficiente para definir quem deveria receber tratamento igual ou desigual e em que medida isso deveria ocorrer.

Com o advento do estado social e o consequente incremento da intervenção estatal em relações sociais, econômicas e culturais, verifica-se releitura do princípio. Ante a constatação de que o mero dever de idêntica proteção para indivíduos ou situações com as mesmas características essenciais acaba por permitir diferenciações arbitrárias e injustas, são delineados os contornos de percepção material, voltada também ao conteúdo justo das normas criadas pelo legislador.[3]

3 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

A igualdade material é tradicionalmente associada à clássica definição de Aristóteles: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nesse sentido, a lição de Rui Barbosa segundo a qual "a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam", pois "tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real."[4]

Embora a fórmula aristotélica não forneça critérios substanciais para a formulação de entendimento sobre a relação de igualdade ou de desigualdade, a óptica material pressupõe a adoção de critérios distintivos justos e razoáveis. Nessa perspectiva, o princípio da igualdade é reconduzido à proibição de arbítrio, vedando tratamentos injustificadamente desiguais para situações essencialmente iguais, assim como tratamentos idênticos para casos fundamentalmente desiguais. Vem-nos de grande pensador do Direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, o seguinte trecho:

> O que se visa com o preceito isonômico é impedir favoritismos ou perseguições. É obstar agravos injustificados, vale dizer, que incidam apenas sobre uma classe de pessoas em despeito de inexistir uma racionalidade apta a fundamentar uma diferenciação entre elas que seja compatível com os valores sociais aceitos no Texto Constitucional.[5]

Diversamente de outros direitos fundamentais, a igualdade não possui conteúdo constitucional pré-determinado. Trata-se de conceito relacional a exigir análise comparativa entre situações, indivíduos ou grupos atingidos pela norma.

A intervenção estatal no âmbito da proteção do direito à igualdade ocorre quando os poderes públicos conferem idêntico tratamento a situações distintas ou tratamento desigual a circunstâncias semelhantes.

---

4 BARBOSA, Rui. *Oração aos moços*. São Paulo: Martin Claret, 2003.

5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Compostura jurídica do princípio de igualdade. Revista de Direito Administrativo e Constitucional – AeC. Belo Horizonte, n. 11, Ano 3, Jan./Mar. 2003.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Embora o dever de "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais" não contenha nenhum parâmetro para definir o que é valorativamente igual ou desigual, a igualdade material só se realiza quando adotados critérios justos e razoáveis. Oscar Vilhena Vieira caracteriza o princípio da igualdade como espécie de "regulador das diferenças", atuando para "discernir entre desigualizações aceitáveis e desejáveis e aquelas que são profundamente injustas e inaceitáveis.[6]"

Para ser legítima, a intervenção deve ser constitucionalmente justificada, submetendo-se ao crivo da proporcionalidade, de modo a se revelar adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.

A medida estatal é adequada quando apta a fomentar os fins pretendidos. Tal aferição, como ensinam Matthias Klatt e Moritz Meister, deve ser precedida da análise da legitimidade[7]. Em outras palavras: a adequação pressupõe a adoção de meio legítimo capaz de promover objetivo também legítimo.

De acordo com as informações prestadas pela Presidência da República, a contratação de médicos estrangeiros é medida de caráter emergencial e temporário voltada a reduzir a carência de profissionais e as desigualdades regionais na área da saúde. A dispensa de revalidação do diploma é justificada pela restrição do exercício das atividades desses profissionais exclusivamente ao âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, pois a aprovação no Revalida importaria o reconhecimento do direito de exercer livremente a profissão em todo o território nacional, algo contrário à finalidade do projeto.

O meio empregado revela-se ilegítimo por ofender princípios basilares da Constituição da República. O Estado tem o dever de tratar todos os membros da comunidade com idêntico respeito. Nas palavras de Ronald Dworkin, "nenhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos sobre os quais

---

6 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: Uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006.

7 KLATT, Matthias; MEISTER, Moritz. "A máxima da proporcionalidade: um elemento estrutural do constitucionalismo global". Tradução: João Costa Neto. *Observatório da Jurisdição Constitucional*. Brasília: IDP, Ano 7, n. 1, jan./jun. 2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política"[8].

O artigo 196 da Lei Maior estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." A leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em nele reconhecer obrigação constitucional de promoção de políticas públicas abrangentes direcionadas à proteção integral da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível solidariamente aos três entes da Federação. Cabe indagar se a política pública destinada à contratação de médicos estrangeiros sem a devida aferição dos atributos técnicos necessários ao exercício profissional é, à luz desse preceito, suficiente e adequada. A resposta é desenganadamente negativa.

A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover, de maneira constitucional, o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais cuja qualificação técnica, considerada a realidade brasileira, não foi suficientemente avaliada pelos órgãos técnicos competentes. Sob esse ângulo, assim fiz ver em voto proferido no julgamento do recurso extraordinário nº 567.985/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno:

> Embora ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa de direitos fundamentais o chamado principio da proibição da concretização deficitária, cujo fundamento último radica-se no dever, imputável ao Estado, de promover a edição de leis e ações administrativas efetivas para proteger os direitos fundamentais.

A carência de médicos, embora problema de extrema gravidade, a

8 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: A teoria e a prática da igualdade. Tradução: Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

exigir a adoção de providências concretas por parte das autoridades públicas, não pode servir como justificativa para o comprometimento dos direitos fundamentais em jogo. Da mesma forma estarrece o argumento segundo o qual a revalidação somente é exigível para o médico atuar, indistintamente, em todo o território nacional, como se as regras jurídicas correspondentes não fossem as mesmas, variando conforme a região.

Atentem para a inadequação do ato impugnado ante o princípio da isonomia, consideradas as disparidades regionais do Brasil. Se é certo que a lei atacada visa conferir a estratos mais carentes da sociedade atendimento médico inexistente, combatendo a quebra da igualdade no acesso ao tratamento digno, não é menos correto afirmar a potencialização das disparidades causada pela norma, tendo em vista a prestação de serviços de saúde por médicos submetidos a procedimentos de qualificação destoantes no território nacional.

A título de implementar política pública eficaz em locais não amparados apropriadamente pelo Estado, a Lei nº 12.871/2013 conferiu-lhes assistência médica precária, avaliada em face de parâmetros menos rigorosos em relação àqueles exigidos para o exercício da medicina em outras partes do País. Há de reconhecer-se a afronta ao princípio da isonomia.

O objetivo visado mostra-se ilegítimo, ainda, por contrariar o previsto no inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal, no qual consagrado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Apesar da possibilidade de restrição do exercício profissional pelo legislador ordinário, tem-se, no caso, reserva legal qualificada, por estar a autorização constitucional limitada à eventual imposição de "qualificações profissionais".

Consoante assentado no julgamento do recurso extraordinário nº 511.961/SP, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicado no Diário da Justiça em 13 de novembro de 2009, "o Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que as restrições legais à liberdade de exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Autorizando a norma constitucional situação de reserva legal qualificada, isto é, de restrição a direito fundamental vinculada a certo fim, ausente no caso concreto, a disciplina mostra-se inconstitucional.

No voto proferido no recurso extraordinário nº 603.583/RS, da minha relatoria, Tribunal Pleno, em que debatida questão alusiva às condições impostas para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, fiz ver:

> o constituinte originário limitou as restrições à liberdade de ofício às exigências de qualificação profissional. Cabe indagar: por que assim o fez? Ora, precisamente porque o trabalho, além da dimensão subjetiva, também ostenta relevância que transcende os interesses do próprio indivíduo. Em alguns casos, o mister desempenhado pelo profissional resulta em assunção de riscos os quais podem ser individuais ou coletivos. Quando o risco é predominantemente do indivíduo exemplo dos mergulhadores, dos profissionais que lidam com a rede elétrica, dos transportadores de cargas perigosas, etc., para tentar compensar danos à saúde, o sistema jurídico atribui-lhe vantagens pecuniárias (adicional de periculosidade, insalubridade) ou adianta-lhe a inativação. São vantagens que, longe de ferirem o princípio da isonomia, consubstanciam imposições compensatórias às perdas físicas e psicológicas que esses profissionais sofrem.
>
> Quando, por outro lado, o risco é suportado pela coletividade, então cabe limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício, exatamente em função do interesse coletivo. Daí a cláusula constante da parte final do inciso XIII do artigo 5º da Carta Federal, de ressalva das qualificações legais exigidas pela lei. Ela é a salvaguarda de que as profissões que representam riscos à coletividade serão limitadas, serão exercidas somente por aqueles indivíduos conhecedores da técnica.
>
> A alusão à dignidade da pessoa humana há de ser lida sob esse prisma, não se devendo levar o princípio às últimas consequências. [...] A liberdade de profissão não se resume à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> esfera particular. Certas profissões, como as de médico, engenheiro, arquiteto, se exercidas por pessoas despidas das qualificações técnicas necessárias, podem resultar em graves danos à coletividade.

A lei atacada, ao dispensar a revalidação do diploma com a alegada restrição do exercício profissional ao âmbito do projeto, subverte a finalidade da cláusula limitadora. Vale dizer: em vez de limitar o acesso à profissão e o exercício com o intuito de prevenir os riscos trazidos à coletividade pela atuação de profissionais médicos inabilitados, optou-se por flexibilizar os critérios de avaliação das qualificações técnicas necessárias ao exercício da medicina no âmbito do programa, ampliando os potenciais danos à vida e à saúde dos pacientes atendidos pelos médicos intercambistas.

Ainda que o meio seja apto a fomentar o fim almejado, ambos carecem de legitimidade à luz da Constituição. Por não superada a etapa da adequação, faz-se desnecessária a análise da exigibilidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

III.5) DO TRATAMENTO CONFERIDO AOS MÉDICOS CUBANOS

Analise-se a questão referente ao tratamento diferenciado conferido aos profissionais da classe médica participantes do programa.

O artigo 23 da Lei nº 12.871/2013 autoriza os Ministérios da Educação e da Saúde, com o propósito de executar as ações relacionadas ao programa, a firmar acordos e outros instrumentos de cooperação, inclusive com organismos internacionais.

Buscando viabilizar o "PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE PARA A PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", o Ministério da Saúde celebrou o Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica, que tem por objeto a inserção de metas e recursos para garantir a cooperação técnica entre as partes. Para o desenvolvimento das atividades do programa, previu:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> I – Compete ao MINISTÉRIO, em conformidade com suas políticas, normas e regulamentos:
>
> [...]
>
> o) Realizar, com base nos Planos de Ação do PROGRAMA, o repasse semestral antecipado à OPAS/OMS dos recursos referentes:
>
> i) ao financiamento da cooperação técnica prestada pela OPAS/OMS, incluída a cooperação por meio de consultores e assessores em Atenção Básica em Saúde;
>
> ii) ao financiamento das bolsas dos Médicos Participantes, incluídas as ajudas de custo de instalação, definido pela Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, assim como o transporte internacional dos Médicos Participantes (incluído o transporte por recesso) e o seguro de vida com repatriação por morte.
>
> [...]

Surge o seguinte quadro: os médicos formados em instituições brasileiras de ensino superior ou com diplomas revalidados recebem valores integrais, correspondentes ao que rotulado como bolsa e ajuda de custo, depositados diretamente em conta-corrente. Já o pagamento da remuneração dos médicos cubanos contratados por meio do referido convênio é efetuado de forma indireta, mediante o repasse dos valores pela Organização Pan-americana da Saúde – OPAS ao governo de Cuba, que retém determinada parcela oficialmente não revelada.

Os valores sociais do trabalho são um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o artigo 1º, inciso IV, do Texto Maior. Da opção política feita pelo constituinte originário resulta compromisso inafastável do Estado brasileiro com a valorização do ser humano, a refletir o reconhecimento do direito ao trabalho como desdobramento da dignidade, uma vez que "é por meio do trabalho que o homem atinge sua plenitude, realiza sua própria existência, socializa-se,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

exercita todas as suas potencialidades (materiais, morais e espirituais)." Daí a assertiva de Cláudio Mascarenhas Brandão no sentido de o referido fundamento representar "a projeção do princípio da proteção à dignidade do homem na condição de trabalhador."[9]

No mesmo sentido, ensina o professor José Afonso da Silva:

> Os *valores sociais do trabalho* estão precisamente na sua função de criar riquezas, de prover a sociedade de bens e serviços e, enquanto atividade social, fornecer à pessoa humana bases de sua autonomia e condições de vida digna. Os *valores do trabalho*, portanto, só se materializam com o direito à livre escolha do trabalho pelo trabalhador, direito a condições equitativas (igualdade de tratamento nas relações de trabalho), direito a uma remuneração que assegure ao trabalhador e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana do trabalhador e seus familiares[10].

Como acontece com os princípios fundamentais, os quais encampam valores supremos densificados ao longo do texto constitucional, trata-se de norma politicamente conformadora, vinculante para os poderes públicos, a ser observada como vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico.

O tratamento conferido aos médicos cubanos viola, a mais não poder, direitos sociais assegurados aos trabalhadores, notadamente a proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, contida no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.

A vedação tem como finalidade impedir diferenciações injustificadas, prejudiciais à vida econômica do trabalhador. A regra geral – corolária, na esfera das relações de trabalho, da cláusula pétrea da igualdade –, consagra rol aberto, e não taxativo, de modo a alcançar

---

9 BRANDÃO, Cláudio Mascarenhas. "Comentário ao artigo 1º, inciso IV". *Comentários à Constituição do Brasil*. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 128-132.

10 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

outros motivos que possam ensejar tratamentos indevidamente diferenciados, entre eles a origem ou nacionalidade do trabalhador.

Nesse sentido, transcrevo parte do voto do ministro Néri da Silveira quando do exame do recurso extraordinário nº 161.243, relator ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 1997:

> De outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso XXX do art. 7º da CF, qualquer discriminação decorrente – além, evidentemente, da nacionalidade – de sexo, idade, cor ou estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário a tratamento discriminatório entre pessoas que prestam serviços iguais a um empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou.

A vedação constitucional dirige-se não apenas aos particulares, mas também ao próprio Estado, de forma que distinções envolvendo remuneração, exercício de funções e critério de admissão somente são consideradas legítimas quando razoáveis e passíveis de justificação pela natureza das atribuições a serem exercidas. É essa a diretriz hermenêutica contida no verbete nº 683 da Súmula deste Tribunal:

> O limite de idade para a inscrição em concurso só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A obscuridade envolvendo os termos do acordo firmado entre a Organização Pan-americana da Saúde – OPAS e o governo cubano, reiteradamente destacada durante a audiência pública[11], e o tratamento

11 O titular da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves, afirmou: "Por várias vezes, nós solicitamos da OPAS que nos desse detalhes ou, senão pelo menos, a cópia do contrato. Eles sequer aceitaram ir ao Congresso Nacional." No mesmo sentido, Sebastião

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

conferido aos profissionais contratados por intermédio do mencionado convênio também não se coadunam com o preceituado no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da Organização Mundial da Saúde – OMS:

> 3.5. O recrutamento internacional de pessoal de saúde deve ser conduzido de acordo com os princípios da transparência, justiça e promoção da sustentabilidade dos sistemas de saúde de países em desenvolvimento. Estados-Membros, em conformidade com a legislação nacional e instrumentos legais internacionais aplicáveis, devem promover e respeitar práticas trabalhistas justas para todo o pessoal de saúde. Todos os aspectos do trabalho e do tratamento do pessoal de saúde imigrante devem ser tratados sem nenhuma distinção ilegal de qualquer tipo.
>
> […]
>
> 4.4. Os Estados-Membros devem, na extensão possível das leis aplicáveis, garantir que os recrutadores e empregadores observem práticas justas de recrutamento e contrato no emprego de pessoal de saúde imigrante e que este não sejam objeto de condutas ilegais ou fraudulentas. O pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tais como níveis de qualificação, anos de experiência e grau de responsabilidade baseados na igualdade de tratamento com o pessoal de saúde do país.

Vieira Caixeta, procurador do Ministério Público do Trabalho, ressaltou: "Foi-nos trazida inclusive a argumentação da União a respeito de que essa relação – e não há controvérsia a respeito disso – dos profissionais cubanos que não percebem a bolsa de dez mil reais, como tal ocorre em relação aos demais profissionais, sejam eles nacionais ou estrangeiros – estrangeiros de outras nacionalidades que não aqueles oriundos de Cuba recebem –, observados os parâmetros da própria medida provisória convertida em lei, os dez mil reais referentes à bolsa, o dinheiro é repassado, através de um convênio celebrado entre Brasil e a OPAS, a Cuba. E aí eu até procurei obter acesso à outra parte do convênio, que fecha essa negociação, que é o convênio entre a OPAS e o Governo de Cuba, e não tive acesso. Foi formalmente negado o acesso a esse convênio. Aliás, segundo informações, sequer o Governo brasileiro tem acesso a esse convênio para saber como é feita a disciplinação do pagamento desses direitos, o que nos parece importante de saber, de maneira a deixar de forma clara o que deve ser repassado aos profissionais."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

> Recrutadores e empregadores devem prover o pessoal de saúde imigrante de informações relevantes e precisas sobre todas as posições oferecidas.
>
> 4.5. Os Estados-Membros devem garantir que, sujeitos às leis aplicáveis, incluindo instrumentos legais internacionais, o pessoal de saúde imigrante deve possuir os mesmos direitos legais e responsabilidades que o pessoal de saúde do país no que concerne a todos os termos de contratação e às condições de trabalho.
>
> […]

As diretrizes fixadas pelo Código devem ser respeitadas pelo Estado brasileiro, inclusive no tocante à seleção de médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, como enfatizado na exposição de motivos da Medida Provisória nº 621/2013:

> 35. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de informações, o monitoramento e a pesquisa no tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arco-Sur.

O pagamento indireto e a menor contraria a Convenção nº 117 sobre objetivos e normas básicas da política social, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho – OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 65/1966 e incorporada ao ordenamento jurídico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

brasileiro por meio do Decreto nº 66.429/1970:

> ARTIGO 8º
>
> 1 - Quando numa região se apelar para os recursos de mão de obra de um país submetido a uma administração diferente, as autoridades competentes dos países interessados deverão, sempre que for necessário ou desejável fazê-lo, concluir acordos para solucionar as questões de interesse comum que possam ser levantadas pela aplicação das disposições da presente Convenção.
>
> 2 - Esses acordos deverão providenciar para que o trabalhador migrante goze de uma proteção e de vantagens não inferiores àquelas de que beneficiam os trabalhadores residentes na região do emprego.
>
> [...]
>
> ARTIGO 11
>
> 1 - Tomar-se-ão as medidas necessárias para assegurar que todos os salários ganhos sejam devidamente pagos, e os empregadores terão obrigatoriamente de estabelecer registros que indiquem os pagamentos dos salários, de entregar aos trabalhadores atestados relativos ao pagamento dos seus salários e de tomar outras medidas apropriadas para facilitar a inspeção necessária.
>
> 2 - Os salários não serão normalmente pagos senão em moeda com circulação legal.
>
> 3 - Os salários serão normalmente pagos diretamente ao próprio trabalhador.

O tratamento dado aos médicos cubanos, especialmente no tocante à contraprestação remuneratória indireta e não integral, por se mostrar nitidamente incompatível com os direitos sociais básicos assegurados aos trabalhadores, merece a glosa jurisdicional.

IV) DO DISPOSITIVO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

Ante o quadro, não admito as ações diretas relativamente aos artigos 15, § 1º, III, e 16, parágrafos 2º a 4º, da Lei nº 12.871/2013; julgo prejudicado o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.037/DF quanto aos artigos 4º e 5º da referida lei; e defiro parcialmente os pedidos formalizados em relação aos demais dispositivos, assentando a inconstitucionalidade dos artigos 13, II, § 1º, II e III, e § 2º, II, e 16 da Lei nº 12.871/2013 e, por arrastamento, do Terceiro Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e a Organização Pan-americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14185532.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, em virtude do detalhado e extensamente fundamentado voto do ilustre relator, Ministro MARCO AURÉLIO, e do horário, serei o mais breve possível. Para tanto, desde logo, acompanho a fundamentação e o voto de sua excelência quase integralmente, excetuando-se as duas hipóteses em que o eminente Ministro relator declarou a inconstitucionalidade da lei: (a) a questão da desnecessidade de revalidação do diploma; (b) a questão da inexistência de relação de trabalho.

O Estado brasileiro está compelido a perseguir, por imposição constitucional, um modelo de atenção à saúde que seja capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado (integralidade, art. 198, II) elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem.

É a partir desse quadro normativo que devemos examinar a questão de fundo. Para tanto, devemos constatar que a lei atacada, a Lei 12.871/2013, tem basicamente três blocos:

(1) Regras sobre a autorização para o funcionamento dos cursos de medicina;

(2) Regras sobre a formação médica no Brasil (entre as quais, por exemplo, a determinação de que 30% do internato seja de Atenção Básica em Saúde e no SUS); e

(3) *Projeto Mais Médicos para o Brasil* (oferecido a prioritariamente a médicos diplomados no Brasil, mas também a médicos diplomados aqui e no exterior – "intercambistas", com foco na Atenção Básica em Saúde e em regiões prioritárias para o SUS).

Esses três blocos presentes na lei refletem os três eixos de atuação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

prioritária definidos no Plano Nacional de Saúde – 2012/2015, como bem lembrado pela Advocacia-Geral da União em sua manifestação. São eles:

> (i) a reordenação da oferta de cursos de medicina e vagas para residência médica, com foco prioritário nas regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos; (ii) o estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e (iii) a promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional. (p. 14 da manifestação da AGU)

Trata-se, portanto, de um caso típico de arcabouço normativo destinado a dar existência a políticas públicas de efeitos concretos.

A norma atacada no geral pela ação sob exame é uma opção de política pública que, por mais criticável que seja em alguns pontos de sua execução, como demonstra o relatório do TCU, pretende dar cumprimento real ao disposto no art. 196 da Constituição:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário e às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

As distorções e as precariedades estão na realidade dada, infelizmente. Dados presentes nos autos e facilmente verificáveis em pesquisas disponíveis apontam para a enorme carência de médicos em várias regiões do Brasil. Uma política pública, por mais criticável que seja, não padece de inconstitucionalidade ao tentar enfrentar essas distorções. Ao contrário, a omissão do poder público é que, sim, ofenderia o princípio da igualdade.

Eventuais ilicitudes ou falhas em sua execução devem ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

investigadas e corrigidas, mas não levam à inconstitucionalidade da lei.

Afasto, portanto, a afirmação do eminente relator – com todas as vênias – de que houve *alegada permissão ao exercício ilegal da medicina ao se dispensar a revalidação do diploma estrangeiro.*

Segundo a autora, o art. 16 da Lei (art. 10 da MP) estaria permitindo o exercício ilegal da medicina ao dispensar a revalidação do diploma estrangeiro do médico intercambista (que pode ser brasileiro ou não).

O dispositivo constitucional que deve nortear o exame da controvérsia é o inciso XIII do art. 5º:

> XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer

De fato, a norma constitucional remete a restrição do exercício de profissão à existência de lei que estabeleça as qualificações pertinentes que seriam de observância obrigatória. Não existindo lei, não há como se restringir o exercício de profissão, como bem já decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA:

> O art. 5º, XIII, da Constituição da República é norma de aplicação imediata e eficácia contida que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. (MI 6.113 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 13/6/2014)

O exercício da medicina, contudo, é daquelas atividades sobre as quais existe legislação que o subordina a determinadas qualificações. E, sim, a exigência de revalidação do diploma estrangeiro é uma dessas exigências legais, conforme lemos no §2º do art. 48 da Lei 9.394/1996:

> Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

> formação recebida por seu titular.
>
> (...)
>
> § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

A medida provisória convertida em lei ora discutida veio e excepcionou para uma determinada hipótese e por um determinado período de tempo a exigência legal de revalidação do diploma.

Não há óbice constitucional na opção feita pelo legislador. Primeiro, porque a norma que excepcionou a exigência de revalidação do diploma é da mesma hierarquia que aquela que instituiu essa exigência. Ambas são leis ordinárias. Segundo, porque a exceção trazida pela lei de conversão ora atacada preservou o regramento geral, sendo muito mais um caso de lei especial que prevalece sobre lei geral que propriamente um caso de lei posterior de mesma hierarquia que revoga lei anterior. A exigência de revalidação continua sendo, portanto, a regra, inclusive para os médicos intercambistas quando terminado o período de 3 anos excepcionado pela lei de conversão. Além disso, a exceção não franqueou ao intercambista o exercício indiscriminado e livre da medicina pelo país, mas o circunscreveu às atividades de ensino, pesquisa e extensão abrigadas pelo projeto. Trata-se, pois, de evidente caso de aplicação do princípio *lex specialis derogat legi generali*.

Tanto é assim que a norma regulamentadora da lei determina expressamente que a carteira de identificação do médico intercambista contenha mensagem explícita sobre a vedação ao exercício da medicina fora das atividades do projeto Mais Médicos:

> Art. 2º O médico intercambista exercerá a medicina exclusivamente no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do disposto no art. 16 da Lei nº 12.871, de 2013.
>
> Parágrafo único. A carteira de identificação do médico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

> intercambista conterá mensagem expressa sobre a vedação ao exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
>
> (Decreto 8.126, de 22 de outubro de 2013)

Não há, pois, inconstitucionalidade a ser declarada nesse ponto.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Então, quanto ao Revalida, Vossa Excelência está divergindo?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O segundo ponto em que divirjo do Ministro Marco Aurélio é sobre a inexistência da relação de trabalho. Disso decorre também a minha divergência com o Ministro-Relator, da inexistência de quebra do princípio da igualdade em relação à questão de Cuba com os demais países. O que se pretendeu, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, como prioridade estabelecida dentro do Sistema Único de Saúde, com o Programa Mais Médicos, foi o binômio ensino/serviço: "Ah, mas como se investir nesse médico estrangeiro durante anos, uma especialização, para que ele, depois, leve esse conhecimento para o seu país e não retribua ao Brasil".

Essa é uma das argumentações da ação e foi uma das argumentações colocadas também pelo eminente Ministro Marco Aurélio. Por isso que a construção do Programa Mais Médicos parte do binômio ensino/serviço. Ao longo da especialização, há a obrigatoriedade da prestação de serviços supervisionada por médicos brasileiros, com a necessidade de irem até os locais mais carentes onde não há o serviço médico e supram, ou, pelo menos, reduzam, a ausência desse serviço. Em verdade, ao invés de se investir na especialização para, depois, auferir o retorno, o Programa pensou em já resolver isso fazendo a questão do ensino/serviço ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente.

Em virtude disso - e aqui é que há a divergência -, não se trata de vínculo empregatício, não se trata de serviço, de vinculação, é uma forma utilizada também em outros países, acadêmico-profissional de especialização junto com prestação de serviço, muito semelhante, por sinal, e que não cria vínculo empregatício, ao que se faz ao conscrito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

O médico ou o dentista que adiou o serviço as Forças Armadas quando completou dezoito anos, porque já estava na faculdade de medicina ou de odontologia; quando se forma, ficará durante um ano, podendo estender até dois anos, recebendo uma bolsa pelos serviços de saúde realizados durante o serviço militar. Não se considera aqui relação de emprego.

Consequentemente, também afasto a alegação de violação a obrigatoriedade de concurso público para acesso ao serviço público, pois a regra estabelecida é de "chamamento". E volto a dizer, prioriza o médico brasileiro; só na ausência, faz toda a sequência. Então, não me parece nem que haja a relação trabalhista, nem a necessidade de concurso público.

E, dentro desse contexto, é uma relação que se faz com entidades, com países de bolsas oferecidas, em que nada é feito diretamente, entre o Ministério da Saúde e o médico específico.

Em relação à Cuba - nós podemos concordar ou não -, mas foi feito primeiro com a organização de saúde com Cuba; que abriu o chamamento. Aqueles médicos que se inscreveram sabem as condições da bolsa. O Brasil não trata desigualmente a bolsa que oferece dentro do programa Mais Médicos, pois foi feito o chamamento geral. Agora, em relação à Cuba, poderemos chamar assim, há um intermediário que faz uma escolha de médicos, ou faz a implantação, mas não é uma diferenciação feita pelo Brasil. Não é uma questão de pagamento diferente de bolsa que é oferecida a determinadas entidades, e, no caso de Cuba, a entidade supervisora, que é ligada ao governo, pela estrutura estatizante cubana, é quem controla e fica com uma parcela. Mas nada obriga o médico cubano a aceitar essa bolsa. Então, não há um tratamento diferenciado para o médico intercambista. O que há é que, dentro dos pactos tratados com Brasil ou aqui das bolsas oferecidas, cada país se estrutura de uma determinada maneira.

Nesse ponto, renovando as vênias, divirjo de sua Excelência, o Ministro-Relator.

Foram somente esses dois pontos que sua Excelência entendeu

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

inconstitucionais. Todos os demais foram declarados constitucionais e reitero que concordo com o ilustre relator, inclusive salientando o último deles, qual seja, a inexistência da alegação de violação da autonomia universitária.

No Brasil, num determinado momento confundiu-se a autonomia universidade com soberania total, como se fosse um estado dentro do próprio país. Ora, autonomia universitária tem as suas restrições, tem de respeitar também a legislação, como todas as demais organizações - como bem salientou o Ministro Marco Aurélio.

Em conclusão Presidente, divirjo, com todo respeito, do Ministro-Relator, somente nesses dois pontos. O meu voto é pela improcedência total da ação, e, consequentemente, pela constitucionalidade dos artigos específicos impugnados na ação movida pelo Conselho de Medicina.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14815916.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Eminentes Ministros, eminente Ministro-Relator, eminente Ministro que inaugurou a divergência e me precedeu, Ministro Alexandre de Moraes, subscrevo os cumprimentos de todos merecido pelo acutíssimo exame levado a efeito pelo eminente Ministro Marco Aurélio.

Senhora Presidente, para ser breve, tenho uma declaração de voto que espelha o estudo que fiz sobre essa matéria, o qual vai numa forma alongada de mais de três dezenas de páginas. Mas, acredito, temos o quadro delineado, e, independentemente de alguma diversidade de fundamentação, isso me permite sumariar bastante a intervenção e, de modo breve, expor o voto que trago à colação.

Compreendo que não estamos a fazer, e não se fez isso evidentemente nos votos que me antecederam, um juízo de valor sobre a política pública. A questão está nos paradigmas constitucionais de controle a ensejar a evidente constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O eminente Ministro-Relator suscitou como inconstitucionais dois pontos que o levaram ao inaugurar a divergência pelo eminente Ministro Alexandre Moraes.

O primeiro decorre do artigo 16 dessa Lei decorrente de medida provisória, que dispensa a revalidação no programa. A questão colocada, e isso está na declaração de voto que trago, é se essa dispensa é ou não inconstitucional. O eminente Ministro-Relator concluiu pela inconstitucionalidade, a divergência conclui em sentido diverso.

Entendo que o inciso XIII do artigo 5º da Constituição estabelece um parâmetro de controle que remete ao legislador a fixação dessas condições. E creio que é uma espacialidade, a qual, com todas as vênias aos que compreendem em sentido diverso, não é dado ao Poder Judiciário adentrar, eis que foi deferida ao legislador e à lei. Estejamos ou não de acordo com a política pública, não é isso o que se coloca, mas, no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14187314.

meu modo de ver, o plano de controle do paradigma de constitucionalidade. E, se a Constituição abre possibilidades, no meu entendimento, ela também estabelece limite. E aqui é um limite de deferência ao legislador.

Portanto, nesse ponto, como está na declaração de voto que farei juntar aos autos, acompanho a divergência para entender que não há irrazoabilidade de fundo constitucional do ponto de vista do estrito paradigma de controle da constitucionalidade. Assim sendo, entendo que o artigo 16, nesse aspecto, não ofende à Constituição. E eventual contradição que ele tenha, como, por exemplo, pode ter com a LDB, diz respeito a um controle de infraconstitucionalidade que não é espacialidade deste Tribunal adentrar. Em meu modo de ver, aqui há um juízo de contenção, sob pena de nós eventualmente elastecermos hipertrofiadamente as atribuições desta Corte.

E, no segundo ponto, também estou a acompanhar a divergência. Essas formas e condições de pagamento não me parecem que, do ponto de vista estritamente do paradigma constitucional, afrontam o parâmetro de controle. Por isso, também neste ponto, estou a acompanhar a divergência.

Peço todas as vênias ao eminente Ministro-Relator nos dois pontos que levaram à inauguração da divergência e acompanho a conclusão da divergência pela improcedência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14187314.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. MARCO AURÉLIO**
REQTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: MARCO AURELIO DE SOUZA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: LUIZ HENRIQUE PRESCENDO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADV.(A/S)	: JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

V O T O - V O G A L

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado relatório proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio.

Assento, preliminarmente, a plena cognoscibilidade da ação direta autuada sob n. 5.035. A autora detém legitimidade para a iniciativa do controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da CRFB, conforme já assentou este Tribunal quando do julgamento da ADI-MC 5.501, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.07.2017.

No que tange à ADI 5.037, a entidade autora "Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU" não ostenta legitimidade ativa para a propositura da ação.

Com efeito, nos termos do art. 103, IX, da CRFB, detêm legitimidade para a propositura "confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional".

Ao interpretar esse dispositivo, este Tribunal tem exigido que a confederação sindical deve apresentar duplo registro, ou seja, não basta apenas o registro civil, no respectivo cartório de pessoas jurídicas, é preciso, ainda, o registro sindical no Ministério do Trabalho.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

Ocorre, porém, que, por meio de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, foi declarada a nulidade do registro sindical da autora, decisão que, posteriormente foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho e por este Supremo Tribunal Federal (ARE 919995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/12/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09/12/2015 PUBLIC 10/12/2015).

Mais recentemente, o e. Ministro Celso de Mello proferiu decisão monocrática na ADI 4.380 reconhecendo a perda superveniente da legitimidade processual da mesma entidade autora da ADI 5.037. Deve-se consignar que tal decisão transitou em julgado em 21.04.2017.

Por essa razão, a ausência do duplo registro é razão impeditiva para o conhecimento da ADI 5.037, ante a ilegitimidade da confederação requerente.

No que se refere à conversão da medida provisória em lei, o que, na linha de precedentes desta Corte, poderia dar ensejo à perda de objeto da ação direta, é preciso registrar que, por meio da Petição 14357/2015, houve pedido de aditamento a fim de que, no que tange às impugnações de ordem material, seja reconhecido o interesse da autora na continuidade do julgamento. Não há, portanto, impedimento para que a ação possa ter continuidade.

A Associação Médica Brasileira argui a inconstitucionalidade da MP 621/13 convertida na Lei 12.871. A norma tem o seguinte teor:

> "CAPÍTULO I
> DISPOSIÇÕES GERAIS
> Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos:
> I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;
> II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País;
> III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação;

IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;

V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;

VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;

VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS; e

VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações:

I - reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos;

II - estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e

III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE MEDICINA

Art. 3º A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

privada, será precedida de chamamento público, e caberá ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre:

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, ouvido o Ministério da Saúde;

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos gestores locais do SUS;

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior privada especializada em cursos na área de saúde;

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento de curso de Medicina; e

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento público.

§ 1º Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão ser consideradas, no âmbito da região de saúde:

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços, ações e programas:

a) atenção básica;

b) urgência e emergência;

c) atenção psicossocial;

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e

e) vigilância em saúde.

§ 2º Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior vencedora do chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários para a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina.

§ 3º O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação desta Lei.

§ 5º O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no inciso II do § 1º deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de Medicina em unidades hospitalares que:

I - possuam certificação como hospitais de ensino;

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus serviços.

§ 6º O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de graduação na área de saúde.

§ 7º A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes):

I - os seguintes critérios de qualidade:

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos especializados, equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação dos estudantes de Medicina;

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos;

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas;

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de serviços de saúde, incluindo dados relativos à:

a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno;

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na região;

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e da região em que a instituição se localiza.

CAPÍTULO III

DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

deste artigo constitui ponto de auditoria nos processos avaliativos do Sinaes.

Art. 5º Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos cursos de graduação em Medicina do ano anterior.

Parágrafo único. A regra de que trata o caput é meta a ser implantada progressivamente até 31 de dezembro de 2018.

Art. 6º Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5º, será considerada a oferta de vagas de Programas de Residência Médica nas seguintes modalidades:

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; e

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes especialidades:

a) Genética Médica;

b) Medicina do Tráfego;

c) Medicina do Trabalho;

d) Medicina Esportiva;

e) Medicina Física e Reabilitação;

f) Medicina Legal;

g) Medicina Nuclear;

h) Patologia; e

i) Radioterapia.

Art. 7º O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade terá duração mínima de 2 (dois) anos.

§ 1º O primeiro ano do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade será obrigatório para o ingresso nos seguintes Programas de Residência Médica:

I - Medicina Interna (Clínica Médica);

II - Pediatria;

III - Ginecologia e Obstetrícia;

IV - Cirurgia Geral;

V - Psiquiatria;

VI - Medicina Preventiva e Social.

§ 2º Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade para os demais Programas de Residência Médica, conforme disciplinado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), excetuando-se os Programas de Residência Médica de acesso direto.

§ 3º O pré-requisito de que trata este artigo apenas será exigido quando for alcançada a meta prevista no parágrafo único do art. 5º, na forma do regulamento.

§ 4º Os Programas de Residência Médica estabelecerão processos de transição para implementação, integração e consolidação das mudanças curriculares, com o objetivo de viabilizar a carga horária e os conteúdos oferecidos no currículo novo e permitir o fluxo na formação de especialistas, evitando atrasos curriculares, repetições desnecessárias e dispersão de recursos.

§ 5º O processo de transição previsto no § 4º deverá ser registrado por meio de avaliação do currículo novo, envolvendo discentes de diversas turmas e docentes.

§ 6º Os Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade deverão contemplar especificidades do SUS, como as atuações na área de Urgência e Emergência, Atenção Domiciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde Coletiva e Clínica Geral Integral em todos os ciclos de vida.

§ 7º O Ministério da Saúde coordenará as atividades da Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade no âmbito da rede saúde-escola.

Art. 8º As bolsas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade poderão receber complementação financeira a ser estabelecida e custeada pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

Art. 9º É instituída a avaliação específica para curso de graduação em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do Ministro de Estado da Educação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

§ 1º É instituída avaliação específica anual para os Programas de Residência Médica, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, pela CNRM.

§ 2º As avaliações de que trata este artigo serão implementadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do sistema federal de ensino.

Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da matriz curricular para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação.

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao Ministro de Estado da Educação.

Art. 11. A regulamentação das mudanças curriculares dos diversos programas de residência médica será realizada por meio de ato do Ministério da Educação, ouvidos a CNRM e o Ministério da Saúde.

Seção Única

Do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde

Art. 12. As instituições de educação superior responsáveis pela oferta dos cursos de Medicina e dos Programas de Residência Médica poderão firmar Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, na qualidade de gestores, com a finalidade de viabilizar a reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas de Residência Médica e a estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade, além de permitir a integração ensino-serviço na área da Atenção Básica.

§ 1º O Contrato Organizativo poderá estabelecer:

I - garantia de acesso a todos os estabelecimentos assistenciais sob a responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

graduação e da residência médica; e

II - outras obrigações mútuas entre as partes relacionadas ao funcionamento da integração ensino-serviço, cujos termos serão levados à deliberação das Comissões Intergestores Regionais, Comissões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, ouvidas as Comissões de Integração Ensino-Serviço.

§ 2º No âmbito do Contrato Organizativo, caberão às autoridades mencionadas no caput, em acordo com a instituição de educação superior e os Programas de Residência Médica, designar médicos preceptores da rede de serviços de saúde e regulamentar a sua relação com a instituição responsável pelo curso de Medicina ou pelo Programa de Residência Médica.

§ 3º Os Ministérios da Educação e da Saúde coordenarão as ações necessárias para assegurar a pactuação de Contratos Organizativos da Ação Pública Ensino-Saúde.

CAPÍTULO IV

DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamento e os recessos.

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, prorrogável por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à sua aprovação nas avaliações periódicas.

§ 3º O primeiro módulo, designado acolhimento, terá duração de 4 (quatro) semanas, será executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de saúde brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da Atenção Básica em saúde,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde, à língua portuguesa e ao código de ética médica.

§ 4º As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e compreenderão o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o médico participante está apto ou não a continuar no Projeto.

§ 5º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas avaliações de que tratam os §§ 1º a 4º, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a programação em módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de aprovação e reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e profissional.

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1º sujeitam-se à legalização consular gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 3º A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, para todos os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão médica e à tutoria acadêmica.

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(Vide Decreto nº 8.126, de 2013) (Vide Lei nº 13.333, de 2016)

§ 1º (VETADO).

§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.

§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de registro único.

§ 5º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM.

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto.

(Vide Lei nº 13.333, de 2016)

§ 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o caput aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular.

§ 2º Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente.

§ 4º Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao disposto neste artigo.

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

(RGPS), na condição de contribuinte individual, na forma da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os médicos intercambistas:

I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais que prevejam cobertura securitária específica; ou

II - filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil.

Art. 21. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil que descumprirem o disposto nesta Lei e nas normas complementares:

I - advertência;

II - suspensão; e

III - desligamento das ações de aperfeiçoamento.

§ 1º Na hipótese do inciso III do caput, poderá ser exigida a restituição dos valores recebidos a título de bolsa, ajuda de custo e aquisição de passagens, acrescidos de atualização monetária, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

§ 2º Na aplicação das penalidades previstas neste artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 3º No caso de médico intercambista, o desligamento do Programa implicará o cancelamento do registro único no Ministério da Saúde e do registro de estrangeiro.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, a coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil comunicará o desligamento do médico participante ao CRM e ao Ministério da Justiça.

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

programas dos Ministérios da Saúde e da Educação.

§ 1º As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço.

§ 2º O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.

§ 3º A pontuação adicional de que trata o § 2º não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2º deste artigo.

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º terá validade até a implantação do disposto no parágrafo único do art. 5º desta Lei.

§ 5º Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o caput.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com transferência de recursos.

Art. 24. São transformadas, no âmbito do Poder Executivo, sem aumento de despesa, 117 (cento e dezessete) Funções Comissionadas Técnicas (FCTs), criadas pelo art. 58 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, do nível FCT-13, em 10 (dez) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo 2 (dois) DAS-5 e 8 (oito) DAS-4.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

Art. 25. São os Ministérios da Saúde e da Educação autorizados a contratar, mediante dispensa de licitação, instituição financeira oficial federal para realizar atividades relacionadas aos pagamentos das bolsas de que trata esta Lei.

Art. 26. São a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) autorizados a conceder bolsas para ações de saúde, a ressarcir despesas, a adotar outros mecanismos de incentivo a suas atividades institucionais e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do Programa Mais Médicos, observada a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.

Art. 27. Será concedida bolsa para atividades de preceptoria nas ações de formação em serviço nos cursos de graduação e residência médica ofertados pelas instituições federais de educação superior ou pelo Ministério da Saúde.

§ 1º Integram as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção de que trata o § 4º do art. 12 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a serem estabelecidas em ato do Ministério da Educação, o exercício profissional no SUS, na área de docência do professor, a preceptoria de que trata esta Lei e o exercício de atividade nos programas definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde.

§ 2º Com vistas a assegurar a universalização dos programas de residência médica prevista no art. 5º desta Lei, poderão ser adotadas medidas que ampliem a formação de preceptores de residência médica.

Art. 28. Os médicos participantes e seus dependentes legais são isentos do pagamento das taxas e dos emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, e no Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de janeiro de 1985.

Art. 29. Para os efeitos do art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, os valores percebidos a título de bolsa previstos nesta Lei e na Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, não caracterizam contraprestação de serviços.

Art. 30. O quantitativo dos integrantes dos projetos e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

programas de aperfeiçoamento de que trata esta Lei observará os limites dos recursos orçamentários disponíveis.

§ 1º O quantitativo de médicos estrangeiros no Projeto Mais Médicos para o Brasil não poderá exceder o patamar máximo de 10% (dez por cento) do número de médicos brasileiros com inscrição definitiva nos CRMs.

§ 2º O SUS terá o prazo de 5 (cinco) anos para dotar as unidades básicas de saúde com qualidade de equipamentos e infraestrutura, a serem definidas nos planos plurianuais.

§ 3º As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos nesta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias destinadas aos Ministérios da Educação, da Defesa e da Saúde, consignadas no orçamento geral da União.

Art. 31. Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde poderão editar normas complementares para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 32. A Advocacia-Geral da União atuará, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, na representação judicial e extrajudicial dos profissionais designados para a função de supervisor médico e de tutor acadêmico prevista nos incisos II e III do art. 15.

Art. 33. A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o .....

.....

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.

…."

(NR)

"Art. 4o .....……..

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

….....

.....

IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2o desta Lei;

„„.....

Parágrafo único. .....

.....

V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos; e

....." (NR)

Art. 34. O art. 1o da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3o, 4o e 5o:

"Art. 1o .....

.....

§ 3o A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil.

§ 4o As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 5o As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo deverão encaminhar, anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as ações de saúde pública." (NR)

Art. 35. As entidades ou as associações médicas que até a data de publicação desta Lei ofertam cursos de especialização não caracterizados como Residência Médica encaminharão as relações de registros de títulos de especialistas para o Ministério da Saúde, para os fins previstos no § 5º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

No que tange ao vício formal alega pela inicial relativo aos pressupostos de relevância e urgência, não há, na medida inquinada, traço de inconstitucionalidade a ser reconhecido por esta Corte.

Tem-se que a Medida Provisória é espécie normativa de competência exclusiva do Presidente da República e excepcional, pois sujeita às exigências de relevância e urgência.

Editada a Medida Provisória, compete ao Poder Legislativo realizar o seu controle. Frise-se que este último é, a um só tempo, político e jurídico, pois se debruça sobre a análise das circunstâncias (urgência e relevância) exigidas pela própria Constituição para a sua edição. Nesse sentido é o magistério de Clève Clèmerson Merlin:

> "O controle parlamentar assume dupla dimensão: é político e jurídico, a um só tempo. A atividade do legislativo não é absolutamente livre, circunscrevendo-se às diretrizes, normas e princípios aprovados pelo Constituinte. Por isso, o Congresso Nacional haverá de formular juízo político, mas também jurídico, no tocante à admissibilidade (concretização dos pressupostos de edição) da medida provisória. É inegável que, nesse particular, a dimensão política do controle vai prevalecendo sobre a jurídica. Superada esta fase e apreciado o conteúdo da medida provisória desde a perspectiva de sua compatibilidade com a Constituição, os critérios da conveniência e oportunidade orientarão a manifestação congressual (conversão ou rejeição). Aliás, a constitucional é questão prejudicial desta. Nesse ponto, a apreciação do Congresso não deve ser mais do que jurídica. Havendo a compatibilidade da matéria disciplinada pela medida com a Lei Fundamental, superada a questão prejudicial, o Parlamento estará livre par apreciar politicamente o ato legislativo provisório." (CLÈVE, Clèmerson Merlin. *Medidas Provisórias*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.183-185).

Sob essas lentes, cumpre observar que apesar da inviabilidade da convalidação, pela lei de conversão, de eventuais inconstitucionalidades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

da medida provisória, no caso em apreço não se está diante de hipótese de inconstitucionalidade formal à exigir intervenção judicial.

É verdade que a jurisprudência desta Corte evoluiu quanto o controle judicial dos requisitos de urgência e relevância das medidas provisórias, mas ressaltou que tal controle só pode ser exercido em situações excepcionais.

Sobre a evolução do controle judicial dos pressupostos de edição de MP, esclarece o e. Relator, Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento do RE 592.377, Redator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015, Tema 33 da Repercussão Geral:

> "Em um primeiro momento, o entendimento foi de admiti-lo apenas em casos de "excesso do poder de legislar", devendo ficar a apreciação por conta, em princípio, do Chefe do Poder Executivo e do Congresso Nacional (Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 162, da relatoria do ministro Moreira Alves, julgada em 14 de dezembro de 1989, Diário da Justiça de 19 de setembro de 1997). Sem dúvida, a óptica, se não incentivou, ao menos não impediu a reedição indefinida das medidas provisórias, de início com números diversos e, após, mediante repetição numérica seguida de dígito a revelar o número da reedição. Aos poucos, o Tribunal, em face dos abusos a demonstrarem a usurpação da atividade do Poder Legislativo, intensificou o controle de constitucionalidade dos pressupostos contidos na cabeça do artigo 62 da Carta, minimizando o caráter de "questões políticas" e passando a assentar inconstitucionais medidas carentes de urgência e relevância. Ao apreciar, em 16 de abril de 1998, o pedido liminar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.753/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence – acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de junho de 1998 –, o Plenário, por unanimidade, suspendeu a eficácia de dispositivos da Medida Provisória nº 1.577-6, de 1997, por afronta ao aludido artigo 62. Na ocasião, fiz ver:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

> Os predicados da relevância e da urgência estão previstos no artigo 62 da Constituição Federal, de que esta Corte é guarda como um grande todo. Logo, cabe-lhe perquirir - e se admite, até mesmo, o controle de atos discricionários quanto ao motivo, à finalidade, à razão da prática - se, na espécie, concorreram, ou não, esses dois requisitos previstos no artigo 62 da Constituição Federal. E a toda evidência não concorreram.
>
> Atualmente, não mais existe oscilação na jurisprudência do Tribunal a respeito da possibilidade de controle de constitucionalidade das medidas provisórias sob o ângulo do atendimento aos requisitos do artigo 62 – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.736/DF, relator ministro Cezar Peluso, julgada em 8 de setembro de 2010, Diário da Justiça de 29 de março de 2011."

Embora tenham os demais integrantes do Colegiado aquiescido quanto a esse fundamento, o Tribunal, quando do julgamento de mérito, acompanhou o voto do saudoso Ministro Teori Zavascki que, em sua manifestação, sublinhou a excepcionalidade do controle a ser exercido pela Corte:

> "Por ora, não está em debate a questão de mérito da medida provisória. Até porque, quanto à sua higidez material, o Supremo Tribunal Federal considerou que não havia inconstitucionalidade nas disposições normativas que estabeleciam para o sistema financeiro critérios de remuneração diferentes dos da Lei de Usura. Há súmula do Tribunal no tema (Súmula 648/STF), e a controvérsia suscitou, inclusive, uma discussão fértil a respeito da cobrança da comissão de permanência.
>
> O que subsiste, aqui, como argumento fundamental, é a falta dos requisitos de relevância e urgência da matéria. Esse é o tema fundamental. Como bem ressaltou o Ministro Relator, o Supremo Tribunal Federal considera sindicável, pelo Poder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

> Judiciário, a presença ou não desses requisitos. Isso porque a invocação vazia desses parâmetros, antes de justificar a atuação da Presidência da República no campo da normatividade primária, revela exercício abusivo de prerrogativa política. Todavia, os precedentes da Corte têm enfatizado que o escrutínio a ser feito pelo Judiciário neste particular é de domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal desses requisitos. É o que ficou proclamado, por exemplo, na ADI 4350, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/14; na ADC 11 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 29/6/07; e na ADI´s 1910 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/2/04."

Ou seja, apesar da jurisprudência deste Tribunal ter se consolidado no sentido da possibilidade de controle judicial dos pressupostos para a edição de medidas provisórias, "o Poder Judiciário deve reconhecer a inconstitucionalidade de texto de medida provisória que, de forma inquestionável, se afaste dos requisitos de relevância e urgência" (ADI 4.350, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03.12.2014).

A forma de se realizar esse controle deve depender da motivação apresentada pelo Chefe do Poder Executivo. Como indica Clèmerson Merlin Clève, a motivação, embora não seja requisito constitucional expresso, facilita o controle da legitimidade e dos requisitos constitucionais autorizadores, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário.

Não estão presentes, *in casu*, tais requisitos.

Acolhendo a ressalva feita por Clèmerson Merlin Clève, é preciso advertir que os conceitos de relevância e urgência não são, a rigor, passíveis de completa definição *a priori* (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 88). Nada obstante, ainda na esteira da lição do Professor da Universidade Federal do Paraná:

> "Possui relevância aquilo que é importante, proeminente, essencial, exigível, fundamental ou indispensável. Quanto às medidas provisórias, a relevância demandante de sua adoção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

> não comporta satisfação de interesses outros que não os da sociedade. A relevância há, portanto, de vincular-se unicamente à realização de um interesse público.
>
> De outro ângulo, a relevância autorizadora da deflagração da competência normativa do Presidente da República não se confunde com a ordinária, desafiadora do processo legislativo comum. Trata-se, antes, de relevância extraordinária, excepcional, especialmente qualificada, contaminada pela contingência, acidentalidade, imprevisibilidade."
>
> (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 89-90).

Do ponto de vista da relevância é preciso realçar que a prioridade atribuída ao tema pelo constituinte é evidente:

> "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."
>
> (...)
>
> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
>
> Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado."

Não por outra razão, a matéria é de competência comum de todos os entes federados (art. 23, II, CRFB).

A jurisprudência desta Corte tem, por sua vez, reconhecido que o tema é da mais alta relevância para o país, como destacou, por exemplo, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

e. Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento da ADPF 54, Pleno, DJe 29.04.2013. De modo mais específico, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do MS 32.238, fez consignar que o programa instituído pela medida provisória "configura uma política pública da maior importância social, sobretudo ante a comprovada carência de recursos humanos na áreas médica no âmbito do Sistema Único de Saúde".

Na exposição de motivos da medida impugnada nesta ação direta, é possível depreender que as preocupações externadas pelos órgãos do Poder Executivo vão ao encontro da relevância outorgada pelo constituinte ao direto fundamental à educação:

> "1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Medida Provisória que institui o Programa Mais Médicos, com a finalidade de:
>
> I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;
>
> II - fortalecer a prestação de serviços na atenção básica em saúde no País;
>
> III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação;
>
> IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;
>
> V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desenvolvidas pelos médicos;
>
> VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;
>
> VII - aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de saúde

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

> do País e na organização e funcionamento do SUS; e
>
> VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas no SUS.
>
> 2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define a saúde como direito da sociedade e responsabilidade do Estado, dando as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, o qual tem como princípios e diretrizes a universalidade, a equidade, a integralidade da atenção, a regionalização, a descentralização, a hierarquização e a participação social.
>
> 3. Por seu turno, o inciso III do artigo 200 da Constituição Federal de 1988 confere ao SUS a ordenação da formação de recursos humanos em saúde, cujo mercado de trabalho atualmente compõe-se de mais de 3 milhões de trabalhadores que necessitam de constante qualificação e reivindica aperfeiçoamento dos novos profissionais.
>
> 4. Por sua vez, o artigo 209 da Constituição Federal estabelece a livre oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que atendidas às condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. A oferta de educação superior de qualidade é fundamental para o processo de desenvolvimento nacional e melhoria da qualidade de vida da população."

No tocante ao pressuposto da urgência, a matéria deve ser examinada levando-se em consideração o já esposado entendimento da Corte, que exige comprovação acerca da inexistência da urgência. Ou seja, *"Trata-se de informações de alta indagação, que não podem ser convincentemente contraditadas por pronunciamentos especulativos, sem embasamento científico seguro. Nessas matérias de relevância e urgência se deve partir – e essa parece ser a jurisprudência do Supremo – da legitimidade das alegações, dessa fundamentação do poder normativo constituído."* (trecho do voto do Min. Teori Zavascki no supracitado RE 592.377).

Da leitura da Exposição de Motivos da MP, percebe-se que o Chefe do Poder Executivo, através do Ministro da Saúde, não se descurou de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

justificar a urgência da edição da medida, nos seguintes termos:

> "(...)
>
> 5. O Plano Nacional de Saúde - 2012/2015 do Ministério da Saúde aponta como estratégia fundamental para o enfrentamento dos principais problemas de acesso da população às ações e serviços de saúde com qualidade a organização do sistema de saúde baseado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) que consistem em estruturas integradas de provisão de ações e serviços de saúde assegurados pelo SUS e tem como princípio a construção de uma intervenção unificada do Ministério da Saúde em articulação com estados, Distrito Federal e municípios.
>
> 6. Essas redes demandam ampliação da oferta de serviços públicos de saúde, sendo que com a expansão prevista até 2014 através exclusivamente dos investimentos do Ministério da Saúde, serão criados mais 35.073 postos de trabalho médico.
>
> 7. As Redes de Atenção à Saúde devem ser ordenadas pela Atenção Básica à Saúde, que é a porta de entrada prioritária do SUS. Esta se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades. Essa modalidade de atenção orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
>
> 8. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia de Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo possível verificar que o Brasil avançou muito nas últimas décadas nesta área. Entretanto, o país convive com muitos vazios assistenciais, que correspondem a localidades que não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

conseguiram prover e fixar profissionais de saúde na atenção básica, em especial os médicos, não garantindo acesso aos serviços básicos de saúde por parte da população brasileira.

9. Compreende-se que a atenção básica bem estruturada possibilita a resolução de até 85% dos problemas de saúde, contribuindo assim para ordenar as Redes de Atenção à Saúde – RAS e organizar a demanda para outros serviços, tais como os de urgência e emergência.

10. Ressalte-se, ainda, que na 14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2011, foi aprovada como diretriz que todas as famílias e todas as pessoas devem ter assegurado o direito a uma equipe de saúde da família.

11. O Brasil possui 359.691 médicos ativos e apresenta uma proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 (mil) habitantes, conforme dados primários obtidos no Conselho Federal de Medicina (CFM) e na estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

12. A proporção de médico/1.000 habitantes constatada no Brasil é menor do que em outros países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante ou países que têm sistemas universais de saúde, a saber: Canadá 2,0; Reino Unido 2,7; Argentina 3,2; Uruguai 3,7; Portugal 3,9; Espanha 4,0 e Cuba 6,7 (*Estadísticas Sanitarias Mundiales* de 2011 e 2012 – Organização Mundial da Saúde – OMS).

13. Não existe parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médico por habitante reconhecido e validado internacionalmente. Para tanto, utiliza-se como referência a proporção de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, que é a encontrada no Reino Unido, país que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter universal orientado pela atenção básica. Nesse cenário, para que o Brasil alcance a mesma relação de médicos por habitante seriam necessários mais 168.424 médicos. Mantendo-se a taxa atual de crescimento do número de médicos no país, o atingimento dessa meta só será viável em 2035.

14. A distribuição dos médicos nas regiões do país

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

demonstra uma grande desigualdade, com boa parte dos estados com uma quantidade de médicos abaixo da média nacional. A tabela abaixo demonstra essa distribuição (IBGE/2012 e CFM/2012):

(...)

15. Mesmo os estados com mais médicos que a média nacional apresentam importantes diferenças regionais. Um exemplo disso é o Estado de São Paulo que, em apenas cinco de suas regiões, apresenta um número superior a 1,8 médicos a cada mil habitantes (Demografia Médica no Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, 2012).

16. Uma das explicações para esse quadro está relacionada ao número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina. Apesar de um número absoluto de escolas médicas maior do que alguns países (são 200 escolas médicas), ao analisar-se a proporção de vagas de ingresso para cada 10.000 (dez mil) habitantes, o país apresenta índice significativamente inferior.

17. Enquanto o Brasil tem o índice de 0,8 vaga a cada 10.000 habitantes, outros países têm índices maiores, a saber: Austrália 1,4; Reino Unido 1,5; Portugal 1,6 e Argentina 3,1. Além disso, há estados em que esse índice é ainda menor, tais como Maranhão e Bahia (0,39).

18. A escassez de médicos em diversas regiões se manifesta em análises realizadas sobre o mercado de trabalho, como no estudo "Demografia do Trabalho Médico", do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Consoante esse estudo, entre os anos de 2003 e 2011, para 93.156 egressos dos cursos de medicina foram criados 146.857 empregos formais. Cabe considerar que nestes dados não estão incluídos os médicos que optam por ingressar na residência médica, médicos cooperativados ou autônomos. Desse modo, é possível concluir que uma parcela significativa dos médicos recém-graduados já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

ingressa no mercado de trabalho com a possibilidade de exercer mais de um emprego formal.

19. A população brasileira percebe e manifesta o desconforto com essa escassez de médicos, que tem impacto no acesso ao SUS. Em estudo do Sistema de Indicadores de Percepção Social, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em 2011, 58,1% dos 2.773 entrevistados disseram que a falta de médicos é o principal problema do SUS. No mesmo estudo, a resposta mais frequente como sugestão de melhoria para o sistema de saúde foi de aumentar o número de médicos.

20. Desse modo, encontramos um quadro de extrema gravidade, no qual alguns estados apresentam um número insuficiente de médicos e de vagas de ingresso na graduação, com ausência de expectativa de reversão desse quadro a curto e médio prazos, caso não haja medidas indutoras implementadas pelo Estado. Nesse cenário, a expansão de 2.415 vagas de cursos de medicina, anunciada pelo MEC em 2012, só contribuiria para atingir o número de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes no ano de 2035.

21. O Ministério da Educação autorizou em 2012 a oferta de cerca de 800 vagas privadas em cursos de medicina. Em que pese o aumento de vagas, o atual momento exige a adoção de iniciativas estatais para criar e ampliar vagas em cursos de medicina nos vazios de formação e de assistência, a partir do papel indutor do Estado na regulação da educação superior. Com isso, incentiva-se a criação de instituições de educação superior voltadas à área da saúde e à oferta de cursos de medicina nessas regiões. A autorização para oferta de cursos de medicina obedecerá a uma regulação educacional específica, com a publicação de chamamentos públicos às instituições de educação superior interessadas em se habilitar para atuação nas regiões que apresentem vulnerabilidade social, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação.

22. Além disso, entende-se que é fundamental agregar novas ações para garantir a ampliação da formação de médicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

para a atenção básica no país, possibilitando à população brasileira o acesso ao sistema de saúde de qualidade.

23. Uma das iniciativas é a ampliação de 12.000 novas vagas de residência médica acompanhadas da oferta de bolsas, a serem implementadas até 2017, uma vez que se entende a importância dessa modalidade para a fixação de profissionais. Estudo recente denominado Migramed, do Observatório de Recursos Humanos de São Paulo/ObservaRH, de 2012, demonstra que 86% dos médicos permanecem no local em que cursaram a graduação e a residência médica.

24. Uma das medidas proposta é a reformulação da grade curricular dos cursos de medicina, com acréscimo substancial de horas na formação específica na Atenção Básica. A presente Medida Provisória prevê que, para os ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1º de janeiro de 2015, a formação do médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares entre si, correspondendo o primeiro ciclo à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da carga horária não inferior a 7.200 horas, e o segundo ciclo ao treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos.

25. O segundo ciclo de formação será considerado componente curricular obrigatório do curso de graduação em medicina, inscrito no histórico escolar do estudante, e constituirá requisito para a obtenção do diploma de médico. Nesse período, o estudante fará jus ao recebimento de uma bolsa, com valor a ser definido pelo Ministério da Saúde. Poderá ainda ser aproveitado como uma etapa dos programas de residência médica ou de outro curso de pós-graduação.

26. Essa nova etapa representa uma importante estratégia para a formação médica, reforçando o conteúdo das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Medicina e apontando para a formação generalista de um profissional com senso de responsabilidade social e compromisso de cidadania.

27. Com vistas a enfrentar o problema da escassez de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

médicos no país, sobretudo em regiões prioritárias para o SUS, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios para os municípios que apresentem condições de receber médicos para preenchimento de vagas em equipes de atenção básica, nos termos da Política Nacional de Atenção Básica, devendo o município enquadrar-se em um dos seguintes grupos: a) G100 (municípios com população superior a 80.000 pessoas, com baixa receita per capita e alta vulnerabilidade econômica); b) municípios com 20% ou mais de sua população vivendo em extrema pobreza; c) áreas de maior vulnerabilidade de capitais e regiões metropolitanas; e d) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

28. Além disso, os Ministérios da Saúde e da Educação desenvolvem políticas para responder a necessidade de provimento e fixação de médicos nas diversas regiões do país. Nos anos de 2012 e 2013, foram realizadas chamadas nacionais para médicos, através do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica/PROVAB, ofertando a possibilidade de curso de especialização na modalidade integração ensino-serviço em regiões de extrema pobreza e periferias, com incentivo aos participantes mediante acréscimo na pontuação no processo seletivo da residência médica.

29. Na primeira edição do Programa, apesar de uma demanda significativa dos municípios por esses profissionais, somente 381 médicos foram vinculados. Na segunda edição do programa, aderiram 2.838 municípios que solicitaram 13.862 médicos para atuar na atenção básica, sendo que apenas 3.577 médicos foram vinculados ao Programa para atuação em 1.260 municípios.

30. Ainda assim, mesmo com aumento importante na participação de médicos, permanece um número significativo de vagas ociosas, correspondendo a 74,2% da demanda inicial (Sistema de Gerenciamento de Programas da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde).

31. Tendo em vista a situação descrita acima, a instituição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

do Projeto Mais Médicos para o Brasil visa possibilitar a seleção de médicos interessados em participar de ações de aperfeiçoamento em atenção básica, em regiões prioritárias para o SUS.

32. Para tanto, serão oferecidos cursos de especialização, concessão de bolsas-formação, bem como será garantida contínua supervisão e acesso a recursos de suporte clínico, a exemplo do Telessaúde.

33. Para execução do Projeto Mais Médicos para o Brasil, além da atuação dos Ministérios da Saúde e da Educação, poderão ser celebrados termos de adesão e compromisso com Estados, Distrito Federal e Municípios, além de instrumentos de cooperação com outros países, organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, entidades públicas e privadas.

34. Nesse sentido, o Projeto Mais Médicos para o Brasil selecionará médicos para participarem do Projeto, garantindo-se a prioridade para a escolha de médicos formados em instituições de educação superior nacionais ou com diploma revalidado. Na hipótese de permanecerem vagas não preenchidas, estas serão ofertadas primeiramente a médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior e, posteriormente, a médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior, mediante chamamento público internacional ou celebração de instrumentos de cooperação com organismos internacionais.

35. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de informações, o monitoramento e a pesquisa no tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arco-Sur.

36. Baseado nas premissas preconizadas pela OMS, não poderão ser selecionados médicos oriundos de países que apresentem relação estatística médico/habitante menor que a do Brasil.

37. Ressalte-se que tais medidas não são dotadas de ineditismo, pois diversos países já as adotaram, a exemplo de Reino Unido, Canadá e Austrália.

38. Mesmo países com indicadores de relação médico/habitante superiores a do Brasil recorreram a programas de recrutamento de médicos estrangeiros para garantir o acesso ao sistema de saúde, geralmente com enfoque em áreas remotas. Dados apresentados pela *Organisation for Economic Co-operation and Development* – OECD, em 2009, e pelo *General Medical Council* do Reino Unido, em 2011, demonstram as seguintes proporções de médicos estrangeiros nos respectivos países: 37% no Reino Unido; 25,9% nos Estados Unidos; 22,8% na Austrália e 17,9% no Canadá.

39. No Brasil o percentual de médicos estrangeiros é de 1,79%, conforme dados primários do Conselho Federal de Medicina (2013).

40. Além disso, o médico formado em instituição de educação superior estrangeira será submetido a processo de acolhimento e avaliação, a ser desenvolvido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, a fim de garantir a adaptação aos princípios e diretrizes do SUS, a adequação à realidade epidemiológica brasileira e a capacidade de comunicação em língua portuguesa.

41. Também está sendo proposta a criação, mediante transformação, sem aumento de despesa, de Funções Comissionadas Técnicas – FCT em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS. Os 10 (dez) cargos em comissão (dois DAS-5 e oito DAS-4) que se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

propõe criar serão alocados em unidades administrativas de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para que tenham condições de constituir estrutura que se incumbirá de novas competências e responsabilidades, especialmente as decorrentes do Programa Mais Médicos.

42. A opção pela transformação – em vez da simples criação dos cargos necessários – se dá com a finalidade de neutralizar potencial impacto nas despesas de pessoal, alternativa que, de resto, já foi adotada em outras oportunidades. Dessa forma, a medida proposta não apresenta impacto orçamentário, já que a remuneração total das cento e dezessete Funções Comissionadas Técnicas que deixarão de existir equivale à remuneração total dos dez novos cargos em comissão obtidos com a transformação.

43. Nesse sentido, não obstante a descrição das ações já adotadas e planejadas para mitigar a escassez de médicos no país, as medidas proporcionadas pela presente Medida Provisória contribuirão para a melhoria do cenário da Saúde, notadamente na área da Atenção Básica.

44. O impacto gerado quando da adoção das estratégias traçadas pelo Programa reflete, de forma direta, a abrangência e relevância de tal medida, uma vez que se dará um salto no ingresso de médicos diretamente nas áreas mais necessitadas de profissionais, como já amplamente demonstrado pelos dados lançados nesta Exposição de Motivos.

45. A reordenação dos recursos humanos na área da Saúde e a reformulação da grade curricular dos cursos de medicina – com acréscimo substancial de horas na formação específica na Atenção Básica – visam garantir o acesso a um sistema de saúde universal e de qualidade a toda população brasileira.

46. Por seu turno, no que se refere à urgência da Medida Provisória, é possível verificar que a eficácia das medidas propostas somente será alcançada pela agilidade de sua implementação, de forma coordenada e conjunta.

(...)"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

O parâmetro para se avaliar essas alegações é, como indicou o Min. Teori Zavascki em manifestação já referida neste voto, "*se deve partir (...) da legitimidade das alegações, dessa fundamentação do poder normativo constituído.*"

Nesse sentido, ainda que a parte ora requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da Medida Provisória impugnada nesta ação direta.

Quanto às alegações de inconstitucionalidade material, não há violação ao princípio constitucional do concurso público, nem imposição de servidão civil aos estudantes do curso de medicina, nem limitação territorial do exercício da profissão, nem, tampouco, temática ligada à racionalidade, cidadania e orçamento.

Em relação aos argumentos de ofensa ao art. 37, II, da CRFB, assiste razão jurídica ao Procurador-Geral da República, quando aduz que "a natureza jurídica das contratações é a definida no inciso IX do art. 37 da Constituição, que admite seleção simplificada para as contratações de pessoal por tempo determinado", o que demonstra amparo constitucional da exceção à regra do concurso.

No que tange à inconstitucionalidade relativa ao exercício ilegal da profissão (arts. 13, 15 e 16 da Lei e 7º, 9º e 10 da MP), o que, no entender da requerente, decorreria do fato de permitir o exercício da medicina a quem não revalidou seu diploma, é preciso observar que o dispositivo constitucional invocado, constante do art. 5º, XIII, da CRFB, garante a liberdade do trabalho, "atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Como se depreende da leitura do texto constitucional, as limitações ao livre exercício profissional dependem de lei que deverá prever qualificações necessárias para o seu exercício. Noutras palavras, devem haver qualificações para o exercício profissional e tais qualificações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

devem estar previstas em lei.

A previsão legal, ainda que por meio de medida provisória, atende ao comando constitucional. Além disso, não se pode dizer que a lei não preveja qualificações, embora ela as tenha fixado em condições diversas da que vigoravam anteriormente. Pode a lei, desde que observe os parâmetros constitucionais, revisar as qualificações anteriormente previstas.

É porque a lei preenche essas funções que também devem ser afastados os argumentos relativos à autonomia universitária ao fundamento de que não haveria como ser comprovado o conhecimento obtido pelos profissionais oriundos de outros países. A referência feita à formação no estrangeiro é tida como qualificação suficiente pela lei, opção política justificável à luz do art. 5º, XIII, da CRFB.

Os Conselhos Profissionais, como autarquias responsáveis pela fiscalização das qualificações estabelecidas em lei, devem limitar-se, nos termos do art. 37, XIX, da CRFB, ao controle de legalidade do exercício profissional, não se podendo falar em ofensa a sua autonomia, caso tenha a lei optado por qualificações distintas daquelas que anteriormente havia fixado.

É preciso consignar, ademais, que as informações apresentadas pela Advocacia-Geral da União atestam a celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no qual se prevê, expressamente, que os profissionais migrantes "gozem de oportunidade e de incentivos para melhorar a sua formação profissional, qualificações e estatuto, numa base de igualdade de tratamento com os profissionais de saúde formados a nível nacional".

Cumpre assentar que esse tipo de contratação está, em tese, contida na dispensa de licitação, a qual, por sua vez, prevista no art. 25 da Lei impugnada. A dispensa de licitação está contida na exceção prevista no art. 37, XIX, da CRFB, razão pela qual não se pode falar em ofensa a esse dispositivo. Isso não significa, porém, que tais atos não estejam sujeitos ao controle externo a cargo do Poder Legislativo, nem ao controle judicial, caso contenham vícios de legalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

Relativamente à alegação de ofensa ao princípio da proibição de servidão, aduz-se que a previsão constante do art. 16 da Lei, que dispõe que "as atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza", não prevê nenhum regramento salarial ou de limitação de jornada. Haveria, assim, no entender da requerente, proteção deficiente do direito ao trabalho.

Especificamente no que tange aos médicos intercambistas, conceito previsto no art. 13, § 2º, II, da Lei ("médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior"), a quem é proibido o exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos (art. 16), é preciso observar que, mesmo nessa condição, terão os médicos direito a perceber bolsas, nos termos do art. 19 da lei impugnada.

Não bastassem as remissões específicas ao caráter formativo do Programa, tal como se depreende, *v.g.*, dos arts. 13 a 15 da Lei, a referência a remuneração por meio de bolsa indica a opção feita pelo legislador pela natureza educacional do projeto, a afastar a alegação de que a ausência de vínculo empregatício poderia equivaler à servidão.

Em relação aos argumentos que sustentam violação do princípio da isonomia , é preciso registrar que o princípio da igualdade formal, como invocado pela requerente, proíbe que se instituam "discriminações ou tratamentos diferenciados baseados em fundamento que não seja razoável ou que não vise a um fim legítimo" (OSÓRIO, Aline; BARROS, Luís Roberto. "Sabe com quem está falando?" Notas sobre o princípio da igualdade no Brasil contemporâneo. In: Direto & Práxis Revista, Rio de Janeiro, Vol. 07, n. 13, p. 209).

Não é disso, porém, que trata a medida provisória atacada. Com efeito, a Lei estabelece, logo em seu art. 1º, I, que um de seus objetivos é "diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área a saúde". O fim é, sem dúvidas, legítimo, como se depreende da leitura do art. 196 da CRFB.

A contratação de profissionais estrangeiros é, sob essa perspectiva,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

adequada, porquanto não haveria tempo hábil para que, por meio apenas da formação de novos quadros, outros profissionais pudessem fazer os atendimentos destinados aos profissionais de outros países. A lei é, ainda, cautelosa em privilegiar os médicos que se formaram no Brasil, possivelmente para, nos termos do art. 1º, II e III, aprimorar a formação médica", além de "fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País".

Ademais, as informações apresentadas pelo autor da política pública, que detém capacidade institucional para formulá-las, dão conta de que é, realmente, baixo o número proporcional de médicos no Brasil, a justificar a edição da medida provisória.

Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 37, I, da CRFB, o acesso a cargos e funções públicas é também acessível a estrangeiros, observados os requisitos legais.

Assim, não é irrazoável, ao contrário, é proporcionalmente adequada a opção política formulada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação direta.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14166378.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Seguindo a sistemática e metodologia que tenho observado quando vou acompanhar posição já defendida no Plenário, reportando-me aos fundamentos que a embasaram e depois fazendo juntada de voto escrito, peço vênia à divergência para acompanhar o eminente Relator nos dois pontos em que entendeu inconstitucionais os dispositivos por ele elencados.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A913-536D-14BC-91C7 e senha B7A4-010D-AB2E-05DE

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Médica Brasileira – AMBR em face dos arts. 7º, I e II, §§ 1º e 2º, incisos I e II e § 3º; 9º, § 1º, incisos I, II e III; 10, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; e art. 11 da Medida Provisória nº 621 de 09.7.2013 (convertida na Lei nº 12.871/2013), que instituiu o Programa Mais Médicos.

Argumenta-se com inconstitucionalidade formal ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 62 da Constituição Federal. Descumprido estaria o requisito de urgência para a regulamentação de matéria relativa à saúde pública, à alegação de que "a criação de '*projeto mais médicos para o Brasil' em verdadeiro toque de caixa por medida provisória teve o único intuito de tentar abafar o clamor popular das manifestações ocorridas em todo território nacional que reclama apenas o cumprimento dos direitos fundamentais constitucionais dos cidadãos*.".

Argui-se a inconstitucionalidade material por violação dos arts. 5º, XIII, 37, II, 62, § 1º, "a" e "d", da Constituição Federal, ao argumento de que a autorização de intercâmbio internacional por médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior sem a exigência de validação do diploma e de domínio do idioma nacional configura tratamento não isonômico entre nacionais e estrangeiros e ofende o direito à saúde (arts. 5º, *caput*, 196 e 197 da Constituição Federal).

Afirma-se a precarização das relações sociais ante a recusa de formação de vínculo de emprego com o médico intercambista (art. 7º da Constituição Federal e art. 6º do Pacto de São José da Costa Rica),

Aponta-se ainda negação ao princípio da autonomia das universidades (art. 207 da Constituição Federal). Aduz que a flexibilização quanto à exigência de proficiência em língua portuguesa ofende o princípio da legalidade estrita contido no art. 5º, II, da Constituição Federal. Por fim, argumenta-se com ofensa à autonomia das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

entidades da classe médica e com violação da exigência de concurso público.

A autora sustenta a sua legitimidade ativa ancorada nos arts. 103, IX, da Constituição Federal e 2º, IX, da Lei nº 9.868/99 e na pertinência temática entre a sua atuação como entidade representante da classe médica de âmbito nacional e o interesse no resguardo da tutela da dignidade profissional do médico e da assistência de qualidade à saúde da população brasileira.

O Ministro Relator determinou o apensamento da ADI 5035 aos autos da ADI 5037.

A Advocacia-Geral da União informa que a decisão governamental de "*despriorizar o modelo de formação de especialistas em prol da formação de médicos generalistas e da família com atuação precipuamente básica*" não significa abandono da formação de especialistas, mas medida destinada à correção da carência de profissionais na área. Informa, outrossim, que a regulação das relações no âmbito do Projeto Mais Médicos se revela premente e inadiável, cumprindo o requisito de urgência. Aduz que a ausência de submissão da revalidação do diploma não reduz a qualidade do profissional, pois obrigatória a avaliação pessoal e presencial do profissional, inclusive sobre conhecimentos da língua portuguesa. Entende que não há ofensa à exigência de concurso público, pois não há vínculo efetivo com o bolsista ou com o intercambista.

Manifestam-se pela improcedência do pedido a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.

Nos dias 25 e 26/11/2013, foi realizada audiência pública para ouvir o depoimento de autoridades e especialistas sobre o "Programa Mais Médicos".

É o relatório.

Voto.

1. O Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos foi instituído pela MP 621/2013, convertida na Lei nº Lei nº 12.871/2013, pelo Governo Federal com a finalidade de implementar políticas públicas na área da saúde visando à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

melhoria dos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde. Desenvolve-se em três eixos: 1. provimento emergencial de profissionais, principalmente em regiões onde há escassez ou ausência de médicos; 2. reestruturação na formação médica, por meio de expansão da graduação e da residência médica; 3. melhoria na infraestrutura por meio de construção de novas unidades já existentes[1].

Relatório elaborado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, após dois anos de consolidação do Programa[2], aponta que, no ano de sua criação, a insuficiente proporção de 1,8 médicos por habitante, aliada à má distribuição desses profissionais no território, não correspondiam à necessidade da população e do Sistema Único de Saúde. As áreas com as populações mais pobres e vulneráveis contavam com menos médicos. Por meio da proposição da Nova Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), foram identificados dez principais desafios na atuação da Atenção Básica de Saúde (ABS), porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde:

> 1. Financiamento insuficiente da Atenção Básica.
>
> 2. Infraestrutura inadequada das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
>
> 3. Baixa informatização dos serviços e pouco uso das informações disponíveis para a tomada de decisões na gestão e na atenção à saúde
>
> 4. Necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera e garantindo atenção, em especial, aos grupos mais vulneráveis.
>
> 5. Necessidade de melhorar a qualidade dos serviços incluindo acolhimento, resolubilidade e longitudinalidade do cuidado.
>
> 6. Pouca atuação na promoção da saúde e no desenvolvimento de ações intersetoriais.

---

1 http://maismedicos.gov.br/conheca-programa

2 Programa Mais Médicos – Dois anos: Mais saúde para os Brasileiros: http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Livro_2_Anos_Mais_Medicos_Ministerio_da_Saude_2015.pdf

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

> 7. Desafio de avançar na mudança do modelo de atenção e na mudança de modelo e qualificação da gestão.
>
> 8. Inadequadas condições e relações de trabalho, mercado de trabalho predatório, déficit de provimento de profissionais e contexto de baixo investimento nos trabalhadores
>
> 9. Necessidade de contar com profissionais preparados, motivados e com formação específica para atuação na Atenção Básica.
>
> 10. Importância de ampliar a legitimidade da Atenção Básica com os usuários e de estimular a participação da sociedade

Nesse contexto, desenvolvido pelo Governo Federal o Programa Mais Médicos no esforço de enfrentar esses desafios com foco nos seguintes pontos: *"déficit de provimento de profissionais médicos; mercado de trabalho predatório e contexto de baixo investimento nos trabalhadores; necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera e garantindo atenção, em especial, aos grupos mais vulneráveis; infraestrutura inadequada das UBS; necessidade de contar com profissionais preparados, motivados e com formação específica para atuação na Atenção Básica."*.

2. Arguição de inconstitucionalidade formal por inobservado o art. 62 da Constituição Federal

Argumenta a autora com vício formal de constitucionalidade da Medida Provisória nº 621/2013 porquanto desconsiderados os pressupostos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal, ao disciplinar matéria afeta à saúde pública.

Com efeito, a Medida Provisória nº 621/2013, convertida na Lei nº 12.871/2013, teve por objeto instituir o Programa Mais Médicos com a finalidade de incrementar o gerenciamento de recursos humanos na área médica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Para tanto, instituiu medidas quantitativas e qualitativas, ou seja, direcionadas tanto ao aumento do número de médicos em regiões prioritárias, com o escopo de reduzir as desigualdades regionais, como à revisão dos parâmetros da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

formação médica no País.

Extraio da Exposição de Motivos da MP 621/2013, dados reveladores de cenário deficitário no número de médicos por habitantes no Brasil, com nítido impacto no acesso da população aos serviços de saúde. À época, o País contava com 359.691 médicos ativos, apresentando uma proporção de 1,8 médicos para cada mil habitantes[3], bem menor do que em países vizinhos como a Argentina (3,2) e o Uruguai (3,7), ou mesmo do que a proporção encontrada no Reino Unido (2,7), referência internacionalmente adotada como padrão ideal para a qualidade do atendimento na saúde pública.

Além do número insuficiente de médicos, são igualmente impactantes ao gerenciamento do sistema de saúde pública do País: as informações atinentes à profunda desigualdade na distribuição desses profissionais consideradas as regiões, com doze Estados apresentando quantidade de médicos abaixo da média nacional; e carência de oferta de vagas nos cursos de graduação em medicina (entre os anos de 2003 e 2011 foram 93.156 egressos para 146.857 empregos formais).

Nesse cenário, a edição da Medida Provisória visou a atender à necessidade de incremento da gestão da saúde pública no País, a justificar urgência e relevância no empenho pelo Poder Público alçar a população brasileira, notadamente aquela mais carente, à concretização do direito constitucional de acesso aos serviços de saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, imprescindível à realização dos valores supremos da segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça em que fundado o nosso Estado Democrático.

Com esses fundamentos, rejeito a inconstitucionalidade formal suscitada pela requerente.

3. Isonomia de tratamento no exercício da medicina e precarização das relações de trabalho

Os principais questionamentos situam-se na constitucionalidade dos dispositivos da MP quanto ao exercício da medicina no país por

3 Dados primários fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísca.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

estrangeiros e por brasileiros formados em instituições estrangeiras no âmbito do Programa Mais Médicos sem submissão às mesmas exigências impostas aos brasileiros formados em instituições de educação superior brasileiras; bem como à precarização das relações de trabalho pela vedação de configuração de vínculo de emprego.

A participação no Programa dispensa a revalidação do diploma no País e determina aos Conselhos Regionais de Medicina a expedição de registro provisório sem qualquer tipo de fiscalização. Interessante notar que a Lei nº 12.842, publicada um dia após a MP 621/2013, em 10.7.2013 (*vacatio legis* de 60 dias), em seu art. 6º dispõe que a denominação "médico" é privativa do graduado em **curso reconhecido** e deverá constar dos diplomas emitidos por instituições de educação credenciadas na forma do art. 46 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)[4] .

No que exclui a possibilidade de vínculo empregatício, a Medida Provisória nega aos participantes do Projeto os direitos sociais fundamentais previstos no art. 7º da Constituição Federal, em nítida precarização das relações de trabalho.

Pelo trabalho desempenhado no Projeto, os médicos recebem apenas bolsas nas modalidades bolsa-formação, bolsa-supervisão e bolsa-tutoria, ajuda de custo destinada a compensar a instalação e as despesas de deslocamento. O art. 23 deixa claro que os valores percebidos a título de bolsa não caracterizam contraprestação de serviços. Nada obstante, a

---

4 Art. 6º–A denominação 'médico' é privativa do graduado em curso superior de Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nart. 46 da Lei nart. 46 da Lei nº art. 46 da Lei nart. 46 da Lei nº art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)art. 46 da Lei nart. 46 da Lei nº art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)art. 46 da Lei nart. 46 da Lei nº art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a denominação 'bacharel em Medicina' (Redação dada pela Lei nº 134.270, de 2016)(Redação dada pela Lei nº 134.270, de 2016)(Redação dada pela Lei nº 134.270, de 2016)(Redação dada pela Lei nº 134.270, de 2016)(Redação dada pela Lei nº 134.270, de 2016)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

própria finalidade do Projeto Mais Médicos de ampliar a atuação médica no âmbito do SUS, denuncia verdadeira contratação para o exercício da medicina sob a aparência de atuação exclusiva no âmbito de ensino, pesquisa e extensão.

Destaque-se que o site do Programa Mais Médicos do Governo Federal aponta que os médicos cumprem carga horária de 40 horas semanais, das quais 32 horas de atuação nas unidades básicas de saúde e 8 horas de dedicação a atividades educacionais:

> O programa trata de uma formação em serviço, não é vínculo de trabalho. Sendo assim, todos os médicos têm direito a um recesso anual remunerado de 30 dias, e, no caso do Mais Médicos, têm a contribuição previdenciária custeada pelo Ministério da Saúde, bem como moradia, alimentação e ajuda de custo. Todos os profissionais recebem bolsa-formação mensal líquida de R$ 10 mil, são supervisionados e **cumprem 40 horas semanais no programa**, sendo **32 horas de atuação nas unidades básicas de saúde** e **8 horas dedicados a ações de educação na UBS ou em outros locais**[5] .

Não obstante a proibição aos Municípios e ao Distrito Federal de substituição dos médicos que já compõem as equipes de atenção básica pelos participantes do Protejo para a formalização da celebração de termo de adesão e compromisso (art. 11, I, da Portaria Interministerial nº 1369 de 8 de julho de 2013), o Relatório de Auditoria Anual de Contas elaborada pela Secretaria Federal de Controle Interno no exercício 2015[6]

---

5 http://maismedicos.gov.br/perguntas-frequentes-de-medicos http://maismedicos.gov.br/perguntas-frequentes-de-medicos http://maismedicos.gov.br/perguntas-frequentes-de-medicos http://maismedicos.gov.br/perguntas-frequentes-de-medicos http://maismedicos.gov.br/perguntas-frequentes-de-medicos

6 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/mais-medicos/Relatorio-de-Auditoria-Anual-de-Contas-n201600675-SGTES-Exercicio-2015.pdf http://portalarquivos.saude.gov.br/images/mais-medicos/Relatorio-de-Auditoria-Anual-de-Contas-n201600675-SGTES-Exercicio-2015.pdf http://portalarquivos.saude.gov.br/images/mais-medicos/Relatorio-de-Auditoria-Anual-de-Contas-n201600675-SGTES-Exercicio-2015.pdf http://portalarquivos.saude.gov.br/images/mais-medicos/Relatorio-de-Auditoria-Anual-de-Contas-n201600675-SGTES-Exercicio-2015.pdf

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

aponta graves desvirtuamentos nos municípios que a ele aderiram. É certo que houve aumento no número de médicos nos municípios participantes do Projeto. Por outro lado, esse incremento foi de apenas 42,14% das vagas disponibilizadas. **Ou seja: a cada 100 médicos alocados, foram dispensados 58 médicos contratados pelos municípios**:

> "A fim de atender a recomendação, a Unidade Prestadora de Contas (UPC) realizou o monitoramento cujos resultados demonstraram que **a evolução do número de médicos em atuação nos municípios que aderiram ao Projeto Mais Médicos para o Brasil é superior à evolução identificada em municípios que não aderiram**.
>
> Por outro lado, **ao se analisar apenas os entes federativos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, verificou-se que o incremento de profissionais é de apenas 42,14% das vagas disponibilizadas, de forma que a cada 100 profissionais alocados, há uma dispensa de 58 médicos contratados pelos municípios em outras modalidades.** Os dados demonstram que, no exercício de 2012, existiam 46.983 médicos em atuação nos municípios que aderiram ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. Ao final de 2015, existiam 54.525 profissionais em atuação, resultando em um aumento de 7.542 postos de trabalho a serviço dos municípios participantes do Projeto.
>
> Tal situação prejudica o atingimento dos objetivos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e configura-se como descumprimento do art. 11 da Portaria Interministerial MEC/MS nº. 1.369, de 08/07/2013, que determina que a participação dos Municípios e do Distrito Federal na execução do Projeto será formalizada com a celebração de termo de adesão e compromisso, que conterá disposição vedando a substituição de médicos que já componham as equipes de atenção básica pelos participantes deste Projeto.

Por esse motivo, foi emitida a Nota de Auditoria nº. 201600675/002

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/mais-medicos/Relatorio-de-Auditoria-Anual-de-Contas-n201600675-SGTES-Exercicio-2015.pdf

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

recomendando à Unidade Prestadora de Contas (UPC) notificar e adotar providências com vistas a corrigir a situação dos municípios em que o aumento no quantitativo de médicos, no comparativo entre a data anterior ao ingresso no Projeto Mais Médicos para o Brasil e a data atual, não é igual ou superior ao quantitativo de médicos do Projeto alocados no ente federativo.

O site de notícias deste Supremo Tribunal Federal em 25.11.2013 informa que o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta, em audiência pública sobre o Programa Mais Médicos, aponta irregularidades no cumprimento de direitos sociais trabalhistas: das 40 horas semanais de dedicação, 32 são de atividade laboral; não há processo de seleção para o ingresso no programa; os profissionais cubanos não recebem a bolsa de R$ 10 mil, pois o dinheiro é repassado pelo Brasil por meio de convênio para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que repassa para Cuba, responsável pela remuneração dos profissionais[7] .

Com relação à contratação dos intercambistas cubanos, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS firmaram o 80º Termo de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento de Ações Vinculadas ao projeto *"Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde"*, com o objetivo específico de "*promover a qualificação e valorização dos profissionais da Atenção Básica, por meio da capacitação técnica, em localidades prioritárias do Sistema Único de Saúde – SUS*"[8]. Por outro lado, o 3º Termo de Ajuste teve por objeto "*viabilizar o Programa de Cooperação Técnica da Organização Pan-Americana da Saúde para a Participação de*

---

7 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254308
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254308
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254308
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254308
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=254308

8 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/TC%2080%201.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/TC%2080%201.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/TC%2080%201.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/TC%2080%201.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/TC%2080%201.pdf

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

Médicos Cubanos no Projeto Mais Médicos para o Brasil"[9] .

Segundo informação do site da Organização Pan-Americana da Saúde, o acordo previa a vinda de 4000 médicos cubanos, com um investimento de R$ 511 milhões, com a finalidade de atuar nos 701 municípios que não foram selecionados por nenhum médico do edital de chamamento individual, brasileiros ou estrangeiros: 86% desses municípios possuem 20% ou mais de sua população em situação de extrema pobreza e 84% são do Norte e do Nordeste[10] .

Importante ressaltar que a Cláusula Quarta do 3º Termo de Ajuste determina a aplicação da legislação brasileira aos médicos participantes no tocante às obrigações civis e penais:

> "As partes acordam que os Médicos Participantes do Programa estão submetidos à legislação brasileira no que se refere às suas responsabilidades civis e penais";[11]

Entretanto, os contratos individuais para a prestação de serviços profissionais e técnicos no exterior celebrados entre os intercambistas cubanos e a sociedade mercantil cubana Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., estabelece "relação de trabalho" com o profissional de saúde cubano. Em sua cláusula 2.1., "j", fixa a obrigação dessa empresa de pagar mensalmente ao profissional "*por concepto de*

---

9 *http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/3%20TA.pdf*
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/3%20TA.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/3%20TA.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/3%20TA.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/dezembro/06/3%20TA.pdf

10 http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:opas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:opas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:opas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:opas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:opas-oms-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-brasil-para-apoiar-programa-mais-medicos&Itemid=834

11 Não houve publicidade do convênio realizado entre OPAS e Cuba.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

estipendio" a quantia de USD 1000,00 (mil dólares americanos), ao câmbio de 1 USD = 1 CUC (peso cubano), da seguinte forma: 600 CUC (seiscentos pesos cubanos) a serem depositados em uma conta em Cuba e USD 400 (quatrocentos dólares) a serem pagos em território brasileiro em reais brasileiros em uma conta corrente habilitada para esse fim.

Nesse contexto, apesar da previsão de aplicação das normas trabalhistas quanto a obrigações civis, ocorre nítida diferenciação na remuneração dos profissionais de saúde cubanos, considerado o pagamento da bolsa no valor de R$ 10.570,00 (dez mil, quinhentos e setenta reais) para os demais médicos, posteriormente reajustada para R$11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais) a partir de janeiro de 2017.

Dados publicados pela Agência Brasil de notícias aponta que 62% dos intercambistas são cubanos, 29% são brasileiros formados no Brasil e 8,4% são estrangeiros e brasileiros formados no exterior. O Programa chega a 72% dos municípios brasileiros e beneficia 63 milhões de pessoas[12].

Os crescentes desafios na busca tanto da universalização quanto da qualidade da prestação dos serviços de saúde à população brasileira não justificam respostas imediatas e emergenciais em prejuízo aos direitos fundamentais

sociais do trabalho. Sob o pálio da garantia do direito à saúde, o Projeto Mais Médicos infundiu nítida diferenciação nas exigências para o exercício da medicina entre brasileiros e estrangeiros e entre os próprios brasileiros. Sob o véu de exercício de atividades de ensino e pesquisa, o Projeto limitou ao percebimento de "bolsa" a retribuição dos médicos pelos serviços prestados em ofensa aos arts. 5º, *caput* e 7º, da Constituição Federal em nítida precarização das relações de trabalho.

A insuficiência na proteção do trabalho dos médicos participantes do programa em nítida desigualdade injustificada em relação aos demais médicos do SUS, em lógica inversa, reforça as condições encontradas e elencadas como desafios a serem enfrentados pelo Programa,

12 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/governo-aumenta-salario-do-mais-medicos-e-quer-mais-brasileiros-no-programa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

notadamente as inadequadas relações de trabalho e o mercado de trabalho predatório. Note-se que os próprios entes federados participantes do Programa vêm substituindo seus profissionais por médicos "intercambistas". A precarização das condições de trabalho dos médicos ameaça a qualidade do atendimento em prejuízo à finalidade do próprio Programa Mais Médicos.

Forte nas premissas assentadas, acompanho o Ministro Relator quanto às preliminares e também quanto ao mérito, no tocante à parte conhecida, para julgar procedente em parte os pedidos, declarando a inconstitucionalidade dos preceitos indicados por Sua Excelência.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0ACD-841C-E038-76B1 e senha AD39-5BB0-86D4-743B

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, a votação da Ministra Rosa me fez exatamente retornar a uma ideia já há bastante sedimentada e divulgada por mim, a qual, digamos assim, está mais ou menos na linha do que pensa o Ministro Gilmar Mendes, no sentido de dar mais funcionalidade ao Plenário.

O ideal seria que, nos momentos em que concordamos, apenas expuséssemos o nosso "de acordo" - e não sei nem quanto tempo leva para falar "de acordo" -, e depois, no que divergíssemos, usássemos o mesmo tempo que o ilustre advogado tem, da tribuna, para oferecer a sua divergência.

Mantendo coerência e admirando a maneira de proceder da Ministra Rosa, acompanho a divergência que votou no sentido da improcedência da declaração de inconstitucionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14216964.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: **Peço vênia**, Senhora Presidente, **para acompanhar**, *integralmente*, **o douto voto** proferido pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES.

É o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 15E7-7FEF-FB7C-B36B e senha 1BC0-DFD0-5A4A-B833

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também vou pedir todas as vênias ao Ministro Marco Aurélio, Presidente, que fez um voto extremamente profundo sobre o tema, mas vou encaminhar-me no sentido do voto divergente, a partir da manifestação do Ministro Alexandre de Moraes.

Nós sabemos que esse tema esteve eivado de muita polêmica, de muita discussão e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo. E a própria legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados e tudo o mais.

O Ministro Alexandre fez uma observação que eu acho extremamente relevante para todo esse debate que se coloca. Nem a autonomia universitária se confunde com soberania, como também a chamada autonomia administrativa e financeira não pode se confundir com esse próprio conceito de soberania, embora, muitas vezes, façamos essa confusão. É fundamental que se veja esses conceitos como garantias institucionais suscetíveis de serem, inclusive, adaptadas no tempo, serem atualizadas. É claro que há um núcleo básico.

Eu me lembro, e já citei isso em outras oportunidades, que, a propósito da autonomia administrativa e financeira modelada para o Ministério Público, o Ministro Pertence, que estava na Procuradoria-Geral da República àquela época, discutindo especialmente com os Procuradores de São Paulo, que defendiam a ideia da autonomia administrativa e financeira, o Ministro Pertence, com aquela sua acuidade típica, disse que desejava que o Ministério Público tratasse o Brasil como nação amiga. Portanto, é uma antevisão, uma antecipação do que veio a se transformar essa ideia de autonomia entre nós, inclusive a chamada autonomia universitária.

Subscrevo às inteiras o voto do Ministro Alexandre de Moraes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14341621.

30/11/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035 DISTRITO FEDERAL

V O T O

A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal):

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, que questiona a validade constitucional dos incs. I e II do art. 7º, de seu § 1º e dos incs. I e II de seu § 2º e de seu § 3º; dos incs. I, II e III do art. 9º e de seu § 1º; dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 10; e do art. 11, todos da Medida Provisória n. 621/2013.

2. A Associação Médica Brasileira/AMBR suscita as seguintes inconstitucionalidades:

a) ausência dos pressupostos constitucionais do art. 62 da Constituição da República para edição de medida provisória - ausência de relevância e urgência;

b) afronta ao direito à saúde;

c) afronta ao princípio da isonomia (*caput* do art. 5º da Constituição) e ao princípio da autonomia das universidades (art. 207 da Constituição);

d) contrariedade ao princípio constitucional do concurso público (inc. II do art. 37 da Constituição);

e) imposição de servidão civil aos estudantes do curso de medicina, em detrimento do art. 6º do Pacto de San José da Costa Rica - norma de caráter supralegal;

f) limitação territorial do exercício da profissão – ofensa ao livre exercício profissional - criação de subcategorias de profissionais (inc. XIII do art. 5º da Constituição);

g) impossibilidade de medida provisória regular matéria relativa à nacionalidade, cidadania e orçamento (al. *a* e *d* do § 1º do art. 62 da Constituição);

h) afronta ao princípio da legalidade estrita (inc. II do art. 5º da Constituição), em razão do afastamento da proficiência em língua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

portuguesa;

i) terceirização ilícita - contratação sem processo licitatório regular (inc. XXI do art. 37 da Constituição).

3. O ministro relator adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

4. A Presidência da República manifestou-se pela rejeição da cautelar e pelo indeferimento dos pedidos, considerados *"os robustos elementos de convicção que cercam o tema, a edição de medida provisória em análise, a par de atender os requisitos formais e materiais do art. 62 da Constituição, representou a materialização do dever de eficiência, também constitucionalmente imposto a toda Administração"*.

5. A Câmara dos Deputados informou que *"a referida matéria foi processada pelo Congresso Nacional dentro dos mais estritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie"*.

6. O Senado Federal refutou *"a alegada inconstitucionalidade formal pelo não preenchimento dos pressupostos para a edição da medida provisória"*. Quanto à inconstitucionalidade material, informou que ainda estaria a analisar os dispositivos da Medida Provisória n. 621/2013, sem ainda concluir pelo mérito da questão debatida.

7. O Conselho Federal de Medicina/CFM foi admitido como terceiro interessado e se manifestou pela procedência da ação.

8. Nos dias 25 e 26/11/2013, foi realizada audiência pública para ouvir o depoimento de autoridades e especialistas sobre o "Programa Mais Médicos".

9. Em petição de 23.6.2014, a Associação Médica Brasileira/AMBR requereu o aditamento da inicial, *"tendo em vista a conversão da Medida Provisória impugnada em lei, para que seja declarada, por meio da presente ação,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

a inconstitucionalidade parcial da Lei 12.871/13, por ofensa ao disposto nos artigos 1º, 2º, 3º, I, IV, art. 5º, caput, I, II, XIII, 6º, 7º, 22, XVI, 37, caput, II e XXI, 44, 62, 65, 66, 194, 196, 197, 207 e 219 da Carta Republicana de 1988, bem como as Leis Federais nº 3268/57, Lei nº 8080/90, § 1º do art. 2º do Decreto 4445/1958, o § 2º do artigo 48 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), Decreto nº 20931/32".

10. Em 18.9.2013, o Ministro Marco Aurélio determinou o apensamento desta ação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.037, *"cujo pleito se mostra mais abrangente"*.

11. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido:

> *"Dispositivos da Medida Provisória n. 621, de 08 de julho de 2013, que 'institui o Programa Mais Médicos e dá outras providências'. Preliminar. Ilegitimidade ativa das requerentes. Mérito. Programa destinado a suprir a carência de profissionais de saúde no País. Presença dos requisitos de urgência e relevância previstos no artigo 62 da Constituição a justificar a edição de medida provisória. Avaliação qualitativa prévia de conhecimentos técnicos e da língua portuguesa. Ausência de violação aos artigos 5º caput e inciso II; 7º; 37, caput e incisos II e XXI; 196; 197 e 207 da Constituição Federal Manifestação pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito, pela improcedência do pedido."*

12. A Procuradoria-Geral da República opina improcedência do pedido:

> *"Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Mais Médicos (Medida Provisória 621/2013). I – Preliminares. Superveniência de conversão da medida provisória em lei. Ausência de aditamento do pedido. Ausência de cópia da lei de conversão. Ausência de procuração com poderes específicos. Ilegitimidade ativa do Conselho Federal de Medicina (CFM). II – Mérito. Presença dos requisitos de urgência e relevância da medida provisória. Inexistência de violação aos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

princípios da legalidade, do concurso público, da isonomia, da licitação pública, do direito à saúde, dos direitos sociais dos trabalhadores, da autonomia universitária e da proteção do mercado interno. Parecer pela intimação da Associação Médica Brasileira (AMBR) para regularização da petição inicial e da documentação anexa e, no mérito, pela improcedência do pedido."

13. Estes os dispositivos impugnados:

"CAPÍTULO IV – DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Art. 7º Fica instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I – aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; e

II – aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observará a seguinte ordem de prioridade:

I – médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País;

II – médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior; e

III – médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I – médico participante – médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II – médico intercambista – médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior.

§ 3º A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de afastamentos e os recessos [atual art. 13 da Lei n. 12.871/2013]

[…]

Art. 9º Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I – o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II – o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico; e

III – o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

§ 1º São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde:

I – apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira;

II – apresentar habilitação para o exercício da medicina no país de sua formação; e

III – possuir conhecimentos de língua portuguesa. [atual art. 15 da Lei n. 12.871/2013]

[…]

Art. 10. O médico intercambista exercerá a medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [atual art. 16 da Lei n. 12.871/2013]

§ 1º Fica vedado ao médico intercambista o exercício da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

§ 2º Para exercício da medicina pelo médico intercambista no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil será expedido registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina.

§ 3o A declaração de participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, fornecida pela coordenação do programa, é condição necessária e suficiente para a expedição de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina, não sendo aplicável o art. 99 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.*
>
> *§ 4º O registro provisório será expedido pelo Conselho Regional de Medicina no prazo de quinze dias, contado da apresentação do requerimento pela coordenação do programa de aperfeiçoamento, e terá validade restrita à permanência do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do regulamento.*
>
> *[…]*
>
> *Art. 11. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza."*

Preliminares

14. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República suscitaram a impossibilidade de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade por vício na representação processual da Associação Médica Brasileira (AMBR), cuja procuração *ad judicia* juntada aos autos não a dotou de poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

A irregularidade, todavia, foi sanada pela autora em 23.6.2014, com a juntada do documento regular (doc. 105).

15. Quanto à arguida ilegitimidade *ad causam* do Conselho Federal de Medicina, tem-se que, em 5.4.2016, o Relator o excluiu do polo ativo da ação por ser pessoa jurídica de direito público *"que realiza verdadeira fiscalização no tocante ao execício da medicina, não podendo ser equiparado a entidade de classe de âmbito nacional"*, admitindo-o como terceiro interessado.

Rejeitada, portanto, a preliminar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

A Associação Médica Brasileira, por sua vez, qualifica-se como entidade de classe de âmbito nacional, regularmente constituída para a defesa *"da dignidade profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da população brasileira, conforme se depreende do seu estatuto (documento anexo)"*, configurando-se a pertinência temática exigida para a propositura da ação, nos termos do inc. IX do art. 103 da Constituição da República e do artigo 2°, inc. IX da lei nacional n. 9.868/99.

16. Quanto à impugnação do art. 10 da Medida Provisória 621/2013, tem-se parcialmente prejudicada a arguição de constitucionalidade, observados os termos da lei de conversão, n. 12.871/2013, em que vetado o respectivo § 1º.

17. Na lei de conversão não prevaleceu a previsão originária dos §§ 3º e 4º do art. 10 da Medida Provisória n. 621/2013, segundo o qual, uma *"declaração de participação"* do médico intercambista retiraria dos Conselhos Regionais de Medicina a competência para avaliar sua qualidade profissional, suprimindo, nas palavras da Autora, *"a possibilidade de fiscalização do exercício profissional através da análise documental para o exercício da medicina"* (inicial, fl. 8).

18. Subsistiram, todavia, as previsões para a dispensa de revalidação de diploma do médico intercambistas, nos três primeiros anos de participação, prorrogados por mais três, nos termos da Lei n. 13.333, de 12.9.2016. Tem-se, atualmente, na lei de conversão:

> *"Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Vide Decreto nº 8.126, de 2013) (Vide Lei nº 13.333, de 2016)*
>
> *§ 1º (VETADO).*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.*
>
> *§ 3º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2º.*
>
> *§ 4º A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de registro único.*

Contrariamente àquela dispensa, a autora suscita a precarização da saúde e, até mesmo, o exercício ilegal da medicina por contrariedade ao art. 5º, inc. XIII, da Constituição, ao art[1]. 17 da Lei n.º 3268/57, e o Decreto n.º 44045/58, *"tendo em conta que a tutela da vida, da segurança e da saúde não pode deixar de observar os parâmetros insculpidos na Constituição da República, principalmente porque os programas de governo devem buscar a redução do risco de doença e de outros agravos, por força dos artigos acima citados"*.

Conclui que a contratação de médicos intercambistas, ao arrepio da legislação nacional, importaria, ainda, *"tratamento desumano e cruel, próximo à escravidão, tendo em conta a evidente violação ao art. 7º da CF/88 e ao artigo 6º do Pacto de São José da Costa Rica, norma supralegal, que proíbe qualquer tipo de trabalho escravo"*.

Esta controvérsia é de natureza infraconstitucional porque imediatamente fundada nos termos do art[2]. 48, § 2º, da Lei n. 9.394/96,

---

1 *"Art . 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade".*

2 Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

sem correspondência direta na Constituição da República, elemento necessário para o regular exercício do controle normativo abstrato. Nessa linha:

> *" Diploma expedido por Universidade estrangeira. Revalidação. (…) A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo ao "direito ao processamento de requerimento de revalidação de diploma de graduação obtido em instituição de ensino superior estrangeira" (RE nº 638.602/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/12/12 – Tema 620) 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça"* (ARE-AgR 1050649, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017);

> *"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO. INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO. LEI Nº 9.615/1999. CARÁTER DIRIGENTE. FUNÇÃO NORMATIZADORA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE. ARTS. 2º, I, DA LEI Nº 9.882/1999, 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. RELEVÂNCIA DA*

---

validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO"* (ADPF n. 406 AgR, Relator Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe 7.2.2017).

Ademais, como ressaltado pela Advocacia-Geral da União, *"tais profissionais somente estão autorizados a exercer a medicina no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, de modo que sua situação jurídica não é equiparável aos profissionais cujos diplomas foram revalidados"* sendo que

> *"a seleção de médicos formados em instituições estrangeiras para a participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil observará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que já são adotadas com êxito na Austrália, Inglaterra e Canadá, e que reúnem princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas de saúde dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos tais como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e o intercâmbio de informações, além do monitoramento e da pesquisa sobre o tema.*
>
> *Além disso, conforme se extrai da Exposição de Motivos n° 24/2013 17, relativa à Medida Provisória n° 621/13, "o médico formado em instituição de educação superior estrangeira será submetido a processo de acolhimento e avaliação, a ser desenvolvido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, afim de garantir a adaptação aos princípios e diretrizes do SUS, a adequação à realidade epidemiológica brasileira e a capacidade de comunicação em língua portuguesa"."* (parecer fls. 31-32).

19. **Conheço, em parte, da ação.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Mérito

Viabilidade do exame dos requisitos constitucionais da medida provisória impugnada após sua conversão em lei

20. Cumpre, inicialmente, ressaltar que a Medida Provisória n. 621/2013, objeto desta ação, foi convertida na Lei n. 12.871, de 22.10.2013, com alterações.

Há precedentes deste Supremo Tribunal, segundo os quais a conversão em lei de medida provisória objeto de controle abstrato de constitucionalidade prejudica o exame de seus requisitos formais. Essa a orientação assentada, por exemplo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721 (Relator Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2007).

Verifica-se, entretanto, entendimento diverso manifestado a partir do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.090 (Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007), remanescendo a possibilidade de análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória mesmo após sua conversão em lei. Confiram-se, a propósito, as razões adotadas pelo Ministro Cezar Peluso:

> *"Se dermos ao caso específico desta figura de produção legislativa híbrida – a medida provisória que se converte em lei –, o mesmo tratamento jurídico-constitucional que se dá a projeto de lei e à lei, a distinção entre as duas figuras desaparecer. Por quê? Porque vamos dar à medida provisória a qualificação de uma lei autônoma capaz de ser secionada no tempo e na sua eficácia. Na verdade, não é disso que se trata. Não se trata de duas leis suscetíveis de seccionamento no tempo, de tal modo que, se o vício perdurou durante a vigência da primeira lei, não contaminaria a outra lei, porque esta seria independente. E não há essa independência. O que ocorre é uma transformação.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *Se me fosse permitido usar uma figura não jurídica, de retórica, diria que o mesmo se sucede na transformação da crisálida em borboleta. Não se trata de outro ser, mas do mesmo, com modos diferentes de ser, que, no caso, é um produto legislativo híbrido, com esta agravante: se o legislador constitucional quis impedir que determinadas matérias fossem reguladas e disciplinadas por um mecanismo híbrido principiado por uma medida provisória – e esta, ele, como legislador, não poderia ignorar que pode ser convertida em lei –, essa sua preocupação de proibir que as matérias fossem cuidadas por via de medida provisória seria um absurdo constitucional. Noutras palavras: para que fim o legislador proíbe que determinados assuntos possam ser regulados por medida provisória, se ele mesmo sabe que a lei vai sanar os vícios dessa medida provisória? Ou seja, ele vai permitir que a sua proibição se torne inútil pelo fato de não poder ignorar que a transformação dessa medida provisória em lei simplesmente é capaz de absolver os vícios que ele tem por impeditivos da edição de uma medida provisória?"*

A jurisprudência atualmente predominante neste Supremo Tribunal admite, portanto, o exame dos pressupostos constitucionais da medida provisória mesmo após sua conversão em lei, pois "*a lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória (…)*" (ADI n. 3.090, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007):

> *"CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 402, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.656, DE 16 DE ABRIL DE 2008. ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DA IMPREVISIBILIDADE E DA URGÊNCIA (§ 3º DO ART. 167 DA CF), CONCOMITANTEMENTE.*
>
> *(…)*
>
> *3. A conversão em lei da medida provisória que abre crédito extraordinário não prejudica a análise deste Supremo Tribunal Federal quanto aos vícios apontados na ação direta de inconstitucionalidade.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *(…)*
>
> *5. Medida cautelar deferida". (ADI 4.049-MC, Relator Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2009)*
>
> *"AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 213/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.*
>
> *(…)*
>
> *2. A conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade desse espécime de ato da ordem legislativa. Presentes, no caso, a urgência e relevância dos temas versados na Medida Provisória nº 213/2004.*
>
> *(…)*
>
> *10. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. ADI's 3.314 e 3.330 julgadas improcedentes". (ADI 3.330, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2013)*
>
> *"(…) a conversão da Medida Provisória 340/2006 na Lei 11.482/2007 não prejudica o debate acerca do atendimento dos pressupostos constitucionais necessários à adoção dessa espécie legislativa. Na espécie, é evidente a continuidade normativa entre o ato legislativo provisório e a lei que resulta de sua conversão" (ARE 704.520, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2014);*

Mesma é a orientação no sentido do não prejuízo da arguição de inconstitucionalidade formal em decorrência da conversão da medida provisória, em lei, como votei, por exemplo, na ADI n. 2.736, sessão plenária de 8.9.2010, Relator o Ministro Cezar Peluso, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 704.520 (Pleno, Dje 2.12.2014), Relator o Ministro Gilmar Mendes, neste tendo se manifestado o Ministro Celso de Mello:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *"A transformação ritual da medida provisória em lei formal, resultante de deliberação aquiescente do Congresso Nacional, não afasta nem exclui a inconstitucionalidade que eventualmente se verifique no ato executivo com força de lei, pois o caráter inconvalidável do vício de ilegitimidade constitucional, impede que a mera vontade dos poderes constituídos se sobreponha à autoridade da própria Constituição.*
>
> *Em outras palavras: a vontade do Parlamento, aprovando a transformação da medida provisória em lei, não se revela suficiente para conferir validez jurídica à lei de conversão, quando esta, por efeito da repercussão causal, seja afetada pelos vícios de inconstitucionalidade do ato presidencial de legislação emergencial que lhe deu origem.*
>
> *Cabe mencionar, por oportuno, neste ponto, que nem mesmo a superveniência de uma emenda à Constituição – quanto mais a promulgação de uma simples lei de conversão – pode convalidar, ainda que para o futuro, diploma legislativo originariamente inconstitucional"* (voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 704.520, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, Dje 2.12.2014).

Subsiste, assim, o objeto da ação.

Ausência de inconstitucionalidade formal das normas impugnadas: observância dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a edição de medida provisória.

21. A autora aponta ausentes os requisitos constitucionais de relevância e urgência para a edição da Medida Provisória nº 621/2013, em contrariedade ao art. 62 da Constituição da República.

Em estudo sobre a matéria, defendi que os órgão do Poder Judiciário devem *"fazer valer a sua competência própria para o exercício do controle de constitucionalidade das medidas provisórias, inclusive quanto aos seus pressupostos, sob pena de vir a se estabelecer um espaço de atuação estatal inexpugnável à jurisdição fiscalizadora de validade dos atos do Poder Público, o*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

que é incompatível com os princípios do Estado democrático de direito" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *Medidas provisórias e princípio da separação de poderes. In: Direito contemporâneo: estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa*, p. 44-69. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 62).

Como anotado pelo Ministro Celso de Mello, "*a possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o Presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipótese em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais*" (ADI 2.213-MC, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 23.4.2004).

Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, ainda que em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade formal de medidas provisórias quando se afigure evidente o abuso do poder de legislar pelo Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência:

> *"CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.*
>
> *1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.*
>
> *2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido". (RE 592.377, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2015)

"MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.226, DE 04.09.2001. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, CAPUT E II; 22, I; 24, XI; 37; 62, CAPUT E § 1º, I, B; 111, § 3º E 246. LEI 9.469/97. ACORDO OU TRANSAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, POR CADA UMA DAS PARTES, AOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO, DA APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA.

1. A medida provisória impugnada foi editada antes da publicação da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001, circunstância que afasta a vedação prevista no art. 62, § 1º, I, b, da Constituição, conforme ressalva expressa contida no art. 2º da própria EC 32/2001.

2. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. No presente caso, a sobrecarga causada pelos inúmeros recursos repetitivos em tramitação no TST e a imperiosa necessidade de uma célere e qualificada prestação jurisdicional aguardada por milhares de trabalhadores parecem afastar a plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 62 da Constituição.*
>
> *(…)*
>
> *6. Pedido de medida liminar parcialmente deferido". (ADI 2.527-MC, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2007)*

Confira-se ainda: ADI 2.418, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; ARE 704.520, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2014; ADC 11-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2007; ADI 1.910-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 27.2.2004; ADI 1.717-MC, Relator Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 25.2.2000; ADI 1.647, Relator Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 26.3.1999; ADI 1.753-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 12.6.1998; ADI 162-MC, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 19.9.1997.

22. Ao conferir ao Presidente da República a possibilidade de editar medidas provisórias com força de lei, o art. 62 da Constituição da República estabelece como requisitos formais dessa espécie normativa a relevância e a urgência do caso.

Observei noutra ocasião que esses requisitos não são "*conceitos vagos ou despojados de conteúdo comprovável em cada caso; antes, são conceitos cuja precisão se põe como possível e imprescindível em cada situação na qual se pretendam utilizá-los*" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *Medidas provisórias e princípio da separação de poderes. In: Direito contemporâneo: estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa*, p. 44-69. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 62).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Somente quando a necessidade social imperiosa for urgente e demandar imediata resposta pela adoção da medida normativa presidencial haverá de ser legitimada a atuação excepcional da autoridade titular do Poder Executivo. Há, pois, que se interpretar o art. 62 da Constituição da República acentuando-se em caso de relevância e quando se configurar urgência.

Ademais, de forma preponderante no deslinde da presente controvérsia, *"se o cuidado normativo de uma determinada matéria a incidir sobre uma circunstância social puder aguardar pelo menos o prazo mínimo para a tramitação urgente de um projeto de lei (hoje fixado em 45 dias), é evidente não se poder fazer uso do instituto da medida provisória por carência de um dos seus pressupostos"*.

Foi o que asseverei em artigo doutrinário sobre o tema:

> *"11. O primeiro pressuposto estabelecido na Constituição para o exercício da competência normativa do Presidente da República para adotar medida provisória é a existência de uma circunstância de relevância – 'em caso de relevância…'.*
>
> *A questão que se põe, primariamente, para o perfeito esclarecimento deste elemento é a que se refere ao caso constitucionalmente referido no texto constitucional. A relevância haverá de ser de um caso cuidado e a ser solucionado com a adoção de medida normativa ou de uma matéria a ser objeto deste ato normativo a atender, urgentemente, um caso social e politicamente pendente na sociedade? 'Em caso de relevância…' significa que há uma necessidade inexorável emergente na sociedade a reclamar, como única solução possível, um comportamento normativo?*
>
> *Relevante é o que tem importância, é o que se põe como essencial, como dotado de qualidade indispensável à essência de um ato, de algo ou de alguém. Quando se configurar, pois, uma circunstância constatada como de necessidade imperiosa na sociedade e a ser objeto de um cuidado normativo, é que se poderá, então, cogitar de adoção de medida no moldes do art. 62 da Constituição da República.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Pressupõe-se, então, que a relevância prevista constitucionalmente concerne à circunstância social a tornar exercitável a competência descrita no art. 62, da Lei Fundamental da República brasileira. Esta circunstância tem de ser objetivamente demonstrativa de uma necessidade social de importância insuperável por outra medida que não aquela de natureza normativa (com força de lei) adotada, provisoriamente, pelo Presidente da República.

Urge salientar que a relevância é, pois, da situação social sobre a qual incidirá o cuidado normativo trazido na medida provisória adotada. Não se considerará jamais caso de relevância aquele que se traduza em interesses, ainda que sérios e importantes, de governo, de partidos, de governantes, mesmo que a hipótese ofereça riscos para a permanência de um grupo no poder ou algo que a isso se equipare.

Somente para a sociedade deverá ser relevante o caso e é apenas em face dela e para ela que será apurada a ocorrência objetiva de tal qualidade das circunstâncias alegadas. Grupos particulares ou interesses, ainda que partidários, não se enquadram na hipótese prevista constitucionalmente e definidora da competência presidencial excepcional.

12. Mas não somente apenas o caso é que haverá de ser relevante para ser possível a deflagração da competência normativa presidencial, como haverá de ser, ainda, pesquisado quando um caso autoriza o seu exercício, para, então, se ter o quadro dos pressupostos do desempenho válido e legítimo daquela atribuição.

A resposta a essa segunda questão é oferecida, expressamente, pela própria Constituição: somente quando a necessidade social imperiosa for urgente e demandar uma imediata resposta por meio da adoção da medida normativa presidencial haverá de ser legitimada a atuação excepcional da autoridade titular do Poder Executivo. Há, pois, que se ler o art. 62, da Constituição da República na forma seguinte: em caso de relevância e quando esse caso de relevância for urgente… Pode haver casos urgentes na sociedade que não têm, contudo, o relevo imposto como pressupostos para o exercício possível da atribuição presidencial em pauta. Pode também haver casos relevantes que não têm a urgência que se põem na base fundante da constitucionalidade legítima do desempenho presidencial. Assim, se o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *cuidado normativo de uma determinada matéria a incidir sobre uma circunstância social puder aguardar pelo menos o prazo mínimo para a tramitação urgente de um projeto de lei (hoje fixado em 45 dias), é evidente não se poder fazer uso do instituto da medida provisória por carência de um dos seus pressupostos.*
>
> *A urgência alia questão de data (momento) com a condição nela constatada. A urgência qualifica o momento e define o tempo de exercício de uma competência. Note-se que a urgência pode ser preventiva ou reparadora, e tal qualidade demonstrada altera a análise da constitucionalidade da declaração de urgência para o exercício da competência.*
>
> *O pressuposto da relevância do caso para o qual se adote medida provisória expõe a natureza da exigência, enquanto o pressuposto da urgência define, constitucionalmente, o momento da exigência da atuação administrativo-normativa"* (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Medidas provisórias e princípio da separação de poderes. In: Direito contemporâneo: estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa, p. 44-69. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 58-60).

Também para Clèmerson Merlin Clève, *"não se pode esquecer, entretanto, que urgente deve ser não apenas a adoção da norma editada (vigência) como, igualmente, a sua incidência (aplicação). Por isso, a melhor doutrina tem, em geral, como indispensável a adoção de medida provisória para produzir efeitos após determinado lapso temporal"*[3].

23. Como enfatizado pela Advocacia-Geral da União, a Medida Provisória n. 621/2013 congregou as seguintes finalidades:

> *"a) a diminuição da carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS;*
>
> *b) a redução das desigualdades regionais na área da saúde;*
>
> *c) o fortalecimento da prestação de serviços básicos em saúde no País".*

3 CLÈVE, Clèverson Merlin. Medidas provisórias. São Paulo: RT, 2010, p 96. Informação do Senado Federal, fl. 10.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Fixou-se em *"três eixos principais de atuação"*:

> *"a) a reordenação da oferta de cursos de medicina e vagas para residência médica, com foco prioritário nas regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos;*
>
> *b) o estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País*
>
> *c) a promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional".*

Estas as finalidades expressamente arroladas na exposição de motivos da Medida Provisória n. 621/2013:

> *"I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;*
>
> *II - fortalecer a prestação de serviços na atenção básica em saúde no País;*
>
> *III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação;*
>
> *IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;*
>
> *V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desenvolvidas pelos médicos;*
>
> *VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras;*
>
> *VII - aperfeiçoar médicos nas políticas públicas de saúde do País e na organização e funcionamento do SUS; e*
>
> *VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas no SUS."*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

24. Consideradas as balizas interpretativas, destacam-se juridicamente relevantes e urgentes, a justificar a adoção de medida provisória, e tão somente, as finalidades que visam a promover e aperfeiçoar o atendimento emergencial do cidadão, histórica e notoriamente desguarnecido de saúde digna, com a implementação de programa análogo à residência médica, de integração ensino universitário, atendimento médico básico, como demonstrado na exposição de motivos da medida provisória.

Segundo as razões estabelecidas naquele documento, subscrito pelos Ministros Alexandre Rocha Santos Padilha, Aloizio Mercadante Oliva e Miriam Aparecida Belchior, o atingimento da meta considerada ideal (padrão Reino Unido) de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes, ocorreria só em 2035, mantida a taxa de expansão das 2.415 vagas de cursos de medicina, anunciada pelo Ministério da Educação, em 2012.

Daí a previsão de ampliação de 12.000 novas vagas de residência médica acompanhadas da oferta de bolsas, a serem implementadas até 2017, também no intuito de domiciliar os profissionais nos locais de sua atuação.

Além disso, buscou-se evidenciar a *"extrema gravidade, no qual alguns estados apresentam um número insuficiente de médicos e de vagas de ingresso na graduação, com ausência de expectativa de reversão desse quadro a curto e médio prazos, caso não haja medidas indutoras implementadas pelo Estado"*. Confira-se:

> *"O Brasil possui 359.691 médicos ativos e apresenta uma proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 (mil) habitantes, conforme dados primários obtidos no Conselho Federal de Medicina (CFM) e na estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).*
>
> *12. A proporção de médico/1.000 habitantes constatada no Brasil é menor do que em outros países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante ou países que têm sistemas*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

universais de saúde, a saber: Canadá 2,0; Reino Unido 2,7; Argentina 3,2; Uruguai 3,7; Portugal 3,9; Espanha 4,0 e Cuba 6,7 (Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2011 e 2012 – Organização Mundial da Saúde – OMS).

13. Não existe parâmetro que estabeleça uma proporção ideal de médico por habitante reconhecido e validado internacionalmente. Para tanto, utiliza-se como referência a proporção de 2,7 médicos por 1.000 habitantes, que é a encontrada no Reino Unido, país que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter universal orientado pela atenção básica. Nesse cenário, para que o Brasil alcance a mesma relação de médicos por habitante seriam necessários mais 168.424 médicos. Mantendo-se a taxa atual de crescimento do número de médicos no país, o atingimento dessa meta só será viável em 2035.

14. A distribuição dos médicos nas regiões do país demonstra uma grande desigualdade, com boa parte dos estados com uma quantidade de médicos abaixo da média nacional. A tabela abaixo demonstra essa distribuição (IBGE/2012 e CFM/2012):

UF - População 2012	- Total de Médicos	-Médico por 1.000 hab.
Acre 721.006	679	0,94
Alagoas 3.233.234	3.632	1,12
Amapá 662.927	505	0,76
Amazonas 3.534.574	3.744	1,06
Bahia 15.001.484	16.311	1,09
Ceará 8.810.603	9.277	1,05
Distrito Federal 2.741.213	9.494	3,46
Espírito Santo 3.577.833	7.040	1,97
Goiás 6.145.928	8.917	1,45
Maranhão 6.533.540	3.767	0,58
Mato Grosso 3.120.442	3.441	1,10
Mato Grosso do Sul 2.426.518	3.733	1,54
Minas Gerais 20.529.623	37.149	1,81
Pará 7.726.888	5.938	0,77
Paraíba 3.843.916	4.488	1,17
Paraná 10.945.791	18.406	1,68
Pernambuco 9.015.728	12.547	1,39

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Piauí	*3.214.556*	*2.971*	*0,92*
Rio de Janeiro	*16.383.401*	*56.391*	*3,44*
Rio Grande do Norte	*3.221.581*	*3.977*	*1,23*
Rio Grande do Sul	*11.073.282*	*24.741*	*2,23*
Rondônia	*1.531.920*	*1.562*	*1,02*
Roraima	*445.043*	*540*	*1,21*
Santa Catarina	*6.297.460*	*10.656*	*1,69*
São Paulo	*42.390.043*	*105.658*	*2,49*
Sergipe	*2.074.528*	*2.701*	*1,30*
Tocantins	*1.323.231*	*1.426*	*1,08*
Total	*196.526.293*	*359.691*	*1,83*

15. Mesmo os estados com mais médicos que a média nacional apresentam importantes diferenças regionais. Um exemplo disso é o Estado de São Paulo que, em apenas cinco de suas regiões, apresenta um número superior a 1,8 médicos a cada mil habitantes (Demografia Médica no Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, 2012).

16. Uma das explicações para esse quadro está relacionada ao número insuficiente de vagas nos cursos de graduação em medicina. Apesar de um número absoluto de escolas médicas maior do que alguns países (são 200 escolas médicas), ao analisar-se a proporção de vagas de ingresso para cada 10.000 (dez mil) habitantes, o país apresenta índice significativamente inferior.

17. Enquanto o Brasil tem o índice de 0,8 vaga a cada 10.000 habitantes, outros países têm índices maiores, a saber: Austrália 1,4; Reino Unido 1,5; Portugal 1,6 e Argentina 3,1. Além disso, há estados em que esse índice é ainda menor, tais como Maranhão e Bahia (0,39).

18. A escassez de médicos em diversas regiões se manifesta em análises realizadas sobre o mercado de trabalho, como no estudo "Demografia do Trabalho Médico", do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Consoante esse estudo, entre os anos de 2003 e 2011, para 93.156 egressos dos cursos de medicina foram criados 146.857 empregos formais. Cabe considerar que nestes dados não estão incluídos os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *médicos que optam por ingressar na residência médica, médicos cooperativados ou autônomos. Desse modo, é possível concluir que uma parcela significativa dos médicos recém-graduados já ingressa no mercado de trabalho com a possibilidade de exercer mais de um emprego formal.*
>
> *19. A população brasileira percebe e manifesta o desconforto com essa escassez de médicos, que tem impacto no acesso ao SUS. Em estudo do Sistema de Indicadores de Percepção Social, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em 2011, 58,1% dos 2.773 entrevistados disseram que a falta de médicos é o principal problema do SUS. No mesmo estudo, a resposta mais frequente como sugestão de melhoria para o sistema de saúde foi de aumentar o número de médicos.*
>
> *20. Desse modo, encontramos um quadro de extrema gravidade, no qual alguns estados apresentam um número insuficiente de médicos e de vagas de ingresso na graduação, com ausência de expectativa de reversão desse quadro a curto e médio prazos, caso não haja medidas indutoras implementadas pelo Estado. Nesse cenário, a expansão de 2.415 vagas de cursos de medicina, anunciada pelo MEC em 2012, só contribuiria para atingir o número de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes no ano de 2035."*

No concernente à redistribuição de vagas nos cursos de medicina, argumentou-se a necessidade de *"a adoção de iniciativas estatais para criar e ampliar vagas em cursos de medicina nos vazios de formação e de assistência, a partir do papel indutor do Estado na regulação da educação superior"* a ser instrumentalizada pela "*regulação educacional específica, com a publicação de chamamentos públicos às instituições de educação superior interessadas em se habilitar para atuação nas regiões que apresentem vulnerabilidade social, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação"*.

Finalmente, centrou-se a medida provisória na atenção médica básica de regiões prioritárias para o SUS, privilegiando municípios com baixa receita *per capita* e alta vulnerabilidade econômica, com parcelas de suas populações vivendo em extrema pobreza, áreas de maior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

vulnerabilidade de capitais e regiões metropolitanas e Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Evidenciou-se, ainda, a insuficiente adesão de médicos brasileiros a programas prévios (2012-2013) de integração ensino-serviço em regiões de extrema pobreza e periferias, nas quais permaneceram ociosas um número significativo de vagas, correspondendo a 74,2% da demanda inicial.

A medida priorizou a contratação de médicos formados em instituições de educação superior nacionais ou com diploma revalidado.

Abriu-se, contudo, a possibilidade apenas subsidiária, em caso de persistirem vagas ociosas, para a contratação: *a)* primeiramente, de médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior e, só então, *b)* de médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior, mediante chamamento público internacional ou celebração de instrumentos de cooperação com organismos internacionais:

> *"Com vistas a enfrentar o problema da escassez de médicos no país, sobretudo em regiões prioritárias para o SUS, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios para os municípios que apresentem condições de receber médicos para preenchimento de vagas em equipes de atenção básica, nos termos da Política Nacional de Atenção Básica, devendo o município enquadrar-se em um dos seguintes grupos: a) G100 (municípios com população superior a 80.000 pessoas, com baixa receita per capita e alta vulnerabilidade econômica); b) municípios com 20% ou mais de sua população vivendo em extrema pobreza; c) áreas de maior vulnerabilidade de capitais e regiões metropolitanas; e d) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).*
>
> *28. Além disso, os Ministérios da Saúde e da Educação desenvolvem políticas para responder a necessidade de provimento e fixação de médicos nas diversas regiões do país. Nos anos de 2012 e 2013, foram realizadas chamadas nacionais para médicos, através do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica/PROVAB,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

ofertando a possibilidade de curso de especialização na modalidade integração ensino-serviço em regiões de extrema pobreza e periferias, com incentivo aos participantes mediante acréscimo na pontuação no processo seletivo da residência médica.

29. Na primeira edição do Programa, apesar de uma demanda significativa dos municípios por esses profissionais, somente 381 médicos foram vinculados. Na segunda edição do programa, aderiram 2.838 municípios que solicitaram 13.862 médicos para atuar na atenção básica, sendo que apenas 3.577 médicos foram vinculados ao Programa para atuação em 1.260 municípios.

30. Ainda assim, mesmo com aumento importante na participação de médicos, permanece um número significativo de vagas ociosas, correspondendo a 74,2% da demanda inicial (Sistema de Gerenciamento de Programas da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde).

31. Tendo em vista a situação descrita acima, a instituição do Projeto Mais Médicos para o Brasil visa possibilitar a seleção de médicos interessados em participar de ações de aperfeiçoamento em atenção básica, em regiões prioritárias para o SUS.

32. Para tanto, serão oferecidos cursos de especialização, concessão de bolsas-formação, bem como será garantida contínua supervisão e acesso a recursos de suporte clínico, a exemplo do Telessaúde.

33. Para execução do Projeto Mais Médicos para o Brasil, além da atuação dos Ministérios da Saúde e da Educação, poderão ser celebrados termos de adesão e compromisso com Estados, Distrito Federal e Municípios, além de instrumentos de cooperação com outros países, organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, entidades públicas e privadas.

34. Nesse sentido, o Projeto Mais Médicos para o Brasil selecionará médicos para participarem do Projeto, garantindo-se a prioridade para a escolha de médicos formados em instituições de educação superior nacionais ou com diploma revalidado. Na hipótese de permanecerem vagas não preenchidas, estas serão ofertadas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *primeiramente a médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior e, posteriormente, a médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior, mediante chamamento público internacional ou celebração de instrumentos de cooperação com organismos internacionais.*
>
> *35. Deve-se advertir que, no caso de seleção de médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, o Estado respeitará as diretrizes estabelecidas no Código Global de Práticas para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS (2010), que reúne princípios éticos no sentido de reforçar os sistemas dos países em desenvolvimento, incluindo assuntos como a capacidade e a qualidade de formação de profissionais, as políticas de apoio à fixação de profissionais de saúde, a reciprocidade dos benefícios, a coleta e intercâmbio de informações, o monitoramento e a pesquisa no tema. Ao mesmo tempo, é importante considerar a qualidade da formação, conforme as medidas tomadas pela Arco-Sur."*

Vagas subsidiadas por bolsas. Ausência de cargo público. Modalidade ensino-serviço análoga à residência médica.

25. Nas informações n. 021/2013, a Advocacia-Geral da União assim resumiu o "*Programa* Mais Médicos" (gênero), no qual se insere o "*Projeto* Mais Médicos para o Brasil" (espécie):

> *"O Projeto 'Mais Médicos para o Brasil' é programa de capacitação desenvolvido na modalidade ensino-serviço (art. 8º), específico e exclusivo para a área de atenção básica em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde – SUS, ensejador do recebimento de bolsa ao médico participante (art. 13), sem que isso importe a formação de vínculo empregatício (art. 11)"* (fl. 6).

O "Programa Mais Médicos" busca *"formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde"* (art. 1º), atuando, reitere-se, em duas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

frentes, simultaneamente:

a) na implementação de faculdades de medicina:

"1.a) autorizando seu funcionamento, por meio de um chamamento público[4], em municípios estrategicamente pré-selecionados pelo Poder Executivo, segundo a *"relevância e a necessidade social da oferta de curso de medicina"* (art. 3º, § 1º, inc. I).

O edital do chamamento público observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (art. 3º, § 3º).

Para a pré-seleção dos municípios aptos à implementação de cursos privados de graduação em medicina, deverá ainda ainda ser considerada a infra estrutura local do Sistema Único de Saúde, a ser disponibilizada à faculdade vencedora do chamamento público, nos termos da adesão assinada com a Administração Pública e desde que adequada para a atenção básica, de urgência e emergência, psicossocial, ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância de saúde.

1.b) aprimoramento da formação médica (intensificação do internato médico com acompanhamento acadêmico, adequação da matriz curricular para atendimento do programa nos prazos e formas aprovadas pelo Ministério da Educação);

1.c) reordenação de oferta de cursos de medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões mais carentes (meta para que a oferta de vagas de residência médica seja equivalente ao de alunos egressos das faculdades de

4 Art. 3º, § 3º: *"O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993".*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

medicina, a ser alcançada até 31.12.2018);

1.d) criação de novos parâmetros para a formação médica,

1.e) integração ensino-serviço com supervisão acadêmica ao atendimento básico da população.

1.f) oferta de cursos de especialização aos médicos já formados e participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil – item abaixo – com atividades de ensino, pesquisa e extensão.

1.g) criação da figura do "tutor acadêmico", docente médico responsável pela orientação acadêmica dos futuros médicos participantes do Programa.

b) no atendimento básico da população (o que, no Programa Mais Médicos, foi denominado "*Projeto* Mais Médicos para o Brasil").

O "Projeto Mais Médicos para o Brasil" oferece vagas nas faculdades de medicina, na sistemática "ensino-serviço", para a formação e atuação dos denominados *"médicos participantes"*, na seguinte ordem de preferência:

"1º) médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

2º) médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

3º) médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior."

Nessa frente, o Programa inclui as seguintes medidas:

"2.a) adoção de intercâmbio internacional para a contratação de médicos;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> 2.b) contratação temporária, com o pagamento de bolsas e custos, de médicos para atuarem em áreas de maior carência no serviço
>
> 2.c) domiciliamento de médicos nas áreas do SUS de maior necessidade".

Essas vagas criadas nas faculdades de medicina seriam, assim, ocupadas pelos médicos participantes e remuneradas por bolsas nas seguintes modalidades (art[5]. 19 da Lei n. 12.871/2013)

> "a) bolsa-formação, para os médicos participantes submetidos aperfeiçoamento profissional supervisionado (art. 15, inc. I c/c art. 19, inc. I, da Lei n. 12.871/2013);
>
> b) bolsa-supervisão, para o profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do médico (art. 15, inc. II c/c art. 19, inc. II, da Lei n. 12.871/2013) e
>
> c) bolsa-tutoria, para o docente médico que será responsável pela orientação acadêmica (art. 15, inc. IIII c/c art.

5 Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber bolsas nas seguintes modalidades:

I - bolsa-formação;

II - bolsa-supervisão; e

III - bolsa-tutoria.

§ 1º Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação.

§ 2º É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde.

§ 3º Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

19, inc. III, da Lei n. 12.871/2013);".

Além das bolsas, a União *"concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação"* (art. 19, 1º, da Lei n. 12.871/2013).

Entre os médicos participantes, a Lei n. 12.871/2013 diferencia o chamado *"médico intercambista"*, classificado como *"o médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior"* (art[6]. 13, § 2º, inc. II).

Para este *"médico intercambista"*, o art[7]. 16 da Lei n. 12.871/2013, reserva o exercício da medicina, exclusivamente, *"no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão"*, ou seja, em atividade estritamente acadêmica, com remuneração por bolsas e ajudas de custo e concessão de *"visto temporário de aperfeiçoamento médico"*, pelo prazo de três anos, prorrogável por igual período

Daí a previsão do art. 17 da Lei n. 12.871/2013, segundo a qual, *"as atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza"*.

No sítio oficial, a dinâmica dos "serviços" do Projeto Mais Médicos está assim descrita:

---

6 *"§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:*

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior".

7 *"Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996".*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *"O programa trata de uma formação em serviço, não é vínculo de trabalho. Sendo assim, todos os médicos têm direito a um recesso anual remunerado de 30 dias, e, no caso do Mais Médicos, têm a contribuição previdenciária custeada pelo Ministério da Saúde, bem como moradia, alimentação e ajuda de custo. Todos os profissionais recebem bolsa-formação mensal líquida de R$ 10 mil, são supervisionados e cumprem 40 horas semanais no programa, sendo 32 horas de atuação nas unidades básicas de saúde e 8 horas dedicados a ações de educação na UBS ou em outros locais".*

26. Não se há de afirmar, portanto, afronta objetiva ao princípio do concurso público pois o "Programa Mais Médicos" não cria cargos públicos. Estabelece nova modalidade *"de capacitação na modalidade ensino-serviço"* (informação 021/2013 da AGU, fl. 6), com duração de três anos, prorrogáveis por mais três, análoga e paralela ao da especialização por Residência Médica[8], igualmente remunerada por bolsa, *"em regime especial de treinamento em serviço"* de 60 (sessenta) horas semanais.

É o que se tem na Lei Nacional n. 6.932/1981, que regulamenta a Residência Médica no País, alterada pelo art[9]. 34 da Lei n. 12.871/2013:

8 *"Instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o "padrão ouro" da especialização médica. O mesmo decreto criou a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)."* (Disponível em http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude/residencia-medica. Acesso em 25.8.2017)

9 Art. 34. O art. 1o da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3o, 4o e 5o:

"Art. 1o .....

.....

§ 3o A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil.

§ 4o As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 5o As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo deverão encaminhar,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

"Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.

(...)

§ 3º A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013)

(...)

§ 4º As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013) (Regulamento) (Regulamento)

§ 5º As instituições de que tratam os §§ 1º a 4º deste artigo deverão encaminhar, anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as ações de saúde pública. (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013) (Regulamento) (Regulamento)

(…)

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

§ 1º O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

§ 2º O médico-residente tem direito, conforme o caso, à licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

---

anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as ações de saúde pública." (NR)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *§ 3º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica poderá prorrogar, nos termos da Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, quando requerido pela médica-residente, o período de licença-maternidade em até 60 (sessenta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *§ 4º O tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento do médico-residente por motivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2º e 3º. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *II - alimentação; e (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *III - moradia, conforme estabelecido em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)*
>
> *§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual. (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)"*

No caso da Residência Médica, os candidatos a uma das sete mil[10] vagas ofertadas no país, submetem-se a um processo de seleção regulamentado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Atualmente, os médicos são submetidos a prova teórica, análise curricular e entrevista pessoal:

> *"Art. 2º - Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.*
>
> *Art. 3º - O médico residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de matrícula:*
>
> *a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;*
>
> *b) o nome da instituição responsável pelo programa;*

10 http://blog.imedicina.com.br/residencia-medica-como-funciona-essa-etapa-da-formacao/

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *c) a data de início e a prevista para o término da residência;*
>
> *d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa."*

27. No "Projeto Mais Médicos para o Brasil", a seleção se dá com a avaliação de títulos e da formação profissional dos candidatos, segundo tabela de pontuação previamente divulgada em edital de *"chamamento público de médicos"*.

Como exemplo, tem-se que o título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade expedido pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, ou Especialização em Saúde da Família Concluída Satisfatoriamente realizada pelo Sistema da Universidade Aberta do SUS (UNASUS) concedem vinte pontos ao candidato, ou ainda, a Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade devidamente concluída, outros quarenta. Os editais preveem, ainda, critérios de preferência e desempate:

> *" A concorrência se dará dentro de cada opção de Município pelos candidatos, só havendo concorrência em opção de prioridade posterior, caso haja vagas remanescentes.*
>
> *8.1.4. Caso o candidato alocado não exerça seu direito à participação no Programa, o candidato classificado posteriormente na ordem de pontuação não tem direito imediato à vaga, uma vez que a concorrência se dá nos termos do subitem 8.1.3.1.*
>
> *8.1.5. Em caso de empate na pontuação, será considerado o seguinte critério de desempate:*
>
> *8.1.5.1. maior idade, considerados o dia, mês e ano de nascimento; permanecendo o empate será considerado a data e horário da realização da inscrição."*[11]

<u>*Exigência de conhecimento de língua Portuguesa*</u>

11 EDITAL Nº 03, DE 19 DE ABRIL DE 2017 ADESÃO DE MÉDICOS AO PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (http://189.28.128.100/maismedicos/Edital-3_Adesao-de-Medicos-ao-MAIS-MEDICOS_publicado.pdf).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

28. Não houve também ofensa pela Lei n. 12.872/2013 ao art. 13 da Constituição, o qual estabelece a língua portuguesa como o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Isso porque o art. 15, § 1º, do diploma legal impugnado lista a existência de conhecimento em língua portuguesa como condição para a participação do médico intercambista estrangeiro no Projeto Mais Médicos para o Brasil. Ademais, ao tratar do primeiro módulo do curso de especialização de que participam esses profissionais, denominado "acolhimento", o § 3º do art. 14 estabeleceu a língua portuguesa como um dos conteúdos lecionados. Essas providências mostram-se suficientes para garantir a observância ao art. 13 da Constituição pelo Projeto Mais Médicos para o Brasil.

29. Como demonstrado pela Presidência da República, não se há cogitar de indevida dispensa de conhecimento da língua portuguesa para o exercício das atividades previstas no projeto, pois *"a avaliação prévia dos médicos intercambistas é feita durante o módulo de acolhimento e avaliação, em que se inclui a aferição de conhecimentos em língua portuguesa, como se depreende do art. 16 da Portaria Interministerial MS-MEC n. 1.369, de 2013. Da aprovação nesse módulo não decorre, todavia, a autorização para exercício indiscriminado da medicina no país, como ocorreria se houvesse obrigatória submissão ao processo tradicional de revalidação de diplomas"*.

Ausência de ofensa ao princípio da isonomia e ao direito à saúde

30. Também não se há acolher a alegação de ofensa ao princípio da isonomia. Esse preceito, em sua dimensão material, impõe seja conferido tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais.

Um dos objetivos principais da Lei n. 12.871/2013 é garantir maior acesso ao sistema de saúde pública às populações de regiões historicamente privadas desse serviço em razão do reduzido número de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

médicos. Isso se extrai do art. 1º, inc. I, do diploma legal impugnado, que elenca, entre os objetivos do programa, a diminuição da "*carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde*".

Na mesma linha, o art. 2º determina que, para a consecução dos objetivos do programa, deve haver reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, de forma a priorizar "*regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante (…)*".

A circunstância de as ações e serviços de saúde da Lei n. 12.871/2013 serem prestadas por médicos formados no exterior sem revalidação do diploma de ensino superior não importa ofensa ao princípio da igualdade ou ao direito fundamental à saúde, especialmente se considerado que o programa impugnado busca justamente suprir a falta de médicos habilitados em determinadas regiões do país.

Assim, longe de ofender o princípio da isonomia ou o direito à saúde, a Lei n. 12.871/2013 buscou dar-lhes concretude, reduzindo as desigualdades regionais no acesso ao sistema único de saúde.

Respeito à autonomia universitária e ausência de imposição de serviço civil obrigatório

31. O Capítulo III da Lei n. 12.871/2013 trata da formação médica no Brasil, veiculando disposições pertinentes aos cursos de medicina e aos programas de residência médica. Em seu art. 4º, o diploma legal questionado sujeita o funcionamento dos cursos de Medicina à implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

No § 1º daquele dispositivo, põe-se que ao menos trinta por cento da carga horária do internato médico na graduação deve se dar na Atenção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de dois anos de internato.

Ao dispor do Projeto Mais Médicos para o Brasil, o art. 14 da Lei n. 12.871/2013 cuida do aperfeiçoamento dos médicos participantes "*mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração ensino-serviço*".

32. O art. 207 da Constituição da República conferiu às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Sobre esses diversos aspectos da autonomia universitária, sustentou o Ministro Celso de Mello:

> *"A autonomia de que gozam as universidades projeta-se, no que concerne ao seu conteúdo material, em três dimensões, a saber:*
>
> *a) autonomia didático-científica, de caráter principal, que confere à universidade, sob a égide do pluralismo de ideias, o direito à liberdade de ensino e de comunicação do pensamento. Essa expressão de autonomia universitária transforma a universidade no locus, no espaço social privilegiado da liberdade e é, em torno dela, que se desenvolvem os demais aspectos. As autonomias de natureza administrativa e financeira ostentam caráter acessório ou instrumental, em face daquela de ordem didático-científica, que apenas buscam complementar. Por isso mesmo, adverte o eminente CAIO TÁCITO (v. Parecer, in RDA, vol. 136/263-268, 265), 'na autonomia universitária o que está em causa é o princípio mais alto da liberdade do ensino, que é uma das facetas da liberdade de expressão do pensamento'. E prossegue: 'A liberdade de comunicação de conhecimentos no exercício do magistério (…) é o fulcro da autonomia didático-científica das Universidades …';*
>
> *b) autonomia administrativa, de caráter acessório, que assegura à universidade, sempre em função de seu tríplice objetivo institucional, capacidade decisória para, de um lado, administrar os seus serviços, agindo e resolvendo interna corporis os assuntos de sua*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *própria competência, e, de outro, disciplinar as suas relações com os corpos docente, discente e administrativo que a integram;*
>
> *c) autonomia financeira, de caráter instrumental, que outorga à universidade o direito de gerir e aplicar os seus próprios bens e recursos, em função de objetivos didáticos, científicos e culturais já programados. Esse aspecto da autonomia universitária não tem o condão de exonerar a universidade dos sistemas de controle interno e externo. O Pretório Excelso, ao julgar essa questão, decidiu, pertinentemente ao tema da autonomia universitária, que 'o controle financeiro se faz a posteriori, através da tomada de contas e das inspeções contábeis' (v. RTJ, vol. 94/1130)" (voto do Ministro Celso de Mello na ADI 51, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 17.9.1993).*

É de se ponderar, entretanto, que a autonomia universitária não é ilimitada, não obstando que a União edite diretrizes gerais sobre temas afetos ao ensino superior, no exercício da competência legislativa privativa estabelecida pelo art. 22, XXIV, da Constituição[12].

É o que estabelece, por exemplo, o art. 53, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao assegurar às universidades, no exercício de sua autonomia, a definição do currículo de seus cursos e programas, desde que "*observadas as diretrizes gerais pertinentes*".

Cabe ao Estado, ademais, garantir padrão de qualidade das instituições de ensino, inclusive as universidades, não podendo ficar impedida de legislar sobre a matéria pela autonomia universitária.

Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos sustenta que "*a autonomia didática indica a liberdade da universidade para escolher o método pedagógico que achar mais adequado, ou seja, a forma mais conveniente de transmitir o ensino, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei*" (BASTOS, Celso Ribeiro. *Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de*

12 "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (…) XXIV - diretrizes e bases da educação nacional".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

1988. Vol. VIII. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 547).

Cite-se, nessa mesma linha de pensamento, lições de Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Pinto Ferreira:

> *"Autonomia. O termo evidentemente não é empregado no seu sentido etimológico, greco, de 'independência', mas sim no de autodeterminação dentro de limites traçados por norma superior. É a lição de Mortati (Instituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1967, v. 2, p. 694): 'Poder de autodeterminação exercitável de modo independente mas nos limites consentidos pela lei estatal superior'.*
>
> *Claro está, portanto, que é a lei, no caso a lei de 'diretrizes e base da educação nacional' (v., supra, art. 22, XXIV), que vai definir a extensão desse poder de autodeterminação. Entretanto, não poderá negá-la, numa medida mínima que seja, quanto às matérias anunciadas neste artigo: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial" (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990-1995. p. 72).*

> *"O conceito de autonomia universitária (…) deve ser entendido em um sentido amplo, que não significa soberania dos reitores e dos órgãos de administração e finanças, corporificados em instituições que, entre nós, se chamam de conselho universitário e de conselho de curadores. A autonomia universitária é uma autonomia relativa, condicionada à legislação editada pelo Estado e à sua tarefa de inspeção, bem como limitada pelas estruturas internas da organização da universidade em unidades específicas de ensino e de pesquisa e do respeito à liberdade acadêmica" (FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 117-118).*

33. Esse entendimento também é refletido na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Relevante destacar alerta do Ministro Paulo Brossard no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 51 (Tribunal Pleno, DJ 17.9.1993), no sentido de que a autonomia universitária, por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

mais larga que seja, não significa independência das universidades em relação à Administração Pública ou soberania em relação ao Estado, não as escusando do cumprimento das leis editadas em conformidade com a Constituição:

> *"A autonomia, é de evidência solar, não coloca a Universidade em posição superior à lei. Fora assim e a Universidade não seria autônoma, seria soberana. E no território nacional haveria manchas nas quais a lei não incidiria, porque afastada pela autonomia.*
>
> *(…)*
>
> *12. Mas, independente disto, a autonomia não significa, nem pode significar que a Universidade se transforme em uma entidade solta no espaço, sem relações com a administração. Bastaria lembrar que à União compete legislar sobre diretrizes e bases da educação e a essa disciplina não é alheio o ensino superior, ou lembrar que, se a Universidade pode ter recursos próprios, a maior parte de sua despesa é custeada pelo erário.*
>
> *(…)*
>
> *É preciso ter presente esse dado elementar e, não obstante, fundamental. A Universidade não deixa de integrar a administração pública, e o fato de ela gozar de autonomia, didática, administrativa, disciplinar, financeira, não faz dela um órgão soberano, acima das leis e independente da República" (ADI 51, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 17.9.1993).*

No mesmo sentido, por exemplo os seguentes precedentes:

> *"Curso de mestrado. Expedição de diploma pela Universidade com validade nacional. Curso autorizado, mas não reconhecido. Lei nº 9.394/96, art. 48. Autonomia administrativa da Universidade. Submissão à normas gerais da educação nacional.*
>
> *1. Não há direito líquido e certo à expedição de diploma com validade nacional se o curso de mestrado não é reconhecido, como expressamente prevê a lei.*
>
> *2. As universidades gozam de autonomia administrativa, o que não as exime do dever de cumprir as normas gerais da educação nacional.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *3. Recurso extraordinário a que se nega provimento". (RE 566.365, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2011)*
>
> *"AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM DOIS CURSOS SIMULTÂNEOS COM COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RESOLUÇÃO EDITADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO SENTIDO DA PROIBIÇÃO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.*
>
> *Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos.*
>
> *Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.*
>
> *Agravo regimental a que se nega provimento". (RE 553.065-AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.7.2009)*

E ainda: RMS 22.047-AgR, Relator Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 31.3.2006.

34. Na espécie, os dispositivos impugnados não ofenderam a autonomia universitária, limitando-se a fixar diretrizes curriculares a serem observadas pelos cursos de medicina em geral, no exercício da competência legislativa privativa da União prevista no inciso XXIV do art. 22 da Constituição da República. Diretrizes essas que consistem: *a)* na sujeição à efetiva implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 53, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação); *b)* na determinação de que ao menos trinta por cento do internato médico na graduação seja desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS; *c)* na previsão de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

possibilidade de oferta de curso de especialização para o aperfeiçoamento de médicos no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Registre-se que a determinação de que ao menos trinta por cento do internato médico na graduação seja desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS não representa imposição de serviço civil obrigatório ou de trabalhos forçados aos aluno de medicina, como alega a Autora.

Cuida-se de legítima diretriz curricular estabelecida pela lei com a finalidade de dar cumprimento a um dos principais objetivos do Programa Mais Médicos, qual seja, "*fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País*" (art. 1º, inc. II, da Lei n. 12.871/2013).

35. Como apontado pela Procuradoria-Geral da República *"não compete ao Supremo Tribunal Federal discutir o acerto ou desacerto da política pública implementada pelo Estado, cabendo-lhe apenas controlar a ação ou omissão do Poder Público que contrariar os comandos constitucionais, conforme reflexão do Ministro Celso de Mello na decisão que proferiu na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45"*:

> *"[…] não posso deixar de reconhecer que a ação constitucional em referência, considerado o contexto em exame, qualifica-se como instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta Política, tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria Constituição da República.*
>
> *Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais – que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

> *Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional: […]*
>
> *É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de implementar políticas públicas […], pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.*
>
> *Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.*
>
> *Cabe assinalar, presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"* (decisão monocrática do Ministro Celso de Melo na ADPF n. 45, de sua relatoria, DJ 4.5.2004).

36. Pelo exposto, conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, **julgo improcedentes** os pedidos nela apresentados.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14816052.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.035
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S) : MARCO AURELIO DE SOUZA (0193035/SP) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JR (271636/SP) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LUIZ HENRIQUE PRESCENDO (242377/SP)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADV.(A/S) : JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA (00013792/DF)

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Rosa Weber, julgou improcedente a ação. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski, e, neste julgamento, os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Falaram, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União, e, pelo *amicus curiae* Conselho Federal de Medicina, o Dr. José Alejandro Bullón. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.11.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14202534